

國立屏東大學教育心理與輔導學系

碩士論文

指導教授：張麗麗 博士



護理人員工作壓力與離職意圖關係中工作滿意度及
組織承諾之序列中介效果探討

研究生：梁明慧撰

中華民國 111 年 07 月 14 日

國立屏東大學教育心理與輔導學系

碩士論文

研究生：梁明慧

護理人員工作壓力與離職意圖關係中工作滿意度及

組織承諾之序列中介效果探討

本論文經審查及口試合格特此證明

論文考試委員會主席

劉芬芳

委員

劉芬芳

委員

羅素貞

指導教授：張麗麗 博士

張麗麗

系主任：張麗麗 博士

張麗麗

中華民國 111 年 07 月 14 日

謝 誌

曾經有朝一日能夠就讀心輔系碩班是我夢想清單中的一個項目，總是在工作和生活中給自己忙碌的藉口而擱在一旁，如今當初的有朝一日已成了實踐完成的項目，花了兩年從一開始茫然無知播種，期間不斷學習和修正如何孕育，到現在終於嚐到了論文果實，這滋味苦澀但是帶著回味的甘甜。

回首這歷程，自己能夠順利完成，要感謝的人真的很多，不論是當初找我一起就讀研究所，讓我有動力化夢想為實際行動，踏上研究所旅程的摯友，還是多方支持、鼓勵和協助我的院區主管、體系護理總顧問、體系各院區護理主管、工作同事們，以及同樣有著多重身份和角色在課堂中相遇，互相砥礪、互吐苦水、經驗分享交流、相互給予情緒支持的每位同學們，當然還有我的指導教授 張麗麗博士，每次當自己的能量被論文寫作所消耗，快要迷失方向時，只要去找麗麗老師做過討論後，內心想做研究的熱情就會再度被燃起，並找回自己做研究的初衷和繼續堅持下去，除了麗麗老師，也很感謝論文口試委員羅素貞老師和劉芹芳老師在口試過程中，給了許多寶貴的建議和提醒，讓我可以把論文中較匱乏不足的部分做修正和補足，有更好的論文成果得以呈現，最後，要感謝我的父母，即便他們心裡會擔心我以在職還要兼顧家庭的情況下繼續進修，身體會吃不消也無法多方兼顧，仍然尊重我的選擇和支持我追夢的決定，還有我的先生，謝謝他總是沒有怨言的幫忙分擔我無法兼顧的部分，全力支持我的每個決定和陪伴，還有已經進入青少年時期卻沒讓我操心，還會用理性化語激勵著我的寶貝女兒。

衷心感謝這兩年在職進修和論文寫作過程中在我身邊的每一個你們，因為有你們讓我感到自己是幸運且幸福的，而心懷感激，我也要謝謝沒有輕言放棄，今天才能有機會在這裡寫謝誌內容的自己。

梁明慧 謹誌

111 年 7 月

中文摘要

護理人員短缺影響層面甚廣，包括了整體醫療照護品質與病人安全以及醫院的人事成本，在相關研究中，護理人員工作壓力、工作滿意度、組織承諾等變項與離職意圖有顯著相關，由於文獻中較少同時探討四個變項間的路徑關係（工作滿意度及組織承諾是否為護理人員工作壓力及離職意圖之序列中介變項），故本研究以台灣某醫療體系在北、中、南區的各家地區醫院護理人員為對象，採取方便取樣的方式，發放問卷 378 份，回收後的有效問卷共計 328 份。研究使用的研究工具為「工作壓力（工作負荷—控制—支持）分量表」、「工作滿意度量表」、「組織承諾量表」、「離職意圖量表」，統計方法採用描述性統計、多變量及單變量變異數分析、皮爾森積差相關、階層回歸及路徑分析等方法，研究結果如下：

- 一、地區型醫療機構中護理人員在「工作負荷—控制—支持」理論之工作壓力面向，知覺社會支持的程度高過知覺工作負荷及工作控制的程度；在「激勵—保健」理論之工作滿意面向，「人際互動與合作」和「主管的領導風格」保健因子的滿意度較高，「支持性執業環境」保健因子最低；組織承諾面向以「情感性」承諾較高，其次為「持續性」承諾和「規範性」承諾；離職意圖則屬中度偏低，離開目前任職醫院的意圖不強烈。
 - 二、在「工作負荷—控制—支持」理論之工作壓力面向，不同性別、年齡及目前任職醫院護理年資者有差異；在「激勵—保健」理論之工作滿意面向，不同服務單位者有差異；在組織承諾面向，不同年齡、婚姻狀況者有差異；在離職意圖方面，不同年齡、婚姻狀況及目前任職醫院護理年資者有差異。
 - 三、工作壓力（工作負荷—控制—支持）量表中「工作控制、主管支持、同事支持」與工作滿意度量表及組織承諾量表呈正相關，與離職意圖呈負相關，而「工作負荷」與工作滿意度量表及組織承諾量表呈負相關，與離職意圖呈正相關；工作滿意度量表與組織承諾量表呈正相關，與離職意圖呈負相關；離職意圖量表與組織承諾量表呈負相關。
 - 四、以護理人員之一般背景、工作壓力（工作負荷—控制—支持）、工作滿意度及組織承諾等四組變項依序進入迴歸模型，對護理人員的離職意圖進行解釋，共可解釋 51.2% 的變異，達統計上顯著，在不同階層模型中，年齡、服務單位、工作負荷壓力、情感性及持續性承諾對離職意圖的獨特解釋力都達顯著。
 - 五、工作壓力（工作負荷—控制—支持）主要均是透過先影響工作滿意度，接著再影響組織承諾的序列性間接中介效果路徑影響離職意圖。
- 關鍵字：護理人員、工作壓力、工作滿意度、組織承諾、離職意圖。

Abstract

Nursing staff shortage and turnover have a broad impact, including medical care quality, patient safety, and hospital personnel costs. Variables such as work stress, job satisfaction, and organizational commitment of nurses are significantly related to turnover intentions. Since the research rarely discusses the path relationship between the four simultaneously, especially whether job satisfaction and organizational commitment acted as serial mediating variables in the relationship between work stress and turnover intention. Data were collected from the nursing staff of the regional hospitals in a medical system's northern, central, and southern districts in Taiwan using a convenience sampling procedure. A total of 378 questionnaires were distributed, and 328 valid questionnaires were returned. This study used the Job Content Questionnaire, Taiwanese Hospital Nurses' Job Satisfaction Scale, Three-Component Model (TCM) Employee Commitment Survey, and Turnover Intention Scale. Descriptive statistics, MANOVA, ANOVA, Pearson product-moment correlation, Hierarchical regression, and path analysis were used in the data analysis. The results are shown below:

1. Nurses in district medical institutions have higher perceived social support than perceived job demand and job control in the aspect of work stress of the "Job Demand-Control-support" theory; In the job satisfaction aspect of the "motivation-hygiene" theory, the satisfaction of the hygiene factors of "interpersonal interaction and collaboration" and "leadership style" is higher, and the hygiene factor of "supportive working environment" is the lowest; In the organizational commitment aspect, "affective" commitment is the highest, followed by "continuance" commitment and "normative" commitment; The turnover intention is moderately low, and the intention to leave the current hospital is not strong.
2. In the aspect of work stress in the "Job Demand-Control-support" theory, there are gender, age, and nursing seniority differences; in the aspect of job satisfaction in the theory of "motivation-hygiene," there are "service unit" differences; in the aspect of organization commitment, there are age and marital status differences; in the turnover intention aspect, there are age, marital status, and nursing seniority differences.
3. In the work stress (Job Demand-Control-Support) scale, job control, supervisor support, and coworker support were positively correlated with the job satisfaction and organizational commitment, and negatively correlated with turnover intention; however, job demand was negatively correlated with job satisfaction and organizational commitment, and positively correlated with turnover intention; job satisfaction was

positively correlated with organizational commitment, and negatively correlated with turnover intention; the turnover intention was negatively correlated with organizational commitment.

4. Four sets of variables, including the general background of nurses, work stress (Job Demand-Control-Support) , job satisfaction, and organizational commitment, were entered into the hierarchical regression model in order to explain the nurses turnover intention, and a total of 51.2% variation could be explained, the variation is statistically significant. Regarding the individual variables, age, service unit, job demand, affective and continuance commitment have significant unique effects on turnover intentions.
5. Work stress (Job Demand-Control-Support) mainly affects turnover intention through a serial indirect mediating effect path that first affects job satisfaction and then affects organizational commitment.

Keywords: nurse, work stress, job satisfaction, organization commitment, turnover intention

目 錄

謝誌.....	i
摘要.....	ii
Abstract	iii
目錄	v
表次	vii
圖次	ix
第一章 緒論	1
第一節 研究背景與動機	1
第二節 研究目的	3
第三節 研究問題	3
第四節 名詞釋義	4
第二章 文獻探討	6
第一節 工作壓力	6
第二節 工作滿意度	14
第三節 組織承諾	18
第四節 離職意圖	22
第五節 工作壓力、工作滿意度、組織承諾與離職意圖之相關性	28
第三章 研究方法	31
第一節 研究架構及研究假設	31
第二節 研究對象	32
第三節 研究工具	34
第四節 研究程序	37
第五節 資料處理與分析	37
第四章 研究結果	39
第一節 護理人員在工作壓力、工作滿意度、組織承諾與離職意圖之現況分析	39
第二節 不同背景之護理人員在工作壓力、工作滿意度、組織承諾與離職意圖上的差異性分析	46
第三節 護理人員工作壓力、工作滿意度、組織承諾與離職意圖之相關分析....	62
第四節 護理人員背景變項、工作壓力、工作滿意度和組織承諾對離職意圖之迴歸分析	66
第五節 工作壓力與離職意圖關係中工作滿意度及組織承諾之序列中介模型分析	70
第五章 研究結論、討論與建議	84
第一節 研究結論	84
第二節 討論	86

第三節 建議	88
參考文獻	90
附錄	103
附錄一 護理人員工作壓力、工作滿意度、組織承諾與離職意圖問卷	103
附錄二 問卷授權同意書	109

表 次

表 3-1	某醫療體系所屬之北、中、南區地區醫院數目及發放問卷和回收問卷數	..33
表 3-2	研究對象之背景變項的次數分配表	33
表 3-3	研究對象之背景變項（年齡及目前任職醫院的護理年資）的統計資料	34
表 3-4	研究對象之背景變項（年齡及目前任職醫院的護理年資）的次數分配表	34
表 4-1	護理人員在工作壓力各分量表及試題上的平均數與標準差	40
表 4-2	護理人員在工作滿意度各分量表及試題上的平均數與標準差	42
表 4-3	護理人員在組織承諾各分量表及試題上的平均數與標準差	44
表 4-4	護理人員在離職意圖試題上的平均數與標準差	45
表 4-5	不同性別之護理人員在工作壓力各分量表的平均數與標準差	47
表 4-6	不同性別之護理人員在工作壓力上的單因子變異數分析摘要表	47
表 4-7	不同年齡之護理人員在工作壓力各分量表的平均數與標準差	48
表 4-8	不同年齡之護理人員在工作壓力上的單因子變異數分析摘要表	48
表 4-9	不同教育程度之護理人員在工作壓力各分量表的平均數與標準差	48
表 4-10	不同婚姻狀況之護理人員在工作壓力各分量表的平均數與標準差	49
表 4-11	目前任職醫院不同護理年資之護理人員在工作壓力各分量表的平均數與標準差	49
表 4-12	目前任職醫院不同護理年資之護理人員在工作壓力上的單因子變異數分析摘要表	50
表 4-13	不同服務單位之護理人員在工作壓力各分量表的平均數與標準差	50
表 4-14	不同性別之護理人員在工作滿意度各分量表的平均數與標準差	51
表 4-15	不同年齡之護理人員在工作滿意度各分量表的平均數與標準差	51
表 4-16	不同教育程度之護理人員在工作滿意度各分量表的平均數與標準差	52
表 4-17	不同婚姻狀況之護理人員在工作滿意度各分量表的平均數與標準差	52
表 4-18	目前任職醫院不同護理年資之護理人員在工作滿意度各分量表的平均數與標準差	53
表 4-19	不同服務單位之護理人員在工作滿意度各分量表的平均數與標準差	53
表 4-20	不同服務單位之護理人員在工作滿意度上的單因子變異數分析摘要表	54
表 4-21	不同性別之護理人員在組織承諾各分量表的平均數與標準差	54
表 4-22	不同年齡之護理人員在組織承諾各分量表的平均數與標準差	55
表 4-23	不同年齡之護理人員在組織承諾上的單因子變異數分析摘要表	55
表 4-24	不同教育程度之護理人員在組織承諾各分量表的平均數與標準差	56

表 4-25 不同婚姻狀況之護理人員在組織承諾各分量表的平均數與標準差	56
表 4-26 不同婚姻狀況之護理人員在組織承諾上的單因子變異數分析摘要表	56
表 4-27 目前任職醫院不同護理年資之護理人員在組織承諾各分量表的平均數與標準差	57
表 4-28 不同服務單位之護理人員在組織承諾各分量表的平均數與標準差	57
表 4-29 不同性別之護理人員在離職意圖量表的平均數與標準差	58
表 4-30 不同年齡之護理人員在離職意圖量表的平均數與標準差	58
表 4-31 不同年齡狀況之護理人員在離職意圖上的單因子變異數分析摘要	58
表 4-32 不同教育程度之護理人員在離職意圖量表的平均數與標準差	59
表 4-33 不同婚姻狀況之護理人員在離職意圖量表的平均數與標準差	59
表 4-34 不同婚姻狀況之護理人員在離職意圖上的單因子變異數分析摘要表	59
表 4-35 目前任職醫院不同護理年資之護理人員在離職意圖量表的平均數與標準差	59
表 4-36 目前任職醫院不同護理年資之護理人員在離職意圖上的單因子變異數分析摘要表	60
表 4-37 不同服務單位之護理人員在離職異圖各分量表的平均數與標準差	60
表 4-38 不同背景之護理人員在工作壓力、工作滿意度、組織承諾、離職意圖上的差異性分析表	61
表 4-39 工作壓力、工作滿意度、組織承諾與離職意圖分量表之相關摘要表	63
表 4-40 一般背景變項、工作壓力、工作滿意度、組織承諾對離職意圖之迴歸預測	68
表 4-41 一般背景、工作壓力、工作滿意度、組織承諾對離職意圖之迴歸係數考驗	69
表 4-42 工作壓力、工作滿意度、組織承諾與離職意圖分量表合併後之相關摘要表	71
表 4-43 「工作滿意－專業自主與發展」與組織承諾為「工作壓力－工作控制」與離職意圖之序列中介模型－直接及間接效果（依變項為離職意圖）	74
表 4-44 「工作滿意－執業環境與護理負荷」與組織承諾為「工作壓力－工作負荷」與離職意圖之序列中介模型－直接及間接效果（依變項為離職意圖）	78
表 4-45 「工作滿意－人際互動與主管領導」與組織承諾為「工作壓力－社會支持（主管和同事）」與離職意圖之序列中介模型－直接及間接效果（依變項為離職意圖）	81

圖 次

圖 2-1	心理需求/負荷-決策自由度模型	10
圖 2-2	Mobley 員工離職決策過程模式	24
圖 2-3	Bluedorn 綜合離職模式	25
圖 2-4	工作壓力、工作滿意度與離職意圖關係模式	29
圖 2-5	工作壓力、組織承諾與離職意圖關係模式	30
圖 2-6	工作壓力、工作滿意度、組織承諾與離職意圖關係圖	30
圖 3-1	研究架構圖	31
圖 4-1	工作壓力與離職意圖關係中工作滿意度及組織承諾之序列中介模型	72
圖 4-2	「工作滿意－專業自主與發展」與組織承諾為「工作壓力－工作控制」與離職意圖之序列中介假設模型	73
圖 4-3	「工作滿意－執業環境與護理負荷」與組織承諾為「工作壓力－工作負荷」與離職意圖之序列中介假設模型	76
圖 4-4	「工作滿意－人際互動與主管領導」與組織承諾為「工作壓力－社會支持(主管和同事)」與離職意圖之序列中介假設模型	79

第一章 緒論

本研究主要在探討護理人員的工作壓力、工作滿意度、組織承諾與離職意圖之現況及關係。本章共分為四節，第一節闡述說明研究背景與動機，第二節說明研究目的，第三節提出研究問題，第四節針對重要名詞釋義，以下依序分別論述說明。

第一節 研究背景與動機

護理人員短缺是現今全球所關注的一個重大議題，由於預期壽命延長和許多國家患有慢性病的人越來越多，加上 COVID-19 疫情影響，短缺問題更加嚴重，使得護理短缺將日益惡化。我國自民國 84 年 3 月實施全民健康保險，推出各種醫療保險支付制度及相關政策，同時國民年所得提升，國民對於醫療照護的需求及品質要求也日益重視，醫療生態面臨衝擊及劇變，而護理專業領域亦受到相當程度的衝擊。護理人力需求，隨著人口高齡與老化、民眾對醫療品質的期待和要求日益高漲、執業環境及法規規範影響下，不減反增，面臨前所未有的挑戰。國際護理協會(International Council of Nurses, ICN) 調查指出，台灣護理人員執業年限，與歐美國家平均 20 年的執業年限差距甚遠，根據中華民國護理師護士公會全國聯合會 109 年護理人力監測指標資料所示，執業會員平均護理工作年資(109 年)為 13 年。根據衛生福利部全國醫療資訊網台閩地區護理人員統計資料(110 年 6 月)所示，護理人員執登人數：179,441 人，領證人數(以最大證書計)：302,453 人，執業率 59.3%。

護理人員離職的相關文獻顯示，張靖梅和林獻鋒(2021)護理人員的短缺、高流動率，會導致護理人員離職意圖提高，因而影響整體醫療服務品質與病人安全；護理人力與病人安全，例如病人死亡率、給藥錯誤率、院內感染率、病人跌倒率、急救成功率...等有關。當護理人員人力不足時，會使人為醫療疏失和醫療失誤頻率增加，甚至危及病人生命安全。Dilig-Ruiz 等人(2018)護理人員的充足人力配置對於提供高品質的病人護理和改善病人預後至關重要，加拿大對 41 家醫院的 182 個單位進行的一項大型泛加拿大研究發現，平均每年護理人員離職率為 19.9%，但重症單位的離職率最高 26.7%，高離職率與高工作量和患者護理品質差相關；除了護理人員和病人的負面結果外，護理人員離職也帶來了巨大的成本，例如，對四個國家 65 家醫院的跨國比較審查中，護理人員離職(更換每個 RN)相關的支出費用(標準化為美元)從 20,561 美元(美國)到 48,790 美元(澳大利亞)不等。護理人力短缺影響層面甚廣，包括了整體醫療照護品質與病人安全以及醫院的人事成本，因此，了解造成護理人力短缺的原因和研擬解決措施，是各國所重視和探討的議題，在相關研究中，工作壓力、工作滿意度、組織承諾等變項與離職意圖有顯著相關(林素鈺等人, 2020; 張靖梅和林獻鋒, 2021; 張翠芬等人, 2016; 陳銘薰和黃新龍, 2019; 蔡月英等人, 2020; Clugstone, 2000; De Gieter et al., 2011; Husnah 和 Hasyim, 2020; Labrague, et al., 2020;

Luz et al., 2018 ; Rindu et al., 2020 ; Sari et al., 2021)。高鳳霞和鄭伯璦 (2014) 根據統計資料顯示，工作壓力產生的不良影響，包括離職、缺勤、低生產、醫療、法律及保險支出等，每年花費美國企業超過 3000 億美元的成本。此外，工作壓力對護理人員心理健康造成的影響已不容忽視，如：失眠、焦慮症與憂鬱症等，這些心理健康的危險因子，對有接觸 COVID-19 確診或是疑似個案的第一線護理人員之影響更是加劇，工作壓力越大，身心健康越差 (楊麗清，2016；黃毓華等人，2015；羅文惠，2020)。

2019 年底新型冠狀病毒疾病 (COVID-19) 在全球爆發，執業護理師在疫情期間須面臨被傳染的風險、染疫後傳染給親友同事、防護裝備是否完善的擔憂，及滾動式感控政策的修改、工時延長、新興疾病持續的時間不明等衝擊，造成工作壓力和心理負荷的增加 (馮明珠等人，2020；羅文惠，2020)，護理人員身處臨床的第一線，護理人力的不足、執業環境的潛在危害 (新興傳染病、放射線、暴力) 以及病人照護上所承擔的心理和身體上的負荷，均是構成護理人員工作壓力的主要來源，護理人員的工作壓力源可歸類成為五大構面：1.行政管理、2.工作環境、3.人際關係、4.病人照護、5.專業知識及技術 (黃玉琳，2019)。工作壓力也因個人背景而不同，性別、年齡、教育程度、婚姻狀態、服務年資、服務單位類別等是護理人員壓力研究中常被探討的背景變項，故本研究將探討護理人員壓力現況，以及壓力是否因個人背景因素而有不同。

護理人員所面臨的工作壓力越大，離職意圖越高 (Rindu et al., 2020)。對一個企業和組織而言，員工的離職率 (turnover rate) 過高代表著人事成本的負擔也會隨之而增加，因此，管理上一直相當的重視員工的離職行為，有許多的研究對員工的離職過程 (turnover process) 進行了深入的探究與討論。離職意圖 (turnover intention) 是離職行為在實際真正發生前，最主要的認知前兆 (cognitive precursor)，員工的離職意圖最能對其離職發生的可能性作相關解釋，而工作滿意度 (job satisfaction) 與組織承諾 (organization commitment) 是員工產生離職意圖時，兩個相當重要的影響前因，根據文獻研究結果所示，黃穗芬 (2011) 護理人員工作壓力並不是影響離職傾向主要因素，工作滿意度和組織承諾才是重要因素。工作滿意度越高，組織承諾越高；工作滿意度越高，離職意圖越低；組織承諾越高，離職意圖越低；工作壓力大、工作滿意度低時，則離職意圖愈顯增高 (張靖梅和林獻鋒，2021；張翠芬等人，2016；Sari et al., 2021)。當護理人員有高組織承諾時，會有較高的工作效率與工作投入，因而減少護理人員的曠職與降低離職意願、工作疲勞感 (林素鈺等人，2020；張靖梅、林獻鋒，2021；蔡坤宏，2000；Luz et al., 2018)。故本研究要探討護理人員的工作壓力、工作滿意度、組織承諾與離職意圖的關係。陳欣妤 (2021) 對國小專任輔導教師的研究發現，工作壓力有可能部分是透過工作滿意度來影響離職意圖，Jou 等人 (2013) 對航空控制人員和 Ferdian 等人 (2020) 對印尼的一間私人公司員工的研究發現，工作滿意度對工作壓力來源與離職傾向的關係具有中介作用。陳銘薰和黃新龍 (2019) 對現任國軍幹部 and Dewi 和 Piartrini (2021) 對民營醫院員工的研究結果發現，組織承諾會中介工作壓力與離職傾向之間的關係。由於文獻中較少同時探討四個變項間的路徑關係，工作

滿意度及組織承諾是否為護理人員工作壓力及離職意圖之序列中介變項，且被研究的醫院屬性，大多以醫學中心和區域醫院為主，較少對地區醫院做相關研究，地區醫院是醫院層級中規模最小的醫療單位，肩負社區民眾健康照護守門員的角色，提供社區民眾具可近性的預防醫療保健、急慢性醫療照護，全民健康保險的開辦造成醫療生態的改變，地區醫院受限於規模和設備上的劣勢，經營維持不易，在設置標準和成本考量下，地區醫院護理人力配置較少、護病比例較高，也因人力受限，造成護理人員工作分工較不清楚，除了護理專業外還需身兼數職形成工作負荷和壓力的狀況(張曉立，2021；黃鴻茗和宋鎮照，2013)，故本研究將以地區醫院護理人員為對象，探討工作壓力、工作滿意度、組織承諾和離職意圖的現況及四個變項間的相關性，工作壓力會透過三條間接中介路徑影響離職意圖，除了前面提出的「工作壓力→工作滿意度→離職意圖」、「工作壓力→組織承諾→離職意圖」的兩條中介路徑外，工作壓力還會透過先影響工作滿意度，接著再影響組織承諾的序列性間接中介效果路徑影響離職意圖「工作壓力→工作滿意度→組織承諾→離職意圖」(Bluedorn, 1982)。希望透過本研究，提供地區醫院管理者及單位主管在面對軟硬體措施設備有所侷限的情況下，研擬護理人力資源管理策略之參考，藉以留住優秀護理人員，替醫院創造更好的醫療照護品質與維護病人安全及提升工作績效。

第二節 研究目的

根據上述研究動機與背景所述，本研究的主要研究目的為：(一)了解護理人員的工作壓力、工作滿意度、組織承諾與離職意圖的現況及不同背景護理人員在工作壓力、工作滿意度、組織承諾與離職意圖上的差異；(二)探討護理人員工作壓力、工作滿意度、組織承諾與離職意圖的相關，以及工作滿意度及組織承諾是否為工作壓力及離職意圖之序列中介變項。

第三節 研究問題

根據上述研究目的，本研究問題為：

- 一、 護理人員的工作壓力、工作滿意度、組織承諾與離職意圖的現況為何？
- 二、 在不同背景變項（性別、年齡、教育程度、婚姻狀況、目前任職醫院的護理年資、單位類別）下的護理人員之工作壓力、工作滿意度、組織承諾與離職意圖是否有顯著差異？
- 三、 護理人員的工作壓力、工作滿意度、組織承諾與離職意圖是否具有相關性？
- 四、 護理人員背景變項、工作壓力、工作滿意度及組織承諾對離職意圖是否可以有效的解釋？
- 五、 工作滿意度及組織承諾是否為護理人員工作壓力及離職意圖之序列中介變項？

第四節 名詞釋義

本研究所採用的名詞釋義如下所述：

一、護理人員

護理人員法.〔第一章〕 總則：第 1 條.中華民國人民經護理人員考試及格，並依本法領有護理人員證書者，得充護理人員。第 2 條.本法所稱護理人員，指護理師及護士。本研究所指的護理人員為領有護理人員證書，且在某醫療體系北、中、南區的各家地區醫院任職滿三個月且通過試用期之正職護理人員。

二、工作壓力

工作壓力指的是「當工作要求與工作者的能力、資源或需求產生不匹配時，產生有害的身體和情緒反應。工作壓力會導致健康狀況不佳甚至受傷」(NIOSH, 1999)。根據工作負荷—控制—支持模式 (JDCA model, Johnson 和 Hall, 1988; Karasek 和 Theorell, 1990)，工作壓力指的是在工作負荷高、工作控制低及支持度低的情況下，工作人員容易產生與工作壓力相關的身心健康問題和工作不滿意的結果。

本研究採用中文版「工作特質量表」(鄭雅文, 2002)測量護理人員工作壓力的四個面向：工作控制、工作負荷、主管支持、同事支持等狀態，工作壓力(工作負荷—控制—支持)各分量表得分越高表示在該面向知覺到的控制、負荷量或支持感受程度越高；反之，則越低。

三、工作滿意度

工作滿意度是看待工作時一種愉快或不愉快的情緒狀態，它可以透過對工作的態度，滿意時的積極態度和不滿意時的消極態度來看 (Sari et al., 2021)。根據 Herzberg 的雙因子理論 (1959)，影響工作滿意度的因素有兩個類別，第一類是與「成長或自我實現的需要」有關的因子，被稱為激勵因子，激勵因子包括成就、認可、工作本身、責任、進步和增長的可能性等；而另一類則與「避免不愉快的需要」有關的因子，被稱為保健因子，保健因子包括公司政策和管理、與主管的關係、人際關係、工作條件和薪水等。激勵因子為工作的內在因素，與增加和改善工作滿意度有關，而保健因子則為工作的外在因素，與工作不滿意度有關，改善保健因子只會降低不滿意度，但不會提升滿意度 (Alshmemri et al., 2017)。

本研究採用曾雯琦等 (2017) 依據雙因子理論編製的「台灣醫院護理師工作滿意度量表」測量護理人員對(激勵因子)專業自主與發展、(保健因子)支持性執業環境、人際互動與合作、主管的領導風格、護理工作負荷等五個構面的滿意程度，分數越高表示對該面向的滿意程度越高。

四、組織承諾

組織承諾是指員工認同組織與組織目標，並且期望自己永遠是組織一員的一種程度。組織承諾包含三個面向：情感性 (affective) 承諾指的是員工對組織的情感依戀、認同和參與感，他們想要 (desire) 如此做，員工希望留下來並願意為組織付出努力，因為他們從這種關係中獲得了好處，從內在化的角度來看，員工會致力於與他們共享

價值觀的組織；持續性（continuance）承諾指的是員工基於離開組織所付出的相關成本考量，而做出的承諾，他們需要（need）如此做，當他們沒有任何其他工作選擇並且不想改變他們的工作時，員工更願意留在組織中；規範性（normative）承諾指的是員工對留在組織的義務感，他們覺得有義務（obligation）如此做，留在組織中的義務感源於規範壓力的內化（Allen 和 Meyer, 1996；Clugston , 2000； Meyer 和 Allen, 1991）。

本研究翻譯 Allen 和 Meyer（1990）「組織承諾量表」（Three-Component Model（TCM）Employee Commitment Survey）成中文版，測量護理人員在情感性承諾、持續性承諾、規範性承諾等三個構面的承諾程度，分數越高表示對該面向的承諾程度越高；反之，則越低。

五、離職意圖

Mobley（1977）指出離職意圖是指員工在組織工作一段時間後，對現有工作感到不滿足，經過評估後產生離職的想法。Takase（2010）指出它是一個複雜的過程，是離職行為實際產生前的主要預測因子。

本研究翻譯 Mobley（1977）「離職意圖量表」成中文版，測量護理人員的離職意圖程度，分數越高表示離職意圖程度越高；反之，則越低。

第二章 文獻探討

本章主要探討工作壓力、工作滿意度、組織承諾與離職意圖相關之理論與研究，本章共分為五節，第一節為工作壓力；第二節為工作滿意度；第三節為組織承諾；第四節為離職意圖；第五節為工作壓力、工作滿意度、組織承諾與離職意圖之相關性。

第一節 工作壓力

本節先敘述一般壓力的定義與意涵，再敘述工作壓力的定義與意涵、工作壓力的理論模式、護理人員工作壓力源、護理人員工作壓力相關研究等五方面。

一、壓力的定義與意涵

（一）壓力的定義

根據張氏心理學辭典對壓力的定義，壓力可分為「pressure」，是指在強制性的情境下從事某種活動時（被動的或是自願的），個體身心所產生的一種複雜而又緊張的感受；「stress」指個體生理或心理上感受到威脅時的一種精神狀態，使人在情緒上產生不愉快甚至痛苦的感受（張春興，2006）。

（二）壓力的意涵

壓力（stress）這個名詞最早起源是在 14 世紀，17 世紀物理與生物學家 Robert Hooke 在橋樑的人造結構上對壓力一詞提出了解釋，影響了 20 世紀初生理學、心理學和社會學中的壓力模型（Lazarus, 1993）。接續有哈佛生理學家 Walter Cannon（1914）提出了 fight-or-flight response（戰或逃反應）理論，他發現身體面對急性壓力的刺激，會讓大腦快速啟動神經和內分泌系統為防禦或逃跑作準備，當刺激離開，生理會回復穩定的狀態（Seaward, 2017）。Selye（1955）提到壓力源會引起身體產生一連串非特異性的生理反應，稱為一般適應症後群（General Adaptation Syndrome, GAS），分成三個階段：（一）警戒（alarm）階段，賀爾蒙產生改變，在這個階段中身體尚未獲得適應；（二）抵抗（resistance）階段，身體適應狀況最良好，生理反應產生的症狀減低；（三）耗竭（exhaustion）階段，若持續暴露於壓力源（stressor）下，身體適應的狀態會再度失去，呈現身體資源耗竭的狀態（高鳳霞和鄭伯璦，2014；張春興，1991；Selye, 1995）。

壓力是壓力源，是一種刺激（自變項）、壓力是反應（依變項）、壓力是刺激與反應的互動歷程（壓力被視為是中介變項）。張春興（1991）將壓力情形區分為「刺激型」，指外在或環境中客觀存在的某種具有威脅性的刺激事件，例如天災人禍的現場，其中壓力被視為自變項；「反應型」，指某種具有威脅性的刺激所引發的一種反應型態，只要類似刺激出現，就會引發同類型的反應，該反應視為壓力反應，壓力為依變項；「刺激—反應」，個體對環境中具有威脅的刺激經認知判定後所顯現的反應，壓力源

是否對個體產生壓力，取決於個體對此一壓力源存在的認知，壓力是環境刺激與個體反應的交互關係，在此情況下壓力知覺感受則為中介變項。Lazarus 強調人與環境的關係和關係意涵，透過思想或生理系統的評估，區分威脅性或有害性與良性，在思想（或身體）用來處理壓力需求的應對過程，對心理和身體所產生的複雜影響模式，壓力是一個複雜的互動過程（Lazarus, 1993）。壓力是個體處在具有威脅性刺激的環境中，無法藉由啟動防禦系統來適應或消除威脅的一種被壓迫的感受，但刺激是否對個體構成壓力，需透過個體對事物帶來的壓力程度作認知判斷，才會形成壓力（張春興，1991）。

二、 工作壓力的定義與意涵

（一）工作壓力的定義

美國國家職業安全衛生研究所（National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH）於 1999 年時，將工作壓力（job stress）定義為：「當工作要求與工作者的能力、資源或需求產生不匹配時，產生有害的身體和情緒反應。工作壓力會導致健康狀況不佳甚至受傷」。我國勞動部勞動及職業安全衛生研究所於 2008 年則定義為：「職業環境上所具有的一些特性，對從業人員造成脅迫，而改變從業者生理或心理正常狀態，並可能影響工作者表現或健康的情形」。

（二）工作壓力的意涵

在過去的 20 年中，人們越來越認識到工作壓力是一個重要的職業健康問題。壓力水平（對壓力的急性反應）被認為是慢性健康狀況的先兆。研究結果顯示，工作壓力除了影響個體的生理健康外也影響心理健康，長期處於工作壓力之下可能引發多種健康問題，包括身心症（頭痛、失眠）、心理層面（憂鬱、焦慮、沮喪、煩躁）、生理層面（心血管疾病、高血壓、消化或免疫系統問題、高肌肉緊張度）、行為層面（工作表現差、工安及交通事故、睡眠障礙、濫用藥物、抽菸、酗酒），甚至是社會層面（家庭衝突、暴力）等問題（高鳳霞和鄭伯璦，2014；葉婉榆等人，2008；Cooper et al., 1988；Murphy, 1995）。歐盟亦將壓力源視為新興社會心理危害因素。另外，工作壓力對組織甚至社會也都造成極大的影響，工作壓力會導致很大一部分工人賠償要求、醫療保健成本、殘疾、曠工和生產力損失，工作壓力與更高的倦怠以及更頻繁的健康和績效問題都有關。工作壓力不考慮職業界限，因此存在此類健康風險的可能性無處不在（高鳳霞和鄭伯璦，2014；葉婉榆等，2008；Cooper et al., 1988；Murphy, 1995）。

Caplan 等（1975）指出工作壓力源是指對個人構成威脅的任何工作環境特徵。儘管工作壓力源被列為單個類別，但通常將它們分為幾大類。例如，Cooper 和 Marshall（1976）所定義的壓力源包含五大類：（一）工作固有的因素；（二）在組織中的角色；（三）工作中的關係；（四）職業發展；（五）組織結構和氣候。而影響工作壓力與健康關係的調節因素包括：個人特徵（例如人格特質）；非工作因素（例如家庭事務，撫養子女，財務問題，社會關係）；和緩衝因素（例如社會支持，應對技能，體育鍛

煉)。這些緩和因素的作用是加強或削弱工作壓力源與健康結果之間的關係 (Murphy, 1995)。

有兩種工作壓力可能會威脅到個人，一種工作壓力是個人無法滿足工作環境的要求，一種工作壓力是工作環境不足以滿足個人的需要。這兩種類型的工作壓力由 French 等 (1974) 透過人與環境的適應性理論進行了闡述。個人的技能和能力與工作要求相匹配的程度代表一種適配的條件，在工作環境中滿足個人需求的程度是另一種適配的方式。因此，工作壓力被概念化為員工與工作環境之間的任何一種關係的不匹配 (Beehr 和 Newman, 1978)。

綜上所述，個人的能力或需求無法和工作要求相匹配時，會衍生工作壓力，進而造成生理、心理、社會、組織表現、醫療等，從個人、到組織、到社會多方面的影響。

三、工作壓力的理論模式

目前工作壓力的模式相當多，不同模式從不同的角度探討造成壓力的因素與壓力造成後果之間的關係，如 (一) **個體與環境適配模式** (person-environment fit model, French, 1973)，個體的健康狀態取決於工作環境及工作要求是否符合個體的能力、知識、技巧與需求等；(二) **工作負荷與控制模式** (Karasek, 1979) 及**後續擴展的工作負荷—控制—支持模式** (Johnson 和 Hall, 1988; Karasek 和 Theorell, 1990)，假設工作負荷與工作控制 (尤其是高負荷及低控制、低支持) 會造成高工作壓力；(三) **付出一回饋失衡模式** (Siegrist, 1996)，強調工作是為了換取各種形式的回饋，如：物質金錢上的回饋 (如：薪資、福利)、心理層面的回饋 (如：自我價值感、尊重和支持)、社會層面的回饋 (如：晉升機會、工作的保障和權力、地位) 等，若付出的成本和獲得回饋之間失去平衡 (如：付出高/回饋低)，則會導致心理方面的壓力及疾病；(四) **統合性工作壓力模式**，由陸洛等 (陸洛和高淑芳, 1999) 根據 Cary 與 Williams (1988) 所發展的工作壓力源及工作壓力後果衡鑑工具「職業壓力指標」(Occupational Stress Indicator, OSI) 所建立出的，此模式強調工作壓力是個人 (工作者) 與環境 (職場) 的特異性關係中衍生的，工作壓力被認為是一個主觀的個體化的現象，是一個複雜的過程，也是一個呈現動態改變的狀態，個體面對各式壓力源所產生的主觀感受，就是一種工作壓力感受，此模式的範圍包括了背景脈絡、潛在的壓力源、調節因素／中介因素、以及工作壓力的後果等。(五) **挑戰—阻礙觀點模式** (Challenge-Hindrance Model) (Cavanaugh et. al., 2000)，此模式認為工作壓力並非都是帶來負向的感受，因此將工作壓力劃分為挑戰型與阻礙型，挑戰型壓力被視為正向的壓力因子，員工會將工作要求當作一種鼓舞與機會，可提供個人成長並達成目標；阻礙型會造成個人發展受到阻礙，干擾個人目標的達成。挑戰—阻礙模式中，人們會對壓力源進行認知上的評估，並將其進行歸類，挑戰型壓力會使員工產生成就感，對於工作效能和工作態度有正向的影響，而阻礙型壓力無法激發個人的潛能，會對工作效能和工作態度造成負向影響。(高旭繁和陸洛, 2011; 高鳳霞和鄭伯壘, 2014; 曾慧萍和鄭雅文, 2002; Lin et al., 2011)。

由於護理人員的工作屬於高工作負荷與高控制的情況，故以下將針對目前備受工作壓力流行病學研究和工作－組織心理學所重視，以及本研究主要依據的「工作負荷－控制模式」及「工作負荷－控制－支持模式」作簡介。

(一) 工作負荷－控制模式 (Job Demand-Control model, JDC model)

Karasek(1979)提出 JDC 模式，構成此模式的核心要素為工作負荷(job demand)及工作決策自由度 (job decision latitude)，前者指心理上的壓力源，如：工作負荷程度、時間壓力與工作衝突，後者指的是工作人員在工作上的技能自由裁量權 (skill discretion) 與決策自主權 (decision authority) 兩個面向，後來的研究則將兩者合併以工作控制 (job control) 稱之。工作負荷是造成外在壓力增加的重要因素，而工作控制則是減少外在壓力的重要因素，員工面對工作負荷，藉由提升控制來減低壓力源，避免工作負荷造成的不良結果。工作控制在工作壓力減緩上扮演重要的角色，工作控制可以增加動機、福祉與健康，充分的工作控制可以避免工作人員心理或生理受到工作負荷的不良影響。

透過工作負荷及控制兩個向度，形成四個基本假設 (圖 2-1) (Theorell 和 Karasek,1996)：

一、 高壓力工作 (high strain job)

在高工作負荷與低工作控制的情況，會導致工作壓力，高工作負荷會造成員工呈現警醒 (arousal) 狀態，增加心跳速率或腎上腺素的分泌，若處於低工作控制而沒有適當的紓解管道時，將會造成工作壓力的狀態，累積性壓力反應讓人喪失自信，甚至失去積極學習的能力，使抗壓性變低。

二、 積極工作 (active job)

高工作負荷與高工作控制的情況，可減緩高工作負荷所造成的工作壓力，高控制提供員工可以積極應對的環境，當員工有能力克服工作負荷時，挑戰性的工作會激發潛能，使人產生支配感與學習動力進而產生自信，提高抗壓性和激勵的正向結果。美國曾以 Karasek 的工作負荷－控制模式量表進行全國性工作特質調查，發現律師、醫師、教師、護理師等專業人員和農夫、木工、水電工是屬於這類型的職業。

三、 低壓力工作 (low strain job)

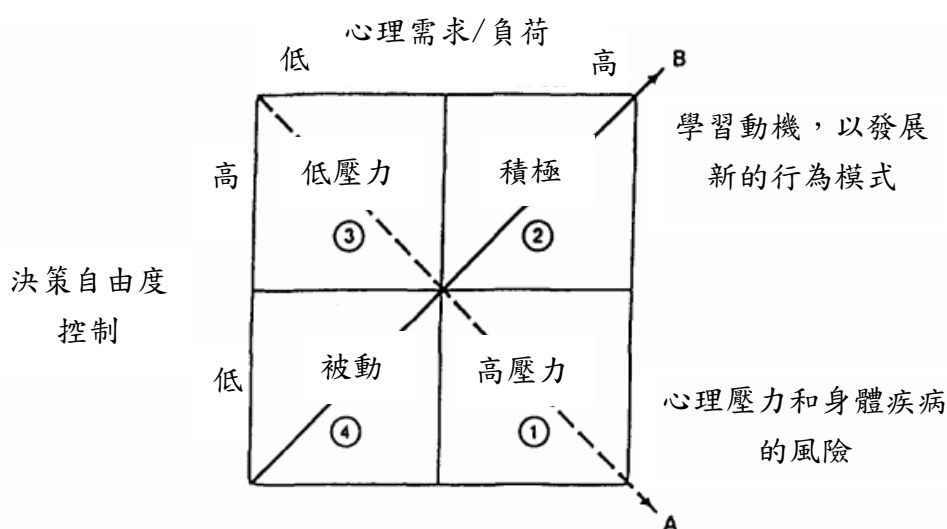
低工作負荷與高工作控制的情況，員工的無助感情況會比較低，流行病學研究發現相較於其他類型，這類型的人心理健康狀況最好。

四、 被動工作 (passive job)

低工作負荷與低工作控制的情況，長期處於這種狀態下的員工，工作步調緩慢、內容較單調，研究發現此類工作者心智機能容易退化，也容易喪失原有技能，會比較無法進行正確判斷、解決問題甚至面對挑戰的能力也較低。

圖 2-1

心理需求/負荷-決策自由度模型



資料來源: Theorell, T., & Karasek, R. A. (1996). Current issues relating to psychosocial job strain and cardiovascular disease research. *Journal of occupational health psychology*, 1(1), 9.

(二) 工作負荷—控制—支持模式 (Job Demand-Control-Support model, JDCS model)

近年來流行病學研究發現社會支持對壓力反應具有其重要性，同時社會支持有可能也是一種壓力源，也可能對個人的壓力反應形成一種緩衝或強化的影響。Karasek 後續修正 Karasek (1979) 提出的觀點，認為除了工作負荷與工作控制之外，應該要加入社會支持對壓力的影響，亦即透過團體成員的力量來產生壓力調節，成員若能感受到社會支持，將降低壓力的發生，因此 Karasek 與同事進一步提出了工作負荷—控制—支持模式 (Johnson 和 Hall, 1988; Karasek 和 Theorell, 1990)，長久以來社會支持在工作壓力以及員工生理、心理健康方面被認為有直接的交互作用，在高工作負荷情況下，能否順利完成工作是員工最擔心的事，而主管與同事給予的支持與肯定，提供了一個讓人安心與接受到回饋的工作環境，社會支持有助於提升員工對於工作完成的信心與受到相互關懷的感受 (高鳳霞和鄭伯璦，2014)。

JDCS 模式將 JDC 模式擴充為 3 個假設：1、隔離壓力假設，此假設為高負荷、低控制（高壓力工作）和低支持的狀態，此狀態不利於員工，會產生高工作壓力、低生理及心理健康、低工作滿意的負面結果；2、緩衝假設，此假設認為社會支持有助於減輕高負荷、低控制（高壓力工作）所造成的負面結果；3、積極假設，此假設則認為社會支持和工作控制有助於增加高負荷的員工在學習、健康的恢復、對工作的信心和生產力上的正面效果 (林少龍，2005)。

故本研究將採用 Karasek (1998) 以 (工作負荷—控制—支持) 模式為依據所發展的工作特質量表 (JCQ) 中文版 (曾慧萍、鄭雅文, 2002), 測量護理人員工作壓力的四個面向: 工作控制、工作負荷、主管支持和同事支持 (社會支持) 等狀態。

四、護理人員工作壓力源

2019 年底新型冠狀病毒疾病 (COVID-19) 在全球爆發, 執業護理師在疫情期間須面臨諸多壓力與擔憂 (馮明珠等人, 2020), 加上我國自民國 84 年 3 月實施全民健康保險, 推出各種醫療保險支付制度及相關政策, 同時國民年所得提升, 國民對於醫療照護的需求及品質要求也日益重視, 使得醫療生態面臨衝擊及劇變, 而護理專業領域亦受到相當程度的衝擊。相較於其他種類的職業族群, 臨床護理專業工作是屬於高工作壓力的職業, 因為護理人員的工作職責與照護病人生命和健康息息相關, 所以工作過程中不容許有任何的錯誤與疏失。

美國勞工部 (U.S. Department of Labor) 於 2013 年指出, 醫療人員須經常面對生死攸關的緊急與複雜的情況, 其工作之繁重、時程之緊湊, 若再加上服務對象過份的要求、人力的不足、繁重的文書工作、複雜或故障的設備、工作等級權力分明時, 皆會變成醫療人員的壓力來源。醫療人員中, 護理人員佔最大部分 (以台灣而言, 將近 70%), 而 1984 年學者 Hingley 更指出: 護理專業是令人感到壓力很大的工作 (引自蕭淑銖和胡佩怡, 2015)。

根據各國及國內的研究統計資料所示, 臨床護理人員所面臨的工作壓力源可歸類成為五大構面 (王靜琳等人, 2008; 何慧菁等人, 2010; 林采怡和林弘昌, 2019; 林瑜雯等人, 2011; 胡家綺, 2017; 張松齡等人, 2003; 張瑋佳和劉美雯, 2013; 張薰榕等人, 2012; 陳宜傳, 2015; 黃玉琳, 2019; 楊育淇等人, 2018; 羅文惠等人, 2021):

一、行政管理: 工作壓力源來自於處理許多單位內及醫院所交付的行政工作, 但在管理上欠缺自主權, 又難以獲得同事間的社會支持。

二、工作環境: 短時間內病人量劇增或交班延長工作時數的負荷、對無法控制的職業危害或傳染性疾病之曝露、擔心與社會隔離、針扎、工作時面對暴力與威脅、睡眠剝奪、人力不足、輪班、醫療糾紛、應付醫院評鑑工作、升等或學術研究、個人考核的制度、薪水的給付制度。

三、人際關係: 缺乏工作上的支持 (尤其是來自護理主管的支持)、與病人關係的維持、與同事及患者的衝突、家庭或私人事務與工作的衝突。

四、病人照護: 工作負荷量過重、時間壓力、病人病情穩定度、病人疾病的緊急變化。

五、專業知識及技術: 工作準備度不足、病人照護上專業相關技能不足及缺乏決定自主權、自我專業成長或職涯發展受限、角色模糊與衝突、在職進修。

五、護理人員工作壓力相關研究

(一) 工作壓力現況

林采怡和林弘昌 (2019) 探討護理人員工作壓力的研究中發現, 護理人員的工作壓力以「人力短缺」排名第一, 「職業危害」排名第二, 「負荷過重」排名第三。雖然

照護病人是臨床護理人員主要的工作職責，但因為病人人數多，且每班護理人員必須完成照護工作才能離開工作單位，因而導致延遲下班頻繁。尤其在病人出入院交替的過程，病人人數在短時間內急劇增加是造成護理人員照護人數負荷過度的重要因素，臨床單位的護理人力有限，合理安排每個班別配置的人數成為護理長工作上之兩難。

此外，臨床護理人員經常會面臨個人無法控制的職業環境危害暴露威脅，例如來自於照護病人過程所引起的危害，因照護疑似新興傳染病或其他具有傳染性疾病的病人，而有遭受感染之風險、施打化療藥物過程碰觸到外滲的藥物、臥床的病人在病房單位照射 X 光時暴露於輻射環境中，或是病人做出暴力攻擊和性騷擾的行為所遭受到的危害。除了照護病人外，資深臨床護理人員亦要指導及協助新進人員的工作情況等都加重其工作負荷（林瑜雯等人，2011）。

在 COVID-19 疫情之下，研究發現護理人員的壓力以「照顧病人的負擔」構面的分數最高，其次依序為「擔心與社會隔離」、「防護裝備引起的不適」、「感染控制的困難與焦慮」（羅文惠等人，2021）。

研究也發現手術室護理人員在手術室的「工作環境」壓力最大，在 42 項工作壓力源中最困擾手術室護理人員的前三項分別是：1.接觸病人血液及體液時（尖銳物刺傷如：針扎）2.器官移植捐贈者的遺體護理 3.接觸 X-Ray 輻射線（黃瑞珍等人，2001）。

其他在工作壓力源感受中，由高至低分別為：面對醫療糾紛、應付醫院評鑑工作、升等或學術研究、病人病情穩定度、個人考核的制度、薪水的給付制度、維持醫療院所的營運、與病人關係的維持等（胡家綺，2017；張薰榕等人，2012）。

綜上所述，護理人員身處臨床的第一線，護理人力的不足、執業環境的潛在危害（新興傳染病、放射線、暴力）以及病人照護上所承擔的心理和身體上的負荷，均是構成護理人員工作壓力的主要來源。

（二）工作壓力與心理相關變項

與工作壓力有關的心理變項大致可分為組織工作及個人心理健康兩大類，與組織工作有關的變項如：工作倦怠、工作滿意度、組織承諾、工作投入、工作表現、離職意圖等；與個人心理健康有關變項如：失眠、焦慮症與憂鬱症等（何慧菁等人，2010；吳美珠等人，2018；林采怡和林弘昌，2019；林碧莉等人，2005；侯望倫，1984；洪秀玟和丘文斌，2013；胡怡君等人，2019；張翠芬等人，2016；張翠芬等人，2020；陳梅麗等人，2000；陳銘薰和黃新龍，2019；黃若飴等人，2017；黃毓華等人，2015；黃瑞珍等人，2001；盧玉蕸等人，2014；謝良博等人，2011）。

本節將針對工作壓力與工作倦怠及心理健康進行簡單回顧，其餘與本研究相關之心理變項（如：工作滿意度、組織承諾、離職意圖），將在後面章節做進一步說明。

1、工作壓力與工作倦怠

工作倦怠（Burnout）又稱疲憊或疲勞，是身體與心理的疲憊與耗竭狀態，1974 年由 Freudenberger 提出，工作倦怠多發生在與「人」密切接觸的工作者身上如護理人員，護理人員因其工作獨特性及需要 24 小時輪班，使護理人員成為工作疲勞高盛行率之族群，長期處於時間及工作量過度負荷的高壓力下，容易產生工作倦怠，不僅降

低工作滿意度，還會影響臨床照護品質及工作績效，甚至導致離職產生，對醫院機構是一大損失（吳美珠等人，2018；胡怡君等人，2019；盧玉羸等人，2014）。護理方面研究顯示護理人員之工作壓力會正向影響其工作倦怠、而其工作倦怠亦會正向影響其離職傾向，此外，工作倦怠在工作壓力與離職傾向間具有部分中介效果（莊于瑄，2020；黃玉琳，2019）。

2、工作壓力與心理健康

研究發現工作壓力對護理人員心理健康造成的影響已不容忽視。楊麗清（2016）以 3,786 位（平均年齡為 32.7 歲，平均護理總年資為 10.2 年），不同層級醫院之臨床護理人員進行研究，其中 34.8% 身心狀況適應良好、33.4% 有輕度心理困擾、24.8% 有中度心理困擾、7% 有重度心理困擾。有 65.2% 達常見精神疾患（如：失眠、焦慮症與憂鬱症等）。

謝良博等人（2001）研究發現憂鬱症狀和工作壓力有關聯，頭痛可作為評估憂鬱狀態的重要參考指標。

何慧菁等人（2010）研究發現，平均睡眠少、平均收入少、女性、未婚、護理人員、任職於一般病房、自覺輪班造成睡眠障礙者與健康狀況有顯著相關。工作壓力越大，身心健康越差。

黃毓華等人（2015）：研究結果證實，工作負荷對心理健康具顯著負向影響；同事支持對身體症狀具顯著負向影響。

賴育民等人（2012）發現研究對象之憂鬱情緒盛行率為 14.58%，屬高壓力工作特質者，是出現憂鬱反應之高危險群。

（三）背景變項

性別、年齡、教育程度、婚姻狀態、服務年資、服務單位類別等是護理人員壓力研究中常被探討的背景變項，以下逐一回顧。

1. 性別

研究發現護理人員工作壓力不會因為性別而有所差異（郭玉琦，2019；胡家綺，2017）

2. 年齡

有研究顯示年齡與壓力有關，年齡愈輕者，壓力感受越大（王靜琳等人，2008；劉素蘭等人，2010），年齡層方面 31-35 歲者較其他年齡族群壓力感受強（張松齡等人，2003），45-49 歲大於 35-39 歲與 40-44 歲，在 45-49 歲年齡層的護理人員因為長期人力短缺、職業倦怠、體力已無法承受輪班壓力等因素而感到工作壓力會比其他年齡層高（林采怡和林弘昌，2019）。但也有研究顯示護理人員工作壓力不會因年齡不同而有顯著差異（胡家綺，2017；郭玉琦，2019）。

3. 教育程度

研究發現，高職者的醫療工作壓力源低於大專以上，學歷為碩士者壓力感受較小，推測與學歷高者專業知識技能及自我肯定較佳有關，教育程度與工作壓力類別反應呈顯著差異（何慧菁等人，2010；張薰榕 等人，2012；黃瑞珍等人，2001），也有研究

顯示，護理人員工作壓力不會因教育程度不同而有顯著差異（王靜琳等人，2008；胡家綺，2017；郭玉琦，2019；黃玉琳，2019）。

4. 婚姻狀態

研究發現未婚護理人員的壓力高於已婚者（王靜琳等人，2008；何慧菁等人，2010；胡家綺，2017；張松齡等人，2003；張薰榕等人，2012），但亦有研究顯示護理人員工作壓力不會因婚姻狀況不同而有顯著差異（郭玉琦，2019）。

5. 服務年資

研究發現，年資越長者其工作壓力越小，在護理總年資方面，年資在 6 至 10 年者壓力會大於 1 至 5 年及 16 年以上者（王靜琳等人，2008；張松齡等人，2003），也有研究顯示，護理人員工作壓力未因服務年資不同而有顯著差異（郭玉琦，2019）。

6. 單位類別

研究顯示，內外科單位、急診、加護病房等單位壓力大於其他單位（王靜琳等人，2008；何慧菁等人，2010；胡家綺，2017；郭玉琦，2019；陳宣傳，2015）。

根據上述護理人員工作壓力相關研究所示，在背景變項方面包含性別、年齡、教育程度、婚姻狀態、服務年資及單位類別等不同變項，而護理人員工作壓力來源可歸類為，工作技能方面（例如：需學習新事物、需高度技術、需做各式各樣的事），工作負荷方面（例如：工作很累人、工作過量、沒有足夠的時間完成工作），而在工作決策和主管及同事支持方面的研究結果較少被呈現，故本研究將以 Karasek 工作負荷—控制—支持模式的理論為依據，採用「工作特質量表」（曾慧萍、鄭雅文，2002；Cheng et al., 2003）探討護理人員工作壓力現況，以及在性別、年齡、教育程度、婚姻狀態、服務年資、單位類別等背景變項不同之護理人員在工作壓力上之差異性，並進行後續工作壓力（工作負荷—控制—支持）分量表對於工作滿意度、組織承諾、離職意圖的相關性檢視。

第二節 工作滿意度

本節從工作滿意度的意涵、工作滿意度的理論模式、護理人員工作滿意度和護理人員工作滿意度的相關研究等四方面分別敘述。

一、工作滿意度的意涵

工作滿意度（job satisfaction）的概念起源於 Mayo（1927-1932）的霍桑實驗。工作滿意度是看待工作時一種愉快或不愉快的情緒狀態。這可以透過對待工作的態度，滿意時候的積極態度和不滿意時候的消極態度來看待（Sari et al., 2021）。此外，有關工作滿意又有另一相似之定義，是由 Getzels 等人所提出的，他們認為「滿意」是一種存在於個人需要（individual needs）和對於制度期盼（institutional expectation）間一致性的函數；當個人需要與制度期盼相同且一致時，滿意度將達到最高點，當個人需要與制度期盼不一致時，滿意度將落到最低點（引自黃昆輝，2000）。

除此之外 Williams (1998) 對超過 14,000 個案例進行分析後，提出職業壓力指標 (OSI)，工作滿意度分為一個內在滿意度因素，是指個人的工作經驗，包括成就和工作本身；一個外在滿意度因素，是指工作環境各方面的滿意度，包括組織設計，組織過程和個人關係。工作滿意和工作不滿意，可以歸因在被調查者自己的特質以及他們對工作環境各方面的不滿。(Lyne et al., 2000)。

綜上所述，工作滿意度是一種看待工作時是否愉快的情緒狀態，存在於個人需要與對體制期盼的一致性與否，又可分為與成就感和工作本身有關的內在因素及與工作環境人、事、物有關的外在因素。

二、工作滿意度的理論模式

有關「工作滿意」理論之探討，依據 Lawler 的看法，可區分為四種類型：(一)「**實現理論**」(fulfillment theory)：工作滿意指的是個人所遭受的待遇，能夠滿足其所需的程度，待遇高的人比待遇低的人較具有滿意感；(二)「**差異理論**」(discrepancy theory)：人們因為「需要」或「期盼」的不同，即便給予一樣的待遇，也會反應出不同的滿意程度；(三)「**公平理論**」(equity theory)：由 Adams 所提出，強調工作者努力的程度、工作績效及工作滿足的主要因素在於個人是否感到滿意，滿意程度關乎於工作者感受自己在工作情境中的付出（如：時間、金錢、心力、技術、努力與經驗）與報酬（如：薪資、福利、獎勵、升遷、讚美、地位）二者之間的比率和他人相比是否公平而定；(四)「**雙因子理論**」(two-factor theory)：強調工作滿意與工作不滿意是二個單獨且平行的獨立變項，造成工作滿意的因子稱為「內在動機因子」，可以促進工作表現；而產生不滿意的因子，稱為「外在環境因子」，是與工作環境所相關的因素（引自黃昆輝，2000）。

另外，還有其他關於工作滿意的理論如「**需求層次理論**」(Need hierarchy theory)，Maslow 認為人類有七種不同層次的需求，由低而高分別是生理需求（如：食衣住行）、安全需求（如：避免身體受到危害、恐懼及意外的安全保障）、愛與歸屬需求（如：友誼、情感與愛的需求）、自尊需求（如：自我尊重、自信及受他人尊重、賞識）、知的需求（如：對知識、價值和新奇事物的探索）、美的需求（如：有結構、有秩序、順應自然等心理需求）、自我實現的需求（如：充實自我、發揮潛力、不斷成長、實踐理想）；「**系統理論**」(Systems theory)，由 Wernimont 所提出，認為影響工作滿意度的因素可分為內在個人因素和外在環境兩大因素，內在因素包括：成就感、責任感、組織認同感、進步感、公平感，外在因素包括：組織政策、工作環境、薪資待遇、職務升遷、主管領導能力、人際關係，內在和外因素會互相影響與循環而形成一個動態的系統（盧怡孜，2017）。

為延續工作壓力（工作負荷—控制—支持）分量表以工作控制（個人）和工作負荷、社會支持（外在環境）為研究及探討的方向，故本研究主要依據為將工作滿意度分為激勵（內在動機）因子和保健（外在環境）因子的「**雙因子理論**」，以下作進一步的說明。

（一）雙因子理論

1959 年，Herzberg 等人在對一群會計師和工程師進行研究的過程中，發現員工的內心感受和外在的環境會對員工的工作滿意度造成影響，因此發表了雙因子理論，該理論受到馬斯洛需求層次的影響。工作滿意度的雙因子理論把對工作滿意度有影響的因素分為兩組類別，造成工作滿意的因子稱為內在動機因子（激勵因子），是與工作活動本身有關的心理滿意程度，有此因子可以促進工作表現；而產生不滿意的因子，稱為外在環境因子（保健因子），是與工作環境所相關的因素，其活動表現與生理預防保健原則類似，其運作模式是在去除人們周遭的危害因素，是預防的而不是治療的（Alshmemri et al., 2017, Herzberg, 1968），兩因子的個別說明如下：

1、激勵因子

與「成長或自我實現的需要」有關，被稱為激勵因子，激勵因子包括成就感、認可感、工作本身因素（有趣的、富有挑戰的）、責任感、個人進步和發展的可能性等因素，當這些激勵因子存在的時候，會讓員工的內在滿足感增加和改善工作滿意度，但是不存在時，也不會因此降低員工工作的動力，因此 Herzberg 將激勵因子歸屬於工作的內在因素，可用來提升組織的績效。

2、保健因子

與「避免不愉快的需要」有關，被稱為保健因子。保健因子包括公司政策、工作管理、與主管的關係、人際關係、工作條件、薪資福利和薪水、工作環境等。因此 Herzberg 將保健因子歸屬於工作的外在因素。假如保健因子存在且設計完善，有助於減少員工對工作所產生的不滿，但是不存在或是設計不完善時，不但沒辦法提升員工的滿足感，對組織的績效也沒有助益。

三、護理人員工作滿意度

研究發現，與護理人員工作滿意度相關的關鍵因素可分為個人因素、工作因素與組織因素三大類：（一）個人因素，如：年齡、工作年資、教育程度、個人的努力、憂鬱狀況；（二）工作因素，如：輪班、工作本身產生的壓力、工作自主性；（三）組織因素，如：組織承諾、主管領導、工作績效、護理工作團隊的凝聚力、護理人力配置、獎勵方式（吳玲珠等人，2014；Dilig-Ruiz et al., 2018；Lu et al., 1999；Penconek et al., 2021）。

四、護理人員工作滿意度的相關研究

（一）工作滿意度現況

林采怡和林弘昌（2019）以某區域教學醫院 207 位臨床護理人員為對象，發現護理人員在「工作滿意度」問卷結果顯示，「人際互動與合作」構面的滿意度最高，其次為對「主管的領導風格」構面，之後是「專業自主與發展」構面，以及「支持性執業環境」構面；滿意度最低的為「護理工作的負荷」構面，此結果顯示護理工作的負荷壓力會影響護理人員對工作產生不滿的感受。

湯心怡（2019）以北區某教學醫院 60 位護理人員為對象，發現護理人員在「工作滿意度」問卷結果顯示，「主管的領導風格」構面的滿意度最高，其次為對「人際

互動與合作」構面，之後是「專業自主與發展」構面，以及「支持性執業環境」構面；滿意度最低的為「護理工作的負荷」構面，此結果亦顯示護理工作的負荷壓力會影響護理人員對工作產生不滿的感受。

（二）工作滿意度與心理相關變項

與工作滿意度有關的心理變項大致可分為組織工作及個人兩大類，與組織工作有關的變項如：工作壓力、組織承諾、離職意圖、主管支持；與個人有關變項如：激勵、自我效能、特質（林采怡和林弘昌，2019；洪淑芬，2014；胡玉英等人，2007；胡家綺，2017；張偉斌等人，2020；張翠芬等人，2016；陳怡光等人，2013；黃穗芬等人，2011；鍾宜芬和陳俞成，2020）。

本節將針對主管支持與工作滿意度、工作壓力與工作滿意度進行說明，其餘與本研究相關之心理變項，將在後面章節做進一步說明。

1、主管支持與工作滿意度

根據 Blau (1964) 提出的社會交換理論觀點，主管與員工雙方之間的交換關係良好，員工能獲得更多來自於主管的支持，就會產生更好的工作滿意。張偉斌等(2020)的研究發現，當主管支持愈高時，公共衛生護理人員所產生的工作滿意度也愈高。

2、工作壓力與工作滿意度

研究一般皆發現工作壓力及工作滿意度存在著密切關係，工作壓力與工作滿意度呈現顯著負向相關（林采怡和林弘昌，2019；張偉斌等人，2020；黃穗芬等人，2011）。護理人員在工作面臨壓力時若無法獲得適當抒解，會對工作的滿意程度產生影響，當護理人員工作壓力越大，對自我工作態度和環境滿意度越低，工作壓力對護理人員的工作滿意度亦是如此，工作負荷過量導致工作壓力，進而使工作滿意降低。護理人員在工作中的需求未能獲得滿足，則容易產生心理壓力，導致精神疲憊，進而對工作不滿意的感受增加（胡家綺，2017）。

（三）背景變項

性別、年齡、教育程度、婚姻狀態、服務年資、服務單位類別等是護理人員壓力研究中常被探討的背景變項，以下逐一回顧。

1、性別

研究發現，性別性別會影響新進護理人員的工作滿意度，男性對工作環境的滿意度明顯高於女性（張翠芬等人，2016）

2、年齡

研究發現，年齡與護理人員工作滿意度並未有顯著的關係存在（吳玲珠等人，2014；林采怡和林弘昌，2019；胡家綺，2017；湯心怡，2019）。但也有研究顯示年齡與護理人員工作滿意度有顯著正相關。（胡玉英等人，2007）

3、教育程度

研究發現，不同教育程度的護理人員其工作滿意度無顯著的差異存在（王郁智等人，2006；湯心怡，2019）。也有研究顯示，大學（含二技）學歷的護理人員在「工作環境總分」的工作滿意度感受高於專科學歷的護理人員（胡家綺，2017）。

4、婚姻狀態

研究發現，不同婚姻狀態的護理人員其工作滿意度無顯著的差異存在（吳玲珠等人，2014；陳自立，2005；湯心怡，2019），也有研究發現，已婚者比未婚者工作滿意度達顯著的差異（王郁智等人，2006；胡家綺，2017）。

5、服務年資

研究大致顯示，不同服務年資的護理人員其工作滿意度無顯著的差異存在（林采怡和林弘昌，2019；胡家綺，2017；湯心怡，2019）。但也有研究顯示服務年資與護理人員工作滿意度有顯著正相關。（胡玉英等人，2007）

6. 單位類別

研究顯示，不同單位類別的護理人員其工作滿意度無顯著的差異存在（湯心怡，2019），也有研究發現，服務科別越是急重症單位，護理人員其工作滿意度反而越低，在「工作環境總分」的護理人員工作滿意度感受中，門診（含社區）最高、加護病房（含呼吸照護病房）及開刀房其次、急診及內外科病房最低（吳玲珠等人，2014；林采怡和林弘昌，2019；胡家綺，2017）。

根據上述各護理人員工作滿意度的相關研究所示，在背景變項方面包含性別、年齡、教育程度、婚姻狀態、服務年資及單位類別等不同變項，而影響護理人員工作滿意度的重要因素可區分為支持性執業環境、專業自主與發展、人際互動與合作、主管的領導風格、以及護理工作的負荷等五個構面。故本研究以雙因子理論為依據，採用曾雯琦等人（2017）所建立的「台灣醫院護理師工作滿意度量表」探討護理人員工作滿意度現況，以及在性別、年齡、教育程度、婚姻狀態、服務年資、單位類別等背景變項不同之護理人員在工作滿意度上之差異性，並進行後續工作滿意度對於工作壓力、組織承諾、離職意圖的相關性檢視。

第三節 組織承諾

本節從組織承諾的意涵、組織承諾的理論模式和護理人員組織承諾的相關研究等三方面分別敘述。

一、組織承諾的意涵

組織承諾（organizational commitment）的概念最早由 Whyte 於 1956 年所提出「所謂組織人，是為組織工作的人，同時也是屬於組織的人」，它是一種對組織認同的心理狀態，所謂承諾是個人經過一番審慎思考後，對所要承諾的主體產生積極且認同的情感，並且願意為所做之承諾的主體做出負責的決定和付出心力（Randall, 1990）。1970 年代，組織承諾的概念在職業心理學與組織行為學中蔚為盛行，管理學界的學者廣泛地引用此概念來探討個人職業發展、組織革新或組織效能，它是管理學領域相

關範疇中，影響層面甚廣且被列為是相當重要的態度變項（Mowday, et al., 1979；Meyer et al., 1993）。

組織承諾是個人對特定組織所產生的認同感和心力投入的程度，包含三個面向：（一）對組織的目標與價值具有強烈的信仰和接受度；（二）願意為了組織的利益而付出努力；（三）確切的希望持續成為組織中的一份子（Mowday, et al., 1979）。Meyer 和 Allen（1993）指出組織承諾是指員工認同組織與組織目標，並且期望自己永遠是組織一員的一種程度。林俊傑（2007）統整國內外學者對組織承諾的定義，組織承諾是指組織成員對於組織的目標和共同享有的核心價值具有強烈的認同感，願意為組織的利益在工作上自動自發的盡心盡力、貢獻自我，而有強烈的意願希望繼續留在組織中。

Steers（1977）研究顯示，組織承諾受到重視的原因有三：第一、組織承諾可以用來預測員工的離職行為；第二、具高組織承諾的員工，其表現出的工作績效較佳，高組織承諾的員工往往會在以下方面表現出色：1.組織強調高成就導向，同時保持良好的員工關係；2.被動承諾可以轉化為主動承諾；3.員工具備必要的技能和能力，並充分理解和接受其特定的組織角色。當組織無法為員工提供具有挑戰性和有意義的任務時，承諾水平往往會降低。第三、組織承諾可以作為預估組織效能的指標。

綜上所述，組織承諾是個人對組織目標或是組織的核心價值，所產生的認同感和願意為了組織利益自動自發投入心力的狀態，且有意願希望繼續留在組織中。

二、組織承諾的理論模式

Meyer 和 Allen（1991）的研究結果將組織承諾分成三個面向：情感性、持續性和規範性承諾，其他學者提出的理論模式有 Steers 之組織承諾「前因後果」模式、Staw 之組織承諾形成模式、Stevens 等之組織承諾角色覺知模式、Mowday 等人將 Steers 模式擴充，並發展出更具體且周延的組織承諾前因後果模式、Morris 與 Sherman 之組織承諾多元預測模式、Fishbein 之組織承諾行為意圖模式、Wiener 之組織承諾形成模式、Reyes 之教師組織承諾模式等（引自林俊傑，2007）。

以下針對本研究所採用的 Meyer 和 Allen 組織承諾理論模式（1991）做進一步說明：

（一）情感性（affective）承諾：是指員工對組織的情感依戀、認同和參與，他們想要（desire）如此做。員工希望留下來並願意為組織付出努力，因為他們從這種關係中獲得了好處。從內在化的角度來看，員工會致力於與他們共享價值觀的組織。此外，他們為這些組織的成功而努力，因為這樣做時他們的行為方式與他們自己的價值觀一致。與情感承諾相關的變項包括 1.入職前的期望：獎勵公平分配、組織可靠性、組織支持、角色清晰和避免衝突；2.和主管考量與能力相關的經驗：包括成就感、自

主性、績效獎勵的公平性、工作挑戰、工作內容、獲得晉升機會、自我表達的機會、參與決策，以及個人對組織的重要性。

(二) 持續性 (continuance) 承諾：是指員工基於離開組織所付出的相關成本考量，而做出的承諾，他們需要 (need) 如此做。當他們沒有任何其他工作選擇並且不想改變他們的工作時，員工更願意留在組織中。員工認知到採取行動所產生的沉沒成本 (sunk costs)，例如，退休金、工資、福利、需要接受非常專業技能培訓的工作，其工作技能的市場價值等，將使離開組織變得更加困難。對於具有高持續承諾的員工來說，在組織中繼續就業是必要的，承諾與在職行為之間的聯繫的性質可能取決於該行為對就業的影響。例如，一個人如果他或她認為繼續受僱需要這樣的表現，那麼他或她與組織的主要聯繫是高水平的持續承諾，可以替組織付出相當大的努力。

(三)、規範性 (normative) 承諾：是指員工對留在組織的義務感，他們覺得有義務 (obligation) 如此做。留在組織中的義務感源於規範壓力的內化。導致這種義務感的社會化體驗可能始於對榜樣的觀察或組織偶然使用的獎勵和懲罰，例如，家庭方面，強調對雇主保持忠誠重要性的父母，很可能會為他們的孩子對組織做出強烈的規範承諾奠定基礎。在更宏觀的層面上，文化方面，可能會強調集體而不是個人的重要性。組織方面，為新員工提供社交體驗，向他們傳達組織期望和重視員工忠誠度的信息。這些經驗的內化，無論是起源於家庭、文化還是組織，可以用社會學習理論原則或更複雜的心理動力學過程來解釋 (Allen 和 Meyer, 1996; Clugston, 2000; Meyer 和 Allen, 1991)。

三、護理人員組織承諾的相關研究

(一) 組織承諾現況

劉淑如和鄭靜瑜 (2002) 研究結果發現護理人員普遍性對組織認同度不高；而在組織承諾的三個面向方面，護理人員的「情感性承諾」之平均值略高於「規範性承諾」、「持續性承諾」(解旻容等人，2013)。

(二) 組織承諾與心理相關變項

以下回顧與組織承諾有關之心理變項間的關係，尤其是與本研究有關之工作壓力及工作滿意度與組織承諾間的關係，至於組織承諾與員工離職意圖的關係將留至後面小節再行回顧。

1. 組織氛圍與組織承諾

組織氛圍與組織承諾和感知到的組織績效有高度相關。組織氛圍在預測組織承諾和感知到的組織績效方面具有重要意義。組織氛圍是醫療保健環境中員工承諾和員工如何看待組織績效的一個重要因素，這將影響在醫療保健組織中提供服務的成果 (Berberoglu, 2018)。情感性承諾對工作績效有顯著正向影響，規範性承諾和持續性承諾對工作績效無顯著影響 (Kaplan 和 Kaplan, 2018)。

2、工作壓力與組織承諾

研究發現工作壓力與組織承諾有顯著負相關，其中工作壓力與情感性承諾、規範性承諾均為負相關，而與持續性承諾呈正相關（洪淑芬，2014；陳小芳，2012；彭士哲和曾淑萍，2021；Yaghoubi et al., 2009）

黃穗芬等人（2011）對中部某醫學中心護理人員的研究發現，工作壓力越大，組織承諾越低。

陳小芳（2012）以南部某區域教學醫院護理人員進行研究發現，工作壓力與組織承諾有顯著負相關。

3、工作滿意度與組織承諾

洪淑芬（2014）針對南部某家醫學中心的 936 位護理人員，陳怡伶（2016）針對基層診所與醫院 328 位護理人員所進行的研究均發現，組織承諾與工作滿意度有正向顯著關係。

黃珊和王秀紅（2008）對南部不同層級的六家醫院護理人員進行的研究結果顯示，組織承諾與工作滿意度有顯著的正相關。

牛美雲（2005）以宜蘭縣所有加入護理師護士公會之護理人員為調查對象，研究結果顯示護理人員工作滿意與組織承諾呈正相關。

廖茂宏等人（2007）針對北部某區域級醫院護理人員研究發現，對工作滿意度愈高者，對於單位之組織承諾亦愈高。

（三）背景變項

性別、年齡、教育程度、婚姻狀態、服務年資、服務單位類別等是護理人員壓力研究中常被探討的背景變項，以下逐一回顧。

1. 性別

研究發現，在組織承諾的努力承諾面向男性得分高於女性（陳小芳，2012）

2. 年齡

研究發現，護理人員年齡與組織承諾有關聯（黃珊和王秀紅，2008；Labrague et al., 2021；Al-Aameri 和 Ahmed S, 2000），惟有些研究發現組織承諾隨著年齡增加而遞減（劉淑如和鄭靜瑜，2002），而亦有研究發現，隨年齡層的增高，組織承諾也越高（莊蕙琿和楊順富，2011；解旻容等人，2013）。

3. 教育程度

研究發現，不同學歷的護理人員在組織承諾上並無顯著差異（劉淑如和鄭靜瑜，2002），也有研究發現，教育程度與組織承諾顯著關聯（黃珊和王秀紅，2008；Labrague et al., 2021）。

4. 婚姻狀態

研究發現，婚姻狀態亦與組織承諾有關，統計結果顯示未婚者在各層面的組織承諾上皆顯著高過已婚者（劉淑如和鄭靜瑜，2002）。也有研究發現，在組織承諾已婚者最高，單身之護理人員最低，且達顯著差異（莊蕙琿和楊順富，2011）。

5. 服務年資

研究發現，服務年資與組織承諾顯著相關（黃珊和王秀紅，2008）。也有研究發現，以服務 16 年以上者最高，2-5 年者最低，且達顯著差異（莊蕙琿和楊順富，2011）。

6. 單位類別

研究發現，不同部門之護理人員在組織承諾的現況，最高三個部門是「門診、開刀房與麻醉科、婦兒科」，最低三個則是「加護病房、急診、外科」，且各科差異值達顯著差異（莊蕙琿和楊順富，2011）。

根據上述各護理人員組織承諾的相關研究所示，在背景變項方面包含性別、年齡、教育程度、婚姻狀態、服務年資及單位類別等不同變項，而影響護理人員組織承諾的重要因素可區分為情感性承諾、持續性承諾、規範性承諾等三個構面。本研究以 Allen 和 Meyer（1990）的「組織承諾量表」中文版進行研究分析，探討護理人員組織承諾現況，以及在性別、年齡、教育程度、婚姻狀態、服務年資、單位類別等背景變項不同之護理人員在組織承諾上之差異性，並進行後續組織承諾對於工作壓力、工作滿意度、離職意圖的相關性檢視。

第四節 離職意圖

本節從離職意圖的意涵、離職意圖的理論模式、護理人員離職意圖的相關研究等三方面分別敘述。

一、離職意圖的意涵

「人才」是企業成功的關鍵，員工的穩定性是組織能夠順利運作的重要根基，因此，員工離職將對企業經營發展產生不良影響，並造成人力成本的損失，「離職」是人力資源管理中十分重要的議題，員工在離職前通常會透漏出離職傾向，離職傾向是一種意圖，當企業能夠及早偵測到員工的離職傾向時，在管理的層面上也比較能夠產生因應的策略。在護理領域，離職意圖可能產生讓護理人員生產率低、護理條件變差、增加組織成本等（蔡月英等人，2020）。

離職意圖（turnover intention）指的是員工自願退出組織前的意圖（Tett 和 Meyer, 1993），它是離職行為實際產生前的主要預測因子。Takase（2010）指出離職意圖是一個複雜的過程，來自於對特定職業或組織條件產生的負面心理反應，這種反應會演變為決心離開或可能需要放棄目前工作的撤離行為，或採取實際行動以獲得更好就業機會。Mobley（1977）認為離職傾向是指員工在組織工作一段時間後，對現有工作感到不滿足，經過評估後產生離職的想法；Mobley 等人（1978）指出離職傾向是員工經

過主觀評估，想要離開組織進而尋找其他工作的意圖，工作不滿意對離職意圖的影響在於，考慮辭職的意圖，而不是離職本身；Miller 等人（1979）認為離職傾向是員工想離開組織並尋找其他工作機會的態度（陳銘薰和黃新龍，2019；Mobley et al., 1978）。

影響離職傾向的因素十分廣泛，舉凡個人特質、家庭因素、工作滿足、組織承諾及工作壓力等，都有可能成為離職傾向的前導原因，進而形成離職的行為（陳銘薰和黃新龍，2019）。Swanburg（2010）研究發現，離職事件的發生可能受到幾件事的影響，如焦慮和不確定性；無法實現個人和組織目標；相互矛盾的需求；對人際關係的不滿；違反規則、政策和條例；任務的內在性質。工作、能力、過度勞累、個人和職業成長有限（Sari et al., 2021）。

二、離職意圖的理論模式

離職意圖受到許多外部因素的影響和真正的離職行為不同，離職行為發生前，會有離職意圖的產生，因此離職意圖可以用來預測離職行為的發生，以下就不同的理論模式做進一步說明。

（一）（Mobley 和 William H, 1977）員工離職決策模式

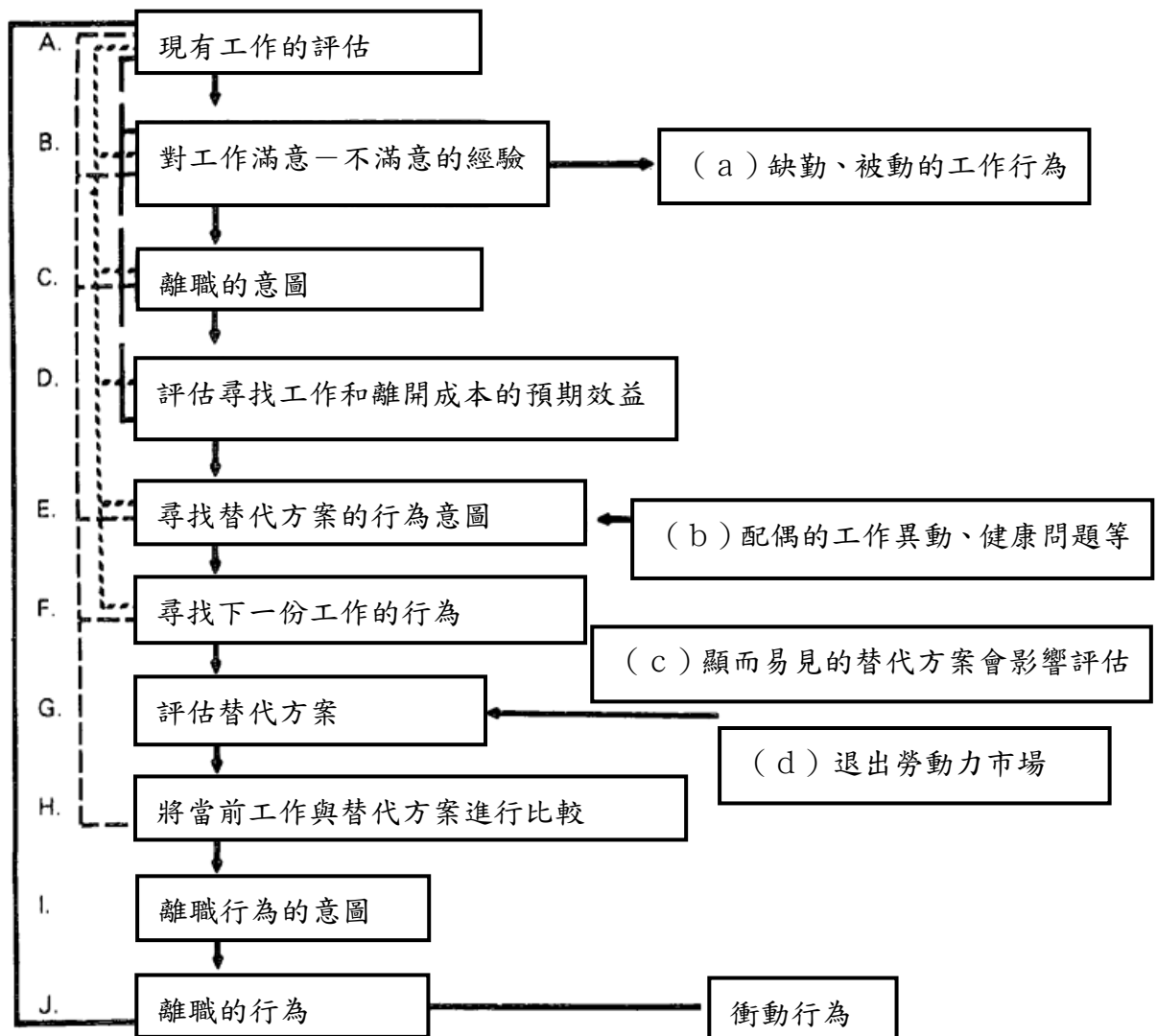
Mobley（1977）提出員工離職決策過程的模式（圖 2-2）。離職決策過程是員工對現有工作產生不滿的情緒到實際產生離職行為前，評估和考慮的過程。

（A）代表評估一個人現有工作的過程；（B）代表某種程度的滿意—不滿意的情緒狀態結果；（C）顯示出不滿的後果之一是刺激離職的意圖，例如，缺勤、被動的工作行為。

（D）離職決策過程的下一步是評估尋找下一份工作和離開成本的預期效益，如果有一定的機會找到替代方案，並且成本不高，那麼下一步，（E）將是尋找替代方案的行為意圖。正如（圖 2-2）中的箭頭（b），與工作無關的因素也可能引起尋找下一份工作的意圖（例如，配偶的工作異動、健康問題等）。尋找下一份工作的意圖之後是實際尋找下一份工作的行為（F）。如果找不到替代方案，個人可能會繼續尋找，重新評估尋找的預期效益，重新評估現有工作，單純地接受當前的狀況，減少辭職的想法，和／或從事其他形式的離職行為（例如、缺勤、被動工作行為）；如果有替代方案，包括（在某些情況下）退出勞動力市場，則會啟動替代方案評估（G）。對替代方案的評估之後，是將當前工作與替代方案進行比較（H）。如果比較有利於替代方案，它將激發（I）離職行為的意圖，然後是實際離職的行為（J）。如果比較有利於目前的工作，個人可能會繼續尋找下一份工作，重新評估尋找下一份工作的預期效益，重新評估現有的工作，單純地接受現狀，減少辭職的想法，和／或從事其他形式離職行為。

圖 2-2

Mobley 員工離職決策過程模式



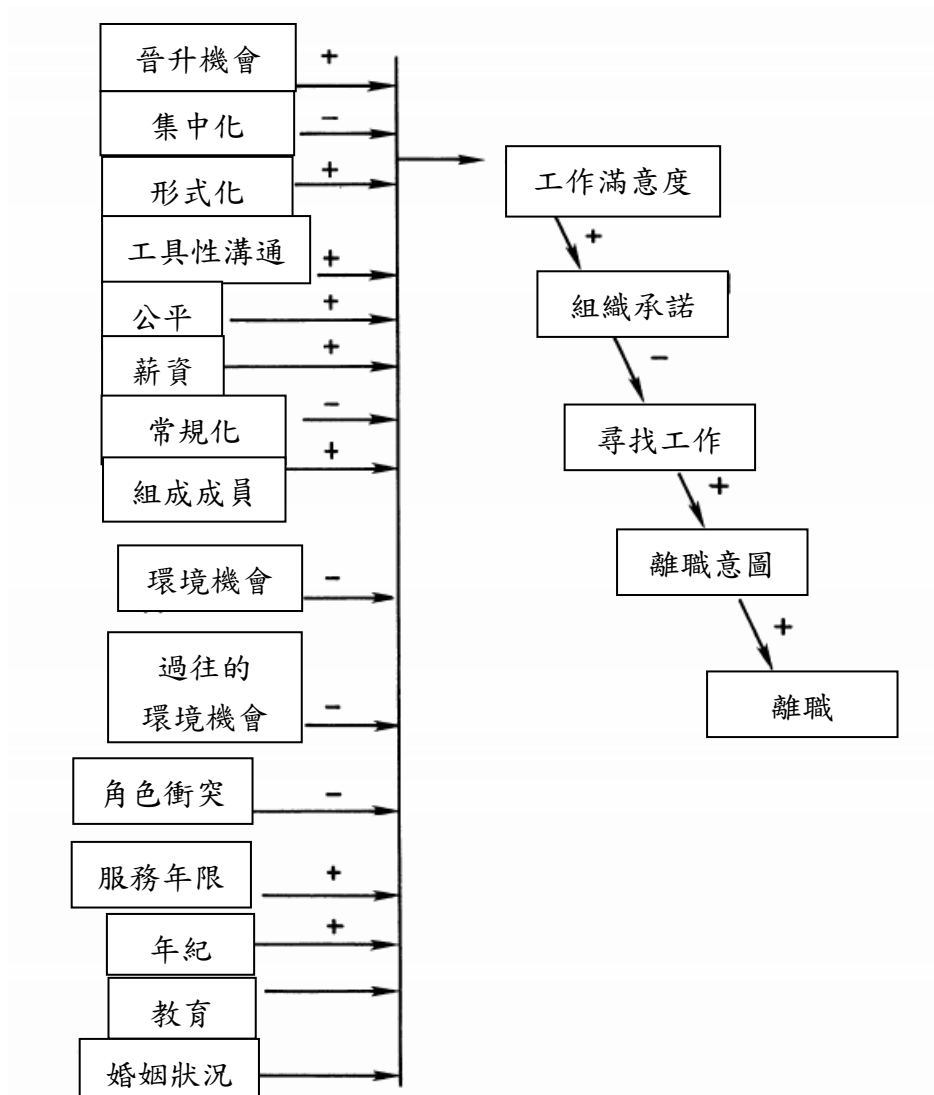
資料來源: Mobley, W. H. (1977). Intermediate linkages in the relationship between job satisfaction and employee turnover. *Journal of applied psychology*, 62(2), 238.

(二) Bluedorn 綜合離職模式

Bluedorn (1982) 提出綜合離職模式，它結合了 Price (1977) 的離職因果模式和 Mobley (1977) 的員工離職決策過程模式，並納入組織承諾變項，而形成一個綜合離職模式（如圖 2-3）。

圖 2-3

Bluedorn 綜合離職模式



資料來源: Bluedorn, A. C.(1982). A unified model of turnover from organizations. *Human relations*, 35(2), 138.

此模式假定組織、環境及個人的前置變項會先影響員工的工作滿意度，繼之再影響組織承諾，最後再影響員工的離職意圖與行為。此綜合模式的前置變項可分為三大類，分別是組織因素（晉升機會、集中化、形式化、工具性溝通、公平、薪資、常規化、組成成員）；環境因素（環境機會、過往的環境機會）；個人因素（角色衝突、服務年限、年紀、教育、婚姻狀況），這些因素對工作滿意產生了正/負向的影響，而工作滿意度對組織承諾有正向影響，組織承諾對尋找工作的意圖有負向影響，進而影響了後續離職意圖和離職行為的產生。在此模式中，工作滿意和組織承諾是三大類前置變項和離職的過程中具有影響的中介變項。本研究亦將參考 Bluedorn (1982) 綜合

離職模式理論中各變項的相關性，提出護理人員從工作壓力到工作滿意再到組織承諾，最後到離職意圖的過程擬定出中介路徑模式。

三、護理人員離職意圖的相關研究

(一) 離職意圖現況

護理人員是影響醫院績效的最重要資產之一，醫院護理人員離職的意圖會削弱護理系統的結構，阻礙護理過程的正確實施。護理人員常見的離職原因為：家庭因素、工作滿意度、工作負荷、工作壓力、執業科別、健康狀態、護病比、照護能力、交通便利性、對未來發展無正面期待、工作無成就感、待遇不合理等(王金蓮等人, 2018; 孫佩娟, 2019; 張靖梅和林獻鋒, 2021; 蔡政廷和林弘昌, 2018)。而護理人員離職時最不满意前五名因素，分別為工作負荷、健康狀態、護病比、照護能力、交通便利性。(施采吟和翁偉楷, 2020; 張靖梅和林獻鋒, 2021)。

(二) 離職意圖與心理相關變項

1、工作壓力與離職意圖

陳梅麗等人(2000)以醫學中心基層護理人員 505 人為對象，進行跨時性研究，發現工作壓力不但與離職有關也是預測離職一個非常重要的變項。

黃穗芬等人(2011)以中部某醫學中心護理人員為對象，研究發現工作壓力與離職傾向是正相關。

陸雅美(2006)以北部、中部、南部、三所醫學中心護理人員為對象，研究發現工作壓力與離職傾向呈現正相關且具顯著意義。

張翠芬等人(2016)以中部六家地區及四家區域醫院的 193 位護理人員為對象，研究結果顯示離職傾向與工作壓力類別之感受度、感受頻率均呈顯著正相關。

2、工作滿意度與離職意圖

張翠芬等人(2016)以中部六家地區及四家區域醫院的 193 位護理人員為對象，研究結果顯示離職意圖與所有工作滿意度類別(工作酬勞、工作環境、自我肯定、醫院管理制度、本質學能)均呈顯著負相關。

陳自立(2005)對高高屏四家地區醫院護理人員進行研究，發現機構內是否有完善的進修制度及定期的訓練機會，是讓護理人員對工作滿意與否的極重要因素，護理人員對機構中的學習成長機會越滿意，離職傾向的意願越低。

Porter 和 Steers (1973) 表示離開意圖可能代表在退出過程中經歷了不滿之後的下一個步驟，在員工離職的研究中顯示，總體滿意度與離職呈負相關。(Mobley 和 William H, 1977; Mobley et al., 1979)。

3. 組織承諾與離職意圖

Porter 等人 (1974) 進行了縱向研究，與工作滿意度的各個組成部分相比，組織承諾更能區分留任者和離職者。情感性和規範性承諾以及對薪酬的滿意度、對晉升的滿意度和對工作性質的滿意度與離職意圖呈顯著負相關，影響離職意圖的變項是情感性承諾，薪水滿意度和規範性承諾 (Luz et al., 2018)。

黃穗芬等人 (2011) 研究發現，護理人員的情感性組織承諾不是影響離職傾向最主要的因素，持續性組織承諾才是重要因素；由於該研究收集資料階段正逢大環境不景氣，因此護理人員基於考量離開組織的成本損失，越認為離開機構會有損自身利益或就業機會者，則越沒有離職傾向。

De Gieter 等人 (2011) 在以醫院護理人員為研究對象的研究中發現，組織承諾顯著預測了護理人員的離職意向。

另外有研究發現護理人員的規範性組織承諾也是影響離職傾向的因素之一，這可能是因為在華人社會文化中的集體規範文化特性，較重視關係與人情，因此，由同儕或人情壓力所形成的規範性組織承諾在組織中更具影響力 (黃穗芬等人, 2011; 張火燦和紀乃文, 2006)。

(三) 背景變項

性別、年齡、教育程度、婚姻狀態、服務年資、服務單位類別等是護理人員壓力研究中常被探討的背景變項，以下逐一回顧。

1. 性別

研究發現，性別與離職意圖無顯著相關 (陳仙媚, 2013)。

2. 年齡

研究發現，離職意圖隨著年齡提升而下降 (王金蓮等人, 2018)，年齡為 25 歲以下，比 25 至 34 歲及 35 歲以上護理人員有較高離職傾向 (陳國瑚等人, 2006)，年齡與離職意圖達顯著負相關 (王雪鳳等人, 2016)。

3. 教育程度

研究發現，大學以上離職意圖較高，專科和高職相對於參考值研究所，離職意圖低且皆達顯著 (王金蓮等人, 2018; 張靖梅和林獻鋒, 2021)，也有研究發現，專科以下學歷的護理人員比起其他較高學歷者，有較高離職傾向 (陳國瑚等人, 2006)，但有其他研究發現，教育程度與離職意圖無顯著差異 (黃慧文, 2017)。

4. 婚姻狀態

黃慧文 (2017) 研究發現，147 位已婚者有 97 位 (66%) 有離職意圖，274 位未婚者有 211 位 (77%) 有離職意圖，婚姻狀況在離職意圖上有顯著差異。研究發現，相較於已婚者，未婚護理人員有較高離職傾向 (陳國瑚等人, 2006)。護理人員之已婚比率愈高，該醫療機構之護理人員離職率愈低 (林谷峻, 2009)。

5. 服務年資

研究發現，年資較長者，相較於新進護理人員之離職傾向來的低而（陳國珣等人，2006），也有研究發現，服務年資與離職意圖無顯著差異（黃慧文，2017）。護理人員之平均服務年資愈高，該醫療機構之護理人員離職率愈低（林谷峻，2009）。

6. 單位類別：

研究發現，開刀房、產房、病房、急診、加護病房，相對於門診有較高的轉業意念（王金蓮等人，2018； 陳國珣等人，2006），也有研究發現，單位類別與離職意圖無顯著差異（黃慧文，2017）。

根據上述各護理人員離職意圖的相關研究所示，經常被探討的背景變項包含性別、年齡、教育程度、婚姻狀態、服務年資及單位類別等。本研究以 Mobley（1977）的離職意圖量表中文版進行研究分析。

第五節 工作壓力、工作滿意度、組織承諾與離職意圖之相關性

本研究探討工作壓力（工作負荷—控制—支持）分量表、工作滿意度、組織承諾與離職意圖的關係，尤其是工作滿意度與組織承諾在工作壓力與離職意圖關係之間的中介角色，前面已回顧兩兩變項之間的關係，本節將回顧工作壓力、工作滿意度與離職意圖，工作壓力、組織承諾與離職意圖，工作壓力、工作滿意度、組織承諾與離職意圖等關係之實徵研究，並提出變項關係的假設中介模型。

一、 工作壓力、工作滿意度與離職意圖

綜合前面各章節文獻所示，工作壓力與工作滿意度呈負相關，工作壓力越大，工作滿意度越低；工作壓力與離職意圖呈正相關，工作壓力越大，離職意圖越高；工作滿意度與離職意圖呈負相關，工作滿意度越低，離職意圖越高。

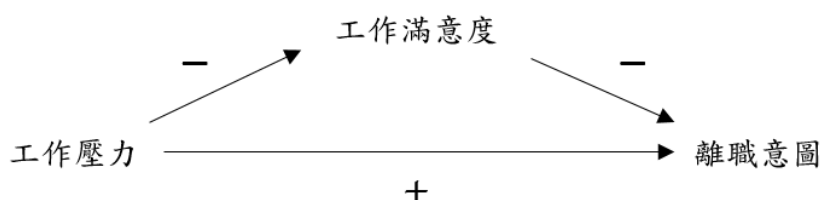
上述皆是兩兩變項間的相關，至於三者間的相關，一年和五年內較高的離職意圖結果和護理人員的心理壓力、工作滿意度有相關。護理人員的離職傾向與工作滿意度呈顯著負相關。工作壓力大、工作滿意度低時，離職意向則愈趨增高（張靖梅和林獻鋒，2021； 張翠芬等人，2016； Sari et al., 2021）。陳欣妤（2021）對國小專任輔導校師的研究發現，工作壓力有可能部分是透過工作滿意度來影響離職意圖。Jou 等人（2013）對航空控制人員和 Ferdian 等人（2020）對印尼的一間私人公司員工的研究發現，工作滿意度對工作壓力來源與離職傾向的關係具有中介作用。張景星（2021）針對精神復健機構專任管理人員的研究發現，內在工作壓力越大時，其外在工作滿意度就越低；外在工作滿意度越高，離職傾向就越低；不同工作壓力面向會透過不同類型的工作滿意度間接或直接影響離職傾向。陸柏憲（2019）研究日月光半導體高雄廠

產線人員發現，工作壓力與離職傾向具有相當程度關聯性，當工作滿意度愈高，則離職傾向愈低。

依據以上實徵研究之回顧，本研究提出三者的關係模式如圖 2-4。工作壓力與工作滿意度呈負相關，工作壓力越大，工作滿意度越低；工作壓力與離職意圖呈正相關，工作壓力越大，離職意圖越高；工作滿意度與離職意圖呈負相關，工作滿意度越低，離職意圖越高。工作壓力會透過工作滿意度的中介路徑影響離職意圖。

圖 2-4

工作壓力、工作滿意度與離職意圖關係模式



二、 工作壓力、組織承諾與離職意圖

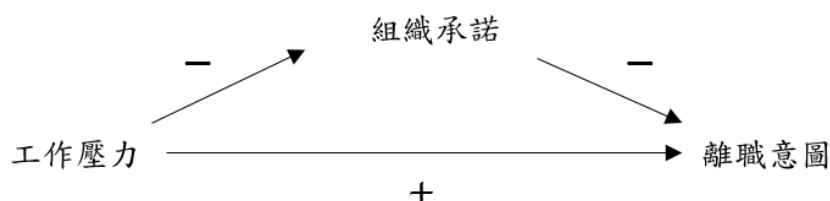
綜合前面各章節文獻所示，工作壓力與組織承諾呈負相關，工作壓力越大，組織承諾越低；工作壓力與離職意圖呈正相關，工作壓力越大，離職意圖越高；組織承諾與離職意圖呈負相關，組織承諾越低，離職意圖越高。

上述皆是兩兩變項間的相關，至於三者間的相關，研究發現，護理人員工作壓力與組織承諾呈顯著負相關；與離職傾向呈顯著正相關，情感性和規範性承諾與離職意圖顯著負相關 (Clugston, 2000; Luz et al., 2018)。當個人承受的工作壓力較低時，可以提升個人的組織承諾，進而降低離職傾向 (沈昭吟和詹昆霖, 2013; 蔡李玉卿, 2009; Husnah 和 Hasyim, 2020; Rindu et al., 2020)。陳銘薰和黃新龍 (2019) 對現職國軍幹部與 Dewi 和 Piartrini (2021) 對民營醫院員工的研究結果發現，組織承諾會中介工作壓力與離職傾向之間的關係。

依據以上實徵研究之回顧，本研究提出三者的關係模式如圖 2-5。工作壓力與組織承諾呈負相關，工作壓力越大，組織承諾越低；組織承諾與離職意圖呈負相關，組織承諾越高，離職意圖越低；工作壓力與離職意圖呈正相關，工作壓力越大，離職意圖越高。工作壓力會透過組織承諾的中介路徑影響離職意圖。

圖 2-5

工作壓力、組織承諾與離職意圖關係模式



三、 工作壓力、工作滿意度、組織承諾與離職意圖

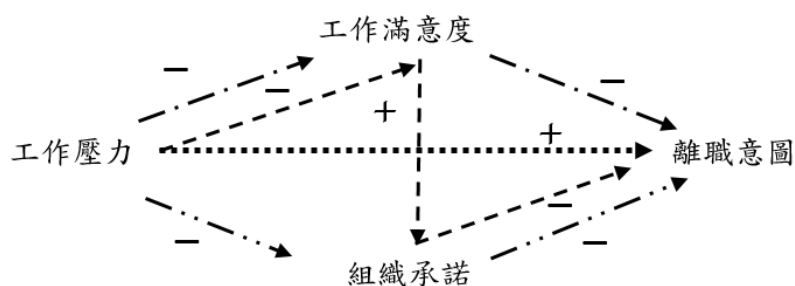
黃穗芬（2011）針對護理人員的研究發現，護理人員工作壓力並不是影響離職傾向主要因素，工作滿意度和組織承諾才是重要因素。陳欣妤（2021）對國小專任輔導校師的研究發現，內在工作壓力會透過降低對激勵因素的滿意度，再降低正向情感性承諾，最後再提高離職意圖。

綜合前面各章節文獻所示，工作壓力與工作滿意度呈負相關，工作壓力越大，工作滿意度越低；工作壓力與組織承諾呈負相關，工作壓力越大，組織承諾越低；工作滿意度與組織承諾呈正相關，工作滿意度越高，組織承諾越高；工作滿意度與離職意圖呈負相關，工作滿意度越低，離職意圖越高；組織承諾與離職意圖呈負相關，組織承諾越高，離職意圖越低；工作壓力與離職意圖呈正相關，工作壓力越大，離職意圖越高。

由於文獻中較少同時探討四個變項間的路徑關係，故本研究將根據四個變項間的兩兩關係，提出四者的中介模型（圖 2-6），模型中工作壓力會透過三條間接中介路徑影響離職意圖，除了前面提出的「工作壓力→工作滿意度→離職意圖」、「工作壓力→組織承諾→離職意圖」的兩條中介路徑外，以 Bluedorn（1982）的綜合離職模式為參考依據，提出工作壓力會透過先影響工作滿意度，接著再影響組織承諾的序列性間接中介效果路徑影響離職意圖「工作壓力→工作滿意度→組織承諾→離職意圖」。

圖 2-6

工作壓力、工作滿意度、組織承諾與離職意圖關係圖



第三章 研究方法

本章分為五節：研究架構及研究假設、研究對象、研究工具、研究程序及資料處理與分析，分別說明如下。

第一節 研究架構及研究假設

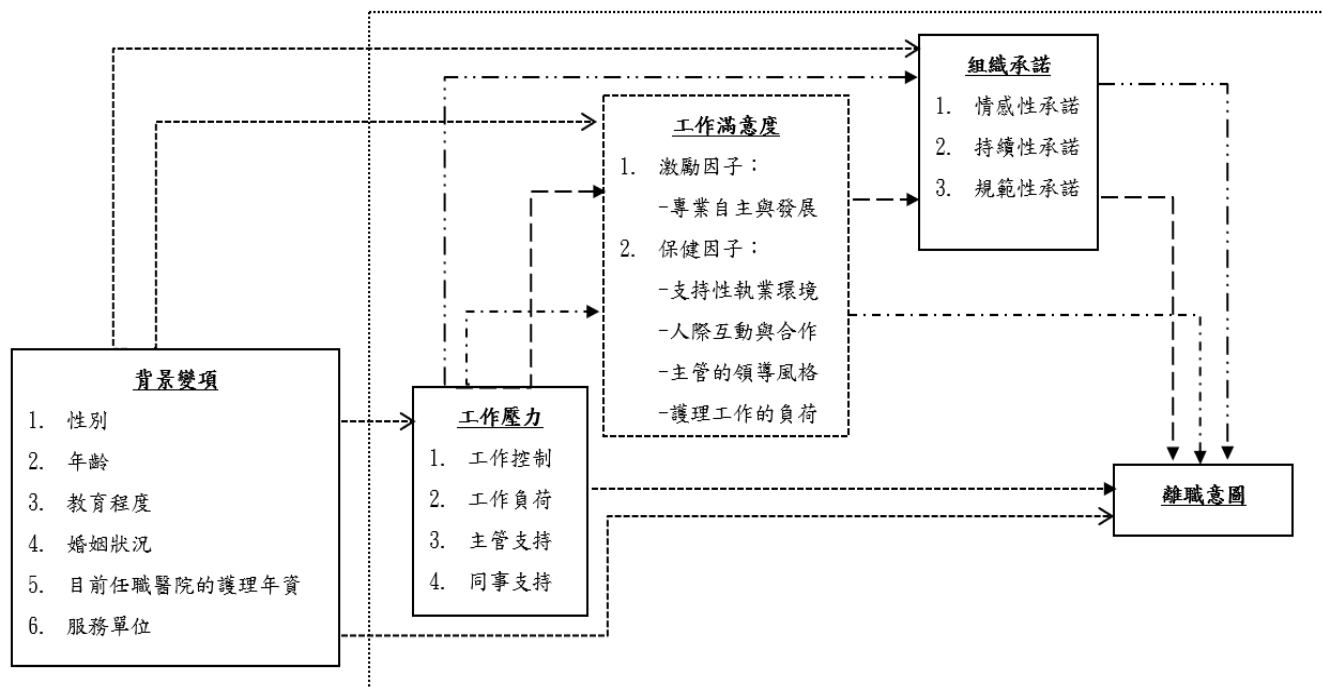
一、研究架構

本研究主要在探討護理人員的工作壓力、組織承諾、工作滿意度與離職意圖之現況；背景變項不同之護理人員在四個變項上之差異；四個變項之間的相關；背景變項、工作壓力、工作滿意度與組織承諾對離職意圖之解釋力；以及工作滿意度和組織承諾是否為工作壓力及離職意圖之序列中介變項。

本研究擬出之研究架構如圖 3-1，其中虛線部分為工作壓力至工作滿意度、組織承諾，再至離職意圖的中介模型。

圖 3-1

研究架構圖



二、研究假設

在前述研究架構下，本研究擬提出下述研究假設：

假設 1：不同背景之護理人員在工作壓力、工作滿意度、組織承諾與離職意圖上有顯著差異。

1-1 不同性別的護理人員在工作壓力、工作滿意度、組織承諾與離職意圖上有顯著差異。

1-2 不同年齡的護理人員在工作壓力、工作滿意度、組織承諾與離職意圖上有顯著差異。

1-3 不同教育程度的護理人員在工作壓力、工作滿意度、組織承諾與離職意圖上有顯著差異。

1-4 不同婚姻狀況的護理人員在工作壓力、工作滿意度、組織承諾與離職意圖上有顯著差異。

1-5 不同服務年資的護理人員在工作壓力、工作滿意度、組織承諾與離職意圖上有顯著差異。

1-6 不同單位類別的護理人員在工作壓力、工作滿意度、組織承諾與離職意圖上有顯著差異。

假設 2：護理人員之工作壓力、工作滿意度、組織承諾與離職意圖上有顯著相關。

假設 3：護理人員之背景變項、工作壓力、工作滿意度及組織承諾能有效解釋其離職意圖。

假設 4：護理人員之工作滿意度及組織承諾為工作壓力和離職意圖之序列中介變項，其中工作壓力先間接影響工作滿意度，再影響組織承諾，最後影響離職意圖。

第二節 研究對象

依據台灣全民健康保險分級制度分類，目前國內之醫療院所分成四個層級，分別為基層診所、地區醫院、區域醫院及醫學中心。考量不同層級醫院之屬性、規模及管理制、規範可能不同，研究者僅採用任職之醫療體系所屬之北、中、南區的各家地區醫院為對象（醫院屬性、規模及管理制、規範同質性較高），在該醫療體系所屬各家地區醫院任職滿三個月且通過試用期之正職護理人員共計 378 人。本研究採取方便取樣，在發放問卷前，先各別聯繫體系所屬之北、中、南區的各院區護理主管，並說明研究目的及本問卷採不具名方式，由護理人員依照個人意願參與填寫，問卷資料僅提供本研究分析用，不做個別的探討，對所取得的資料絕對保密，在取得各院區護

理主管同意後，以郵寄方式發放及回收問卷，發放問卷 378 份，回收問卷 367 份，回收率達 97.1%，無效問卷共 39 份，以有效問卷共計 328 份進行正式分析。表 3-1 為該醫療體系所屬之北、中、南區地區醫院數目及發放問卷和回收問卷數。

表 3-1

某醫療體系所屬之北、中、南區地區醫院數目及發放問卷和回收問卷數

區域	北區	中區	南區	合計
醫院數目	7	1	4	12
發放問卷數	264	14	100	378
回收問卷數	253	14	100	367

表 3-2

研究對象之背景變項的次數分配表

變項	類別	人數（人）	比例（%）
性別	女	313	95.4
	男	15	4.6
教育程度	高職	11	3.4
	專科	151	46
	大學	161	49.1
	碩士或以上	5	1.5
婚姻狀況	未婚	149	45.4
	已婚	163	49.7
	同居	7	2.1
	離異或鰥寡	9	2.7
服務單位	加護病房	28	8.5
	一般病房	56	17.1
	呼吸照護病房	113	34.5
	開刀房	22	6.7
	洗腎室	11	3.4
	門診	79	24.1
	健檢	10	3.0
	其他	9	2.7

註：n = 328

表 3-2 為研究對象之背景變項的次數分配表，根據表 3-2 所示，護理人員以女性居多，佔了 95.4%；教育程度以大學學歷居多，佔了 49.1%，專科學歷次之，佔了 46%；婚姻狀況方面以已婚居多，佔了 49.7%；服務單位以呼吸照護病房居多，佔了 34.5%，門診次之，佔了 24.1%。

表 3-3

研究對象之背景變項（年齡及目前任職醫院的護理年資）的統計資料

變項	人數	平均數	標準差	最大值	最小值
年齡	328	36	8.472	61	20
目前任職醫院的護理年資	328	8.5	6.783	35	0.3

根據表 3-3 所示，年齡平均為 36 歲，年紀最小為 20 歲，最大為 61 歲；任職醫院的護理年資平均為 8.5 年，最少為 0.3 年，最多為 35 年。接著再將年齡及目前任職醫院的護理年資進行分組，每個變項分為 3 組，如表 3-4 所示，年齡分成（20-30 歲／31-40 歲／大於 40 歲）3 組，目前任職醫院的護理年資分成（5 年以下／5-10 年／10 年以上）3 組。

表 3-4

研究對象之背景變項（年齡及目前任職醫院的護理年資）的次數分配表

變項	類別	人數（人）	比例（%）
年齡	20-30 歲	109	33.2
	31-40 歲	119	36.3
	大於 40 歲	100	30.5
目前任職醫院的 護理年資	5 年以下	115	35.0
	5-10 年	119	36.3
	10 年以上	94	28.7

第三節 研究工具

本研究所使用的工具包含「基本資料」、「工作壓力（工作負荷—控制—支持）分量表」、「工作滿意度量表」、「組織承諾量表」、「離職意圖量表」五個部分。

一、基本資料

本研究分析的基本資料包含：性別、年齡、教育程度、婚姻狀況、目前任職醫院的護理年資、服務單位。

二、工作壓力（工作負荷—控制—支持）分量表

中文版「工作特質量表」已被運用在醫療機構員工和護理人員的工作壓力相關研究中（洪淑芬，2014；陳怡光等人，2013；錢才瑋等人，2012），本研究採用的是臺灣大學健康政策與管理研究所鄭雅文教授開發的中文版量表「工作特質量表」（曾慧萍和鄭雅文，2002；Cheng et al., 2003）測量護理人員的工作壓力。此中文版量表（公共版）係由鄭等根據 Karasek 所發展的「工作特質量表」（Job Content Questionnaire, JCQ）（1998）進行翻譯和開發，含 25 個題目，測量四個主要面向：工作控制（9 題）（例題：在工作中，我需要學習新的事物）；工作負荷（8 題）（例題：我的工作場所有人力不足的現象）；主管支持（4 題）（例題：我的主管關心部屬的福利）；同事支持（4 題）（例題：我的同事會幫忙我的工作）。量表採用 Likert 四分點量表，分為 1 分「很不同意」、2 分「不同意」、3 分「同意」及 4 分「很同意」作答，部份題目為反向題，先進行分數轉置後再進行加總及統計分析。

「工作特質量表」（Job Content Questionnaire, JCQ）中文版量表，除了「心理負荷量」內部一致性較差外（男女性 Cronbach α 值為 .58 與 .61），其他在「工作控制」與「社會支持」的 Cronbach α 值均尚可達 .65 以上（曾慧萍、鄭雅文，2002），錢才瑋等人（2012）「技能裁量權」的 Cronbach α 值為 .73，「決策自主權」的 Cronbach α 值為 .57，「心理負荷量」的 Cronbach α 值為 .81，「主管支持」的 Cronbach α 值為 .88，「同事支持」的 Cronbach α 值為 .84。本研究「工作控制」Cronbach α 值為 .64，「工作負荷」Cronbach α 值為 .77，「主管支持」Cronbach α 值為 .90，「同事支持」Cronbach α 值為 .90，整體信度 Cronbach α 值為 .79。

三、工作滿意度量表

本研究採用曾雯琦等人（2017）所建立的「台灣醫院護理師工作滿意度量表」作為研究工具，該量表從歸納護理工作滿意度的主要概念，然後參考國內學術研究成果及臨床實施工作滿意度調查的現況，建構本土性醫院護理師工作滿意度量表，最後對量表進行信效度前驅測試。該滿意度量表共有 31 題，分為五個面向：支持性執業環境（9 題）（例題：我對於工作環境的安全性感到...）；專業自主與發展（9 題）（例題：我對於工作的專業自主感到...）；人際互動與合作（6 題）（例題：我對於與其他醫事人員的互動情形感到...）；主管的領導風格（4 題）（例題：我對於直屬護理主管的支持與關懷感到...）；以及護理工作的負荷（3 題）（例題：我對於目前護理專業的工作量感到...）。量表以 Likert 五點量表計分，分為 1 分「非常不滿意」、2 分「不滿意」、3 分「普通」、4 分「滿意」及 5 分「非常滿意」。

「台灣醫院護理師工作滿意度量表」經探索性因素分析，得到五個因素，進行內在一致性信度分析，結果因素一 Cronbach α 值為 .93，因素二為 .93，因素三為 .88，因素四為 .95，因素五為 .86，整體信度 Cronbach α 值為 .96。本研究結果因素一 Cronbach α 值為 .91，因素二為 .87，因素三為 .88，因素四為 .93，因素五為 .81，整體信度 Cronbach α 值為 .95。

四、組織承諾量表

本研究採用 Allen 和 Meyer (1990) 發展之「組織承諾量表」(Three-Component Model (TCM) Employee Commitment Survey)，由研究者自行翻譯為中文，並經精通中英文之學者檢核。該量表分成「情感性承諾」、「持續性承諾」及「規範性承諾」三個構面，共計 24 題，分別為：情感性組織承諾 (8 題) (例題：我會很高興能在這間醫院渡過日後的職業生涯)；持續性組織承諾 (8 題) (例題：如果我現在離開醫院，也不會有太多的損失)；規範性組織承諾 (8 題) (例題：我曾被教導要對一間醫院維持忠誠度)。量表以 Likert 五點量表計分，分為 1 分「非常不同意」、2 分「不同意」、3 分「沒意見」、4 分「同意」及 5 分「非常同意」。

「組織承諾量表」進行內在一致性信度分析，結果「情感性承諾」Cronbach α 值為 .82、「持續性承諾」Cronbach α 值為 .68 及「規範性承諾」Cronbach α 值為 .83 (成亮等人, 2008)，整體信度 Cronbach α 值為 .82 (林靖瑛, 2016)。本研究結果「情感性承諾」Cronbach α 值為 .70、「持續性承諾」Cronbach α 值為 .78 及「規範性承諾」Cronbach α 值為 .72，整體信度 Cronbach α 值為 .85。

五、離職意圖量表

本研究採用 Mobley (1977) 提出的離職意圖量表，由研究者自行翻譯為中文，並經精通中英文之學者檢核。量表共計 4 題 (例題：我時常考慮要離開這家醫院)。量表以 Likert 五點量表計分，分為 1 分「非常不同意」、2 分「不同意」、3 分「沒意見」、4 分「同意」及 5 分「非常同意」。

「離職意圖量表」經國內多位研究者使用，整體信度 Cronbach α 值為 .72—.87 (林靖瑛, 2016; 張景星, 2021; 黃穗芬等人, 2011)。本研究結果整體信度 Cronbach α 值為 .69。

第四節 研究程序

本研究程序分為七個階段，依序如下所示：

一、文獻探討

先針對護理人員工作壓力相關文獻進行蒐集，與指導教授討論並擬定研究方向，依研究方向進行國內外文獻資料蒐集與彙整分析，作為本研究的理論依據。

二、確立研究架構

蒐集完國內外文獻資料，擬定研究架構並與指導教授討論研究架構，修訂研究主題和相關變項，確立研究架構。

三、撰寫研究計畫

蒐集並閱讀國內外相關文獻，進行文獻資料統整與分析，將相關理論彙整運用在研究計畫中。

四、研究工具

本研究採用鄭雅文（2002）研發的中文版「工作特質量表」（Job Content Questionnaire, JCQ）；曾雯琦等人（2017）所建立的「台灣醫院護理師工作滿意度量表」；Allen 和 Meyer（1990）發展之「組織承諾量表」（Three-Component Model (TCM) Employee Commitment Survey）及 Mobley（1977）提出的離職意圖量表，由研究者自行翻譯為中文，並經精通中英文之學者檢核，製訂本研究所需之問卷。

五、進行施測階段

本研究進行問卷資料施測蒐集前，先與各家醫院護理主管聯繫，取得各家醫院護理主管同意後，以郵寄問卷方式對同意接受施測之醫院進行資料蒐集。

六、資料分析與討論

將回收之問卷進行整理、編碼、歸類，採用 SPSS22.0 版統計軟體進行統計分析，並撰寫結果及討論。

七、研究結論撰寫與建議

將研究結果歸納彙整，最後提出本研究之結論及建議，由指導教授審視後，增修內容，完成論文撰寫。

第五節 資料處理與分析

本問卷的目的在于了解護理人員工作壓力、工作滿意度、組織承諾與離職意圖之現況及關係進行研究。以下針對研究問題，說明使用的統計分析方法。

一、以描述性統計回答研究問題一

針對護理人員「工作壓力(工作負荷—控制—支持)分量表」、「工作滿意度量表」、「組織承諾量表」與「離職意圖量表」，以平均值與標準差來描述各試題及分測驗之集中及分散的情況，藉此了解護理人員工作壓力、工作滿意度、組織承諾與離職意圖之現況。

二、以變異數分析回答研究問題二

(一)以多變量單因子變異數分析(MANOVA)考驗不同背景變項的護理人員在工作壓力、工作滿意度及組織承諾上的差異，若達顯著，則針對各個分量表進行單因子變異數分析(ANOVA)。若單因子變異數分析也達顯著，且組別超過三組或以上，則進行 Scheffé 事後比較。

(二)以單因子變異數分析(ANOVA)考驗不同背景變項的護理人員在離職意圖(單向度總分)上是否有顯著差異。

三、以 Pearson 積差相關回答研究問題三

以 Pearson 積差相關探討護理人員工作壓力、工作滿意度、組織承諾與離職意圖之相關情形。

四、以階層迴歸分析回答研究問題四

以階層迴歸探討護理人員背景變項、工作壓力、工作滿意度及組織承諾對離職意圖之解釋力。分析前，所有類別變項皆以虛擬變項處理。

五、以路徑分析回答研究問題五

以路徑分析檢視工作滿意度及組織承諾為離職意圖之序列中介變項，表示工作壓力先透過影響工作滿意度，再影響組織承諾，最後影響離職意圖。

第四章 研究結果

本章分為五節：第一節呈現護理人員在工作壓力、工作滿意度、組織承諾與離職意圖之現況分析結果；第二節則呈現不同背景之護理人員在工作壓力、工作滿意度、組織承諾與離職意圖上的差異性分析結果；第三節呈現護理人員工作壓力、工作滿意度、組織承諾與離職意圖之相關分析結果；第四節呈現護理人員背景變項、工作壓力、工作滿意度和組織承諾對離職意圖之迴歸分析結果；第五節呈現工作壓力與離職意圖關係中工作滿意度及組織承諾之序列中介模型分析結果。

第一節 護理人員在工作壓力、工作滿意度、組織承諾與離職意圖之現況分析

一、護理人員在工作壓力各分量表及試題上的現況

根據 Karasek 與 Theorell (1990) 提出的負荷—控制—支持模式 (JDCS model) 得知，工作負荷是造成外在壓力增加的重要因素，而工作控制則是減少外在壓力的重要因素，社會支持即透過團體成員的力量來產生壓力調節，故採用中文版「工作特質量表」(曾慧萍和鄭雅文，2002) 測量護理人員在知覺工作壓力的四個面向：工作控制、工作負荷、主管支持和同事支持(社會支持)的感受程度。

表 4-1 為護理人員在工作壓力(工作負荷—控制—支持)各分量表及試題上的平均數與標準差。從表 4-1 整體 4 個分量表可以得知，「同事支持」的分量表平均數最高 ($M=3.10$)，其次是「主管支持」($M=2.94$)，第三是「工作負荷」($M=2.82$)，在「工作控制」分量表的平均數為最低 ($M=2.68$)。結果顯示護理人員工作壓力(4 等級計分)，在與壓力調節有關的社會支持「同事支持」、「主管支持」平均分數屬中度偏高，與外在壓力增加有關的「工作負荷」平均分數屬中度略偏高，而和減少外在壓力有關的「工作控制」平均分數屬中度。

從工作壓力(工作負荷—控制—支持)各分量表內試題來看，平均數最高的「同事支持」分量表共四題，其平均數介於 3.03~3.15，由各題平均數顯示出護理人員在知覺與壓力調節有關的同事支持感受上，有中度偏高的程度，第 25 題「我的同事會幫忙我的工作」和第 24 題「我的同事很友善」知覺到的同事支持感受程度最高。

表 4-1

護理人員在工作壓力各分量表及試題上的平均數與標準差

分量表與題號	平均數	標準差	分量表	
			平均數	標準差
一 工作控制				
1. 在工作中，我需要學習新的事物	3.14	.520	2.68	.305
2. 我的工作內容，很多是重複性的工作（R）	1.82	.500		
3. 在工作中，我必須具有創新的想法	2.77	.583		
4. 在工作中，很多事我可以自己作主	2.77	.663		
5. 我的工作需要高度的技術	2.93	.591		
6. 對於如何執行我的工作，我沒有什麼決定權（R）	2.65	.642		
7. 我的工作內容是很多元多樣的	2.81	.630		
8. 對於工作上發生的事，我的意見具有影響力	2.63	.627		
9. 在工作中，我有機會發展自己特殊的才能	2.61	.626		
二 工作負荷				
10. 我的工作步調很快	2.97	.630	2.82	.405
11. 我的工作很辛苦	2.89	.682		
12. 我的工作不會過量（R）	2.46	.676		
13. 我有足夠的時間來完成工作（R）	2.19	.558		
14. 我的工作需要長時間集中注意力	3.06	.546		
15. 我的工作非常忙碌	3.02	.637		
16. 我的工作場所有人力不足的現象	3.06	.786		
17. 我的工作很耗體力	2.91	.689		
三 主管支持				
18. 我的主管關心部屬的福利	2.86	.690	2.94	.556
19. 我的主管會聽取我的意見	2.92	.642		
20. 我的主管能協助部屬做事	2.99	.626		
21. 主管會組織部屬工作	2.98	.574		
四 同事支持				
22. 我的同事很稱職	3.03	.555	3.10	.461
23. 我的同事關心我	3.09	.517		
24. 我的同事很友善	3.14	.499		
25. 我的同事會幫忙我的工作	3.15	.533		

註：R 表示反向題，試題分數為轉向後的分數。

從「主管支持」分量表內試題來看，此分量表共四題，其平均數介於 2.86~2.99，由各題平均數顯示出護理人員在知覺與壓力調節有關的主管支持感受上，有中度偏高的程度，其中第 20 題「我的主管能協助部屬做事」和第 21 題「主管會組織部屬工作」知覺到的主管支持感受程度最高。

以「工作負荷」分量表內試題來看，此分量表共八題，其平均數介於 2.19~3.06，由各題平均數顯示出護理人員在知覺與造成外在壓力增加有關的工作負荷感受上，有中度略偏高的程度，其中第 14 題「我的工作需要長時間集中注意力」、第 16 題「我的工作場所有人力不足的現象」、第 15 題「我的工作非常忙碌」知覺到的工作負荷感受程度較高。

而「工作控制」此分量表共九題，以分量表內試題來看，其平均數介於 1.82~3.14，由各題平均數顯示出護理人員在知覺與減少外在壓力有關的工作控制感受上，有中度的程度，其中第 1 題「在工作中，我需要學習新的事物」、第 5 題「我的工作需要高度的技術」、第 7 題「我的工作內容是很多元多樣的」知覺到的工作控制感受程度較高。

整體而言，護理人員工作壓力（工作負荷—控制—支持）分量表的四個面向：工作控制、工作負荷、主管支持和同事支持（社會支持）中，與壓力調節有關的社會支持「同事支持」（如：我的同事會幫忙我的工作、關心我、很友善、很稱職等）、「主管支持」（如：我的主管能協助、組織部屬工作、會聽取部屬意見、關心部屬福利等）的平均分數屬中度偏高，與外在壓力增加有關的「工作負荷」（如：工作需要長時間集中注意力、工作場所人力不足、工作非常忙碌、步調很快等）的平均分數屬中度略偏高，而和減少外在壓力有關的「工作控制」（如：在工作中，我需要學習新的事物、需要高度的技術、內容是很多元多樣的）的平均分數屬中度，表示護理人員在工作中，工作壓力的四個面向以知覺到同事支持和主管支持的感受程度較高，而在知覺工作負荷的感受程度上又高過於工作控制。

二、護理人員在工作滿意度各分量表及試題上的現況

工作滿意度量表的試題填答方式，是藉由受試者對每一題試題的內容感到滿意程度（非常不滿意、不滿意、普通、滿意、非常滿意）（5 等級計分）的方式來填答（如：我對於機構提供的個人防護設施及配備感到...），表 4-2 為護理人員在工作滿意度各分量表及試題上的平均數與標準差。從表 4-2 整體 5 個分量表可以得知「人際互動與合作」的分量表平均分數最高（ $M=3.59$ ），其次是「主管的領導風格」（ $M=3.53$ ），第三是「專業自主與發展」（ $M=3.45$ ），第四是「護理工作的負荷」（ $M=3.25$ ），在「支持性執業環境」分量表的平均分數為最低（ $M=3.20$ ）。結果顯示護理人員工作滿意度，在與激勵因子有關的「專業自主與發展」和與保健因子中人際有關的「人際互動與合作」、「主管的領導風格」、保健因子中環境有關的「護理工作的負荷」、「支持性執業環境」上平均分數均屬中度略偏高。

從工作滿意度各分量表內試題來看，滿意度最高的「人際互動與合作」分量表共六題，其平均數介於 3.44~3.74 屬中度略偏高，由各題平均數顯示出護理人員對於與醫療相關人員尤其是護理同儕間的共同合作和互動感到高度滿意，其中第 21 題「我對於與護理人員共同合作情形感到...」的滿意度最高；而第 23 題「我對於我的工作受到跨團隊成員的相互尊重感到...」的滿意度最低。

表 4-2

護理人員在工作滿意度各分量表及試題上的平均數與標準差

分量表與題號	平均數	標準差	分量表	
			平均數	標準差
一 支持性執業環境				
1. 我對於機構提供的個人防護設施及配備感到	3.41	.753	3.20	.569
2. 我對於各項作業的資訊化感到	3.02	.811		
3. 我對於工作環境的安全性感到	3.24	.753		
4. 我對於機構提供醫療設備的品項及數量感到	3.17	.793		
5. 我對於機構提供病人的照護模式感到	3.31	.721		
6. 我對於機構支持護理人員進修感到	3.29	.729		
7. 我對於機構提供的專業訓練感到	3.29	.695		
8. 我對於服務機構的退休制度感到	3.01	.742		
9. 我對於職位的升遷機會感到	3.06	.714		
二 專業自主與發展				
10. 我對於現有的薪資報酬感到	2.97	.840	3.45	.452
11. 我對於能自我掌握工作的狀況感到	3.52	.616		
12. 我對於自己處理危機的能力感到	3.50	.605		
13. 我對於工作的專業自主感到	3.56	.592		
14. 我對於自己有參與各項重要決策的機會感到	3.33	.632		
15. 我對於自己的工作能力能獲得同儕的認同與肯定感到	3.61	.580		
16. 我對於自己的工作能力能獲得主管的認同與肯定感到	3.52	.590		
17. 我對於能從工作上獲得成就感感到	3.55	.639		
18. 我對於在工作上能得到學習的機會感到	3.51	.654		
三 人際互動與合作				
19. 我對於與其他醫事人員的互動情形感到	3.66	.588	3.59	.492
20. 我對於與醫師共同合作情形感到	3.54	.594		
21. 我對於與護理人員共同合作情形感到	3.74	.584		
22. 我對於與行政人員的互動情形感到	3.52	.620		
23. 我對於我的工作受到跨團隊成員的相互尊重感到	3.44	.684		
24. 我對於與護理同儕的互動情形感到	3.66	.654		
四 主管的領導風格				
25. 我對於直屬護理主管的支持與關懷感到	3.59	.697	3.53	.673
26. 我對於直屬護理主管的領導能力感到	3.60	.727		
27. 我對於直屬護理主管有能力凝聚團隊向心力感到	3.53	.745		
28. 我對於直屬護理主管能公平與合理的對待感到 (如：升遷、考核、獎勵及福利等)	3.41	.776		
五 護理工作的負荷				
29. 我對於目前非護理專業的工作量感到	3.11	.697	3.25	.545
30. 我對於目前護理專業的工作量感到	3.31	.622		
31. 我對於自己承擔目前護理工作的困難度感到	3.32	.590		

從「主管的領導風格」分量表內試題來看，此分量表共四題，其平均數介於 3.41~3.60 屬中度略偏高，其中第 26 題「我對於直屬護理主管的領導能力感到...」的滿意度最高；其次是第 25 題「我對於直屬護理主管的支持與關懷感到...」；而第 28 題「我對於直屬護理主管能公平與合理的對待感到...（如：升遷、考核、獎勵及福利等）」在分量表中的滿意度最低。

以「專業自主與發展」分量表內試題來看，此分量表共九題，其平均數介於 2.97~3.61 屬中度略偏高，其中第 15 題「我對於自己的工作能力能獲得同儕的認同與肯定感到...」、第 13 題「我對於工作的專業自主感到...」、第 17 題「我對於能從工作上獲得成就感感到...」的滿意度較高；而第 10 題「我對於現有的薪資報酬感到...」的滿意度最低。

從「護理工作的負荷」分量表內試題來看，此分量表共三題，其平均數介於 3.11~3.32 屬中度略偏高，其中第 31 題「我對於自己承擔目前護理工作的困難度感到...」的滿意度最高；而第 29 題「我對於目前非護理專業的工作量感到...」在分量表中的滿意度最低。

而「支持性執業環境」此分量表共九題，以分量表內試題來看，其平均數介於 3.01~3.41 屬中度略偏高，其中第 1 題「我對於機構提供的個人防護設施及配備感到...」的滿意度最高；而第 8 題「我對於服務機構的退休制度感到...」、第 2 題「我對於各項作業的資訊化感到...」和第 9 題「我對於職位的升遷機會感到...」的滿意度較低。

整體而言，透過工作滿意度各分量表可得知「人際互動與合作」（如：與護理人員、與醫師、與其他醫療相關人員的共同互動合作情形等）的平均分數最高，其次是「主管的領導風格」（如：對於直屬護理主管的領導能力、支持與關懷、凝聚團隊向心力等），第三是「專業自主與發展」（如：對於自己的工作能力能獲得同儕的認同與肯定、工作的專業自主、能從工作上獲得成就感等），第四是「護理工作的負荷」（如：承擔目前護理工作的困難度、目前護理或非護理專業的工作量等），平均分數最低的是「支持性執業環境」（如：服務機構的退休制度、各項作業的資訊化、職位的升遷機會等）。

三、護理人員在組織承諾各分量表及試題上的現況

表 4-3 為護理人員在組織承諾各分量表及試題上的平均數與標準差。從表 4-3 整體 3 個分量表可以得知，「情感性承諾」在組織承諾的分量表中平均分數最高（ $M = 3.17$ ），其次是「持續性承諾」（ $M = 3.00$ ），而「規範性承諾」分量表的平均分數為最低（ $M = 2.84$ ）。結果顯示護理人員組織承諾（5 等級計分），在「情感性承諾」和「持續性承諾」上平均分數屬中度，而「規範性承諾」則屬中度略偏低。

從組織承諾各分量表內試題來看，平均分數最高的「情感性承諾」分量表共八題，其平均數介於 2.65~3.41，第 2 題「我很樂於跟外人談論我工作的醫院」的組織承諾程度最高；而第 3 題「我真的覺得這間醫院的問題就是我自己的問題」在分量表中的組織承諾程度最低。

表 4-3

護理人員在組織承諾各分量表及試題上的平均數與標準差

分量表與題號	平均數	標準差	分量表	
			平均數	標準差
一 情感性承諾				
1. 我會很高興能在這間醫院渡過日後的職業生涯	3.35	.747	3.17	.447
2. 我很樂於跟外人談論我工作的醫院	3.41	.757		
3. 我真的覺得這間醫院的問題就是我自己的問題	2.65	.927		
4. 我覺得我可以輕易地對其他醫院產生像對目前醫院一般的歸屬感（R）	3.07	.787		
5. 我覺得我並非這間醫院大家庭中的一份子（R）	3.38	.740		
6. 我對這間醫院並沒有情感上的依附（R）	3.27	.783		
7. 這間醫院對我個人有極大的意義	3.12	.777		
8. 我對於我們的醫院並沒有強烈的歸屬感（R）	3.13	.795		
二 持續性承諾				
9. 我不害怕如果我辭掉工作會無人遞補（R）	2.55	.866	3.00	.553
10. 即使我想離開這間醫院，我也很難馬上做到	3.25	.844		
11. 如果我決定現在就離開醫院，我生活中太多的事情會被打亂	3.15	.979		
12. 如果我現在離開醫院，也不會有太多的損失（R）	2.88	.887		
13. 目前留在這間醫院上班，對我而言是一種必要也是需要	3.41	.804		
14. 我覺得我沒有太多的選擇可以考慮離開這間醫院	2.94	.847		
15. 離開這間醫院的嚴重後果之一是其它工作的選擇太少	2.84	.908		
16. 我繼續留在這間醫院的一個主要原因是，離開需要付出相當大的個人犧牲，另一間醫院可能無法提供我相同的福利	2.99	.915		
三 規範性承諾				
17. 我覺得現在的人太常更換工作的醫院	3.51	.805	2.84	.519
18. 我不認為人們必須對於自己工作的醫院一直保持忠誠（R）	2.90	.936		
19. 我不覺得轉換醫院是件不道德的事（R）	2.47	.888		
20. 繼續留在這間醫院的一個主要原因是，我相信忠誠很重要，所以覺得有道德上的義務待下來	2.88	.899		
21. 就算我得到另一份更好的工作，我也不覺得離開現在的醫院是正確的	2.84	.930		
22. 我曾被教導要對一間醫院維持忠誠度	2.75	.901		
23. 如果人們職業生涯都只待在同一家醫院，那麼一切將會變得更美好	2.51	.874		
24. 我認為對雇主忠誠不再是一項明智的抉擇（R）	2.90	.868		

註：R 表示反向題，試題分數為轉向後的分數。

從「持續性承諾」分量表內試題來看，此分量表共八題，其平均數介於 2.55~3.41，其中第 13 題「目前留在這間醫院上班，對我而言是一種必要也是需要」的組織承諾程度最高；而第 9 題「我不害怕如果我辭掉工作會無人遞補」在分量表中的組織承諾程度最低。

而「規範性承諾」此分量表共八題，以分量表內試題來看，其平均數介於 2.47~3.51，其中第 17 題「我覺得現在的人太常更換工作的醫院」的組織承諾程度最高；而第 19 題「我不覺得轉換醫院是件不道德的事」在分量表中的組織承諾程度最低。

整體而言，透過各分量表可得知護理人員的組織承諾中情感性承諾的平均數較高（如：我很樂於跟外人談論我工作的醫院、我會很高興能在這間醫院渡過日後的職業生涯）而規範性承諾的平均數較低（如：我不覺得轉換醫院是件不道德的事、如果人們職業生涯都只待在同一家醫院，那麼一切將會變得更美好）。

四、護理人員在離職意圖試題上的現況

表 4-4 為護理人員在離職意圖各試題上的平均數與標準差，結果顯示離職意圖整體平均數（ $M = 2.86$ ），屬於中度略偏低，各試題的平均數介於 2.58~3.35，護理人員離職意圖（5 等級計分）中，第 1 題「如果我現在離職，以我目前的年齡和專業技能我在其他醫院很容易找到合適的工作」的離職意圖最高；而第 4 題「在未來的一年內我不會辭去目前的工作」的離職意圖最低。

表 4-4

護理人員在離職意圖試題上的平均數與標準差

量表與題號	平均數	標準差	分量表	
			平均數	標準差
1.如果我現在離職，以我目前的年齡和專業技能，我在其他醫院很容易找到合適的工作	3.35	.865		
2.我時常考慮要離開這家醫院	2.87	.908	2.86	.654
3.過去一年我有去尋找其它工作	2.63	1.02		
4.在未來的一年內我不會辭去目前的工作（R）	2.58	.853		

註：R 表示反向題，試題分數為轉向後的分數。

五、結語與討論

護理人員工作壓力（工作負荷—控制—支持）分量表的四個面向以知覺到同事支持和主管支持的感受程度較高，而在知覺工作負荷的感受程度上又高過於工作控制。雖然呈現高工作負荷與低工作控制的高壓力工作況，但在 JDCS 模式中，社會支持會減輕高壓力工作（高負荷，低控制）所產生的負面結果，高鳳霞和鄭伯璦（2014）提到在高工作要求情況下，社會支持有助於提升員工對於工作完成的信心與受到相互關懷的感受。本研究發現在地區型醫療機構中的護理人員感受到來自人際支持的程度高過感受到的工作負荷及工作控制，推論其原因可能為，地區醫院相較於醫學中心或區域醫院，規模較小且人力配置較少，因此主管和護理人員及護理人員和同事間較為熟稔且互助、互動緊密，人際關係及工作氣氛較佳，

護理人員工作滿意度以「人際互動與合作」的平均分數最高，其次是「主管的領導風格」，第三是「專業自主與發展」，第四是「護理工作的負荷」，平均分數最低的是「支持性執業環境」。此結果與林采怡和林弘昌（2019）以某區域教學醫院 207 位臨床護理人員為對象的研究結果略有不同：護理人員在「人際互動與合作」構面的滿

意度最高，其次為對「主管的領導風格」構面，之後是「專業自主與發展」構面，以及「支持性執業環境」構面；滿意度最低的為「護理工作的負荷」構面。推論其原因可能為，地區醫院和區域教學醫院在設置標準、福利制度、設備及工作複雜度上的不同，因此在同屬於保健因子中與環境有關的「護理工作的負荷」、「支持性執業環境」滿意度上略有差異。

護理人員組織承諾中「情感性承諾」略高於「持續性承諾」、「規範性承諾」；此結果與解旻容等人（2013）的研究結果：護理人員的「情感性承諾」之平均值略高於「規範性承諾」、「持續性承諾」相似。

離職意圖指的是員工自願退出組織前的意圖（Tett 和 Meyer, 1993），它是離職行為實際產生前的主要預測因子，本研究的護理人員離職意圖平均分數屬於中度偏低，顯示護理人員離開目前任職醫院的意圖不強烈。

第二節 不同背景之護理人員在工作壓力、工作滿意度、組織承諾與離職意圖上的差異性分析

本節呈現不同背景變項之護理人員在工作壓力、工作滿意度、組織承諾與離職意圖上的差異性分析結果。背景變項包括：性別（男／女）、年齡（20-30 歲／31-40 歲／大於 40 歲）、教育程度（大學＋碩士／高職＋專科）、婚姻狀況（未婚／已婚）、目前任職醫院的護理年資（5 年以下／5-10 年／10 年以上）、服務單位（加護病房／一般病房／呼吸病房／開刀房／門診）（註：婚姻狀態及服務單位之部分類別人數過少，未納入分析）。本節以各背景變項為自變項，分別以工作壓力（四因素）、工作滿意度（五因素）、組織承諾（三因素）與離職意圖為依變項。以單因子多變量變異數分析（1-way MANOVA）考驗不同背景變項的護理人員在工作壓力、工作滿意度、組織承諾各組變項上的差異，若達顯著，則針對每組變項的各分量表進行單變量 ANOVA 分析，若單變量 ANOVA 分析也達顯著，則進行 Scheffé 事後比較。由於離職意圖無分量表，故以單變量 ANOVA 分析考驗不同背景變項的護理人員在離職意圖（總分）上的差異。

一、不同背景之護理人員在工作壓力上的差異性分析結果

（一）不同「性別」之護理人員的工作壓力差異

表 4-5 為不同性別之護理人員在工作壓力 JDCS「工作負荷－控制－支持」四個分量表上的平均數與標準差，由表可得知「男性」護理人員在四個分量表中平均數皆

略高過「女性」護理人員，以單因子 MANOVA 考驗差異，結果顯示不同性別的護理人員在工作壓力分量表上有顯著差異（ $Wilk\lambda=0.969$ ， $F(4,323)=2.591$ ， $p=.037$ ，部分 Eta 平方為 .031），研究假設獲得支持，表示護理人員的工作壓力會因性別不同而有差異，性別可以解釋護理人員在工作壓力上 3.1 % 的變異。

表 4-5

不同性別之護理人員在工作壓力各分量表的平均數與標準差

工作壓力分量表	女性	(n=313)	男性	(n=15)
	平均數	標準差	平均數	標準差
工作控制	2.675	.301	2.830	.363
工作負荷	2.810	.403	3.008	.410
主管支持	2.926	.552	3.133	.626
同事支持	3.089	.458	3.383	.442

為進一步了解不同性別護理人員在 JDCS 工作壓力各分量表上的差異，遂進行單變量 ANOVA 分析，從表 4-6 結果發現，不同「性別」的護理人員在「同事支持」分量表上達顯著差異，事後比較男性高於女性。

表 4-6

不同性別之護理人員在工作壓力上的單因子變異數分析摘要表

變異來源		平方和	自由度	平均平方和	F	顯著性	Eta 平方	事後比較
工作控制	組間	.341	1	.341	3.689	.056	.011	
	組內	30.172	326	.093				
工作負荷	組間	.561	1	.561	3.454	.064	.010	
	組內	52.986	326	.163				
主管支持	組間	.617	1	.617	2.002	.158	.006	
	組內	100.444	326	.308				
同事支持	組間	1.236	1	1.24	5.907	.016	.018	男>女
	組內	68.229	326	.209				

（二）不同「年齡」之護理人員的工作壓力差異

表 4-7 為不同年齡之護理人員在 JDCS 工作壓力各分量表上的平均數與標準差，整體言，年紀較大者在工作控制及工作負荷上分數較高，年紀較輕者則在主管、同事支持上分數較高。單因子 MANOVA 考驗結果顯示不同年齡的護理人員在工作壓力上有顯著差異（ $Wilk\lambda=0.941$ ， $F(8,644)=2.487$ ， $p=.012$ ，部分 Eta 平方為 .030），研究假設獲得支持，表示護理人員的工作壓力會因年齡不同而有差異，年齡可以解釋護理人員在工作壓力上 3.0 % 的變異。單變量 ANOVA 後續分析（表 4-8）結果顯示，

不同「年齡」的護理人員在「主管支持」分量表上達顯著差異，Scheffé 事後比較發現「20-30 歲」組顯著高於其他兩個年齡組。

表 4-7

不同年齡之護理人員在工作壓力各分量表的平均數與標準差

工作壓力 分量表	20-30 歲 (n=109) 平均數 標準差	31-40 歲 (n=119) 平均數 標準差	大於 40 歲 (n=100) 平均數 標準差
工作控制	2.667 .301	2.653 .317	2.734 .292
工作負荷	2.778 .366	2.833 .432	2.849 .411
主管支持	3.071 .607	2.866 .559	2.870 .465
同事支持	3.186 .492	3.065 .464	3.057 .411

表 4-8

不同年齡之護理人員在工作壓力上的單因子變異數分析摘要表

變異來源	平方和	自由度	平均平方和	F	顯著性	Eta 平方	事後比較
工作控制	組間 組內	.403 30.110	2 325	.202 .093	2.175	.115	.013
工作負荷	組間 組內	.299 53.248	2 325	.150 .164	.913	.402	.006
主管支持	組間 組內	3.016 98.045	2 325	1.508 .302	4.998	.007	.030 1 > 2,3
同事支持	組間 組內	1.125 68.340	2 325	.562 .210	2.674	.070	.016

註:1 = 20-30 歲，2 = 31-40 歲，3 = 大於 40 歲

(三) 不同「教育程度」之護理人員的工作壓力差異

表 4-9

不同教育程度之護理人員在工作壓力各分量表的平均數與標準差

工作壓力分量表	高職+專科 (n=137) 平均數 標準差	大學+碩士或以上 (n=148) 平均數 標準差
工作控制	2.647 .309	2.679 .308
工作負荷	2.860 .418	2.788 .415
主管支持	2.916 .531	2.966 .608
同事支持	3.080 .412	3.142 .485

表 4-9 為不同教育程度之護理人員在 JDCS 工作壓力各分量表上的平均數與標準差，整體言，高職+專科者在工作負荷上分數較高，大學+碩士或以上者則在工作控制、主管支持和同事支持上分數較高。單因子 MANOVA 考驗結果顯示不同教育程度的護理人員在工作壓力上無顯著差異 ($Wilk \lambda = 0.984$, $F(4, 280) = 1.125$, $p = .345$),

部分 Eta 平方為 .016)，研究假設未獲得支持，表示護理人員的工作壓力不會因教育程度不同而有差異。

(四) 不同「婚姻狀況」之護理人員的工作壓力差異

表 4-10 為不同婚姻狀況之護理人員在 JDCS 工作壓力各分量表上的平均數與標準差，整體言，未婚者在工作負荷及主管支持上分數較高，而已婚者則在工作控制和同事支持上分數較高。以單因子 MANOVA 考驗結果顯示不同婚姻狀況的護理人員在工作壓力上無顯著差異（Wilk $\Lambda = 0.980$ ， $F(4, 280) = 1.462$ ， $p = .214$ ，部分 Eta 平方為 .020），研究假設未獲得支持，表示護理人員的工作壓力不會因婚姻狀況不同而有差異。

表 4-10

不同婚姻狀況之護理人員在工作壓力各分量表的平均數與標準差

工作壓力分量表	未婚 (n=142)	已婚 (n=143)
	平均數	標準差
工作控制	2.632	.338
工作負荷	2.832	.410
主管支持	2.961	.582
同事支持	3.097	.472

(五) 目前任職醫院不同「護理年資」之護理人員的工作壓力差異

表 4-11 為目前任職醫院不同的護理年資之護理人員在 JDCS 工作壓力各分量表上的平均數與標準差，整體言，大於 10 年者在工作控制和工作負荷上分數較高，5 年以下者則在主管支持、同事支持上分數較高。單因子 MANOVA 考驗結果顯示不同護理年資的護理人員在工作壓力上有顯著差異（Wilk $\Lambda = 0.905$ ， $F(8, 644) = 4.121$ ， $p = .000$ ，部分 Eta 平方為 .049），研究假設獲得支持，表示護理人員的工作壓力會因目前任職醫院護理年資不同而有差異，護理年資可以解釋護理人員在工作壓力上 4.9 % 的變異。

表 4-11

目前任職醫院不同護理年資之護理人員在工作壓力各分量表的平均數與標準差

工作壓力 分量表	5 年以下 (n=117)	5-10 年 (n=119)	大於 10 年 (n=92)			
	平均數	標準差	平均數	標準差	平均數	標準差
工作控制	2.663	.299	2.665	.286	2.729	.334
工作負荷	2.760	.418	2.810	.418	2.908	.357
主管支持	3.062	.531	2.908	.538	2.810	.582
同事支持	3.220	.468	3.011	.472	3.073	.407

單變量 ANOVA 後續分析（表 4-12）結果顯示，目前任職醫院不同「護理年資」的護理人員在「工作負荷」、「主管支持」、「同事支持」分量表上達顯著差異，Scheffé 事後比較發現「大於 10 年」組在「工作負荷」顯著高於其他兩個年資組，「5 年以下」組在「主管支持」、「同事支持」顯著高於其他兩個年資組。

表 4-12

目前任職醫院不同護理年資之護理人員在工作壓力上的單因子變異數分析摘要表

變異來源		平方和	自由度	平均平方和	F	顯著性	Eta 平方	事後比較
工作控制	組間	.285	2	.143	1.534	.217	.009	
	組內	30.228	325	.093				
工作負荷	組間	1.145	2	.572	3.550	.030	.021	3 > 2 > 1
	組內	52.402	325	.161				
主管支持	組間	3.418	2	1.709	5.689	.004	.034	1 > 2 > 3
	組內	97.643	325	.300				
同事支持	組間	2.703	2	1.351	6.579	.002	.039	1 > 3 > 2
	組內	66.762	325	.205				

註:1 = 5 年以下，2 = 5-10 年，3 = 大於 10 年

（六）不同「服務單位」之護理人員的工作壓力差異

表 4-13 為不同服務單位之護理人員在 JDCS 工作壓力各分量表上的平均數與標準差，整體言，加護病房的護理人員在工作控制、工作負荷和主管支持上分數較高，開刀房的護理人員則在同事支持上分數較高。單因子 MANOVA 考驗結果顯示不同服務單位的護理人員在工作壓力上無顯著差異（Wilk Λ = 0.922， $F(16,886) = 1.494$ ， $p = .095$ ，部分 Eta 平方為 .020），研究假設未獲得支持，表示護理人員的工作壓力不會因服務單位不同而有差異。

表 4-13

不同服務單位之護理人員在工作壓力各分量表的平均數與標準差

工作壓力 分量表	加護 病房	(n=28)	一般 病房	(n=56)	呼吸 病房	(n=113)	開刀房	(n=22)	門診	(n=79)
	平均數	標準差	平均數	標準差	平均數	標準差	平均數	標準差	平均數	標準差
工作控制	2.786	.296	2.669	.309	2.640	.314	2.717	.306	2.665	.304
工作負荷	2.969	.317	2.777	.455	2.854	.388	2.807	.355	2.759	.453
主管支持	3.125	.357	2.821	.747	2.938	.558	3.102	.516	2.940	.472
同事支持	3.143	.399	2.973	.352	3.095	.456	3.239	.696	3.149	.425

二、不同背景之護理人員在工作滿意度上的差異性分析結果

(一) 不同「性別」之護理人員的工作滿意度差異

表 4-14 為不同性別之護理人員在工作滿意度各分量表上的平均數與標準差，整體言，男性護理人員在工作滿意度的五個分量表上，除了專業自主與發展分數略低於女性護理人員的滿意度，其餘分量表的分數上皆略高於女性護理人員的滿意度。單因子 MANOVA 考驗差異，結果顯示不同性別的護理人員在工作滿意度上無顯著差異 ($Wilk \lambda = 0.997$, $F(5, 322) = .213$, $p = .957$ ，部分 Eta 平方為 .003)，研究假設未獲得支持，表示護理人員的工作滿意度不會因性別不同而有差異。

表 4-14

不同性別之護理人員在工作滿意度各分量表的平均數與標準差

工作滿意度分量表	女生	(n=313)	男生	(n=15)
	平均數	標準差	平均數	標準差
支持性執業環境	3.198	.574	3.237	.488
專業自主與發展	3.453	.457	3.430	.349
人際互動與合作	3.593	.495	3.611	.461
主管的領導風格	3.528	.677	3.650	.589
護理工作的負荷	3.248	.541	3.289	.641

(二) 不同「年齡」之護理人員的工作滿意度差異

表 4-15 為不同年齡之護理人員在工作滿意度各分量表上的平均數與標準差，整體言，大於 40 歲者在工作滿意度的五個分量表上分數皆較高。單因子 MANOVA 考驗差異，結果顯示不同年齡的護理人員在工作滿意度上無顯著差異 ($Wilk \lambda = 0.975$, $F(10, 642) = .818$, $p = .612$ ，部分 Eta 平方為 .013)，研究假設未獲得支持，表示護理人員的工作滿意度不會因年齡不同而有差異。

表 4-15

不同年齡之護理人員在工作滿意度各分量表的平均數與標準差

工作滿意度分量表	20-30 歲	(n=109)	31-40 歲	(n=119)	大於 40 歲	(n=100)
	平均數	標準差	平均數	標準差	平均數	標準差
支持性執業環境	3.213	.555	3.165	.563	3.228	.596
專業自主與發展	3.414	.418	3.448	.455	3.498	.484
人際互動與合作	3.558	.526	3.552	.463	3.682	.482
主管的領導風格	3.544	.609	3.515	.708	3.545	.703
護理工作的負荷	3.220	.547	3.252	.540	3.280	.552

(三) 不同「教育程度」之護理人員的工作滿意度差異

表 4-16 為不同教育程度之護理人員在工作滿意度各分量表上的平均數與標準差，整體言，教育程度為大學+碩士或以上者，除了支持性執業環境外，在專業自主與發展、人際互動與合作、主管的領導風格和護理工作的負荷上分數皆較高。單因子 MANOVA 考驗結果顯示不同教育程度的護理人員在工作滿意度上無顯著差異(Wilk $\Lambda=0.982$, $F(5,279)=1.039$, $p=.395$, 部分 Eta 平方為 .018)，研究假設未獲得支持，表示護理人員的工作滿意度不會因教育程度不同而有差異。

表 4-16

不同教育程度之護理人員在工作滿意度各分量表的平均數與標準差

工作滿意度分量表	高職+專科	(n=137)	大學+碩士或以上	(n=148)
	平均數	標準差	平均數	標準差
支持性執業環境	3.203	.549	3.184	.628
專業自主與發展	3.397	.482	3.490	.437
人際互動與合作	3.554	.491	3.624	.505
主管的領導風格	3.487	.657	3.554	.703
護理工作的負荷	3.212	.544	3.273	.555

(四) 不同「婚姻狀況」之護理人員的工作滿意度差異

表 4-17 為不同婚姻狀況之護理人員在工作滿意度各分量表上的平均數與標準差，整體言，已婚者在工作滿意度的五個分量表上分數較高。單因子 MANOVA 考驗結果顯示不同婚姻狀況的護理人員在工作滿意度上無顯著差異(Wilk $\Lambda=0.968$, $F(5,279)=1.826$, $p=.108$, 部分 Eta 平方為 .032)，研究假設未獲得支持，表示護理人員的工作滿意度不會因婚姻狀況不同而有差異。

表 4-17

不同婚姻狀況之護理人員在工作滿意度各分量表的平均數與標準差

工作滿意度分量表	未婚	(n=142)	已婚	(n=143)
	平均數	標準差	平均數	標準差
支持性執業環境	3.131	.565	3.255	.610
專業自主與發展	3.379	.458	3.511	.455
人際互動與合作	3.541	.503	3.639	.491
主管的領導風格	3.484	.634	3.559	.725
護理工作的負荷	3.237	.576	3.249	.524

(五) 目前任職醫院不同「護理年資」之護理人員的工作滿意度差異

表 4-18 為目前任職醫院不同護理年資之護理人員在工作滿意度各分量表上的平均數與標準差，整體言，5 年以下者在工作滿意度的五個分量表上分數較高。單因子 MANOVA 考驗差異，結果顯示不同護理年資的護理人員在工作滿意度上無顯著差異 ($Wilk \Lambda = 0.948$, $F(10, 642) = 1.734$, $p = .070$ ，部分 Eta 平方為 .026)，研究假設未獲得支持，表示護理人員的工作滿意度不會因護理年資不同而有差異。

表 4-18

目前任職醫院不同護理年資之護理人員在工作滿意度各分量表的平均數與標準差

工作滿意度 分量表	5 年以下 (n=117)	5-10 年 (n=119)	大於 10 年 (n=92)			
	平均數	標準差	平均數	標準差	平均數	標準差
支持性執業環境	3.321	.518	3.129	.551	3.139	.633
專業自主與發展	3.498	.460	3.406	.437	3.453	.460
人際互動與合作	3.652	.508	3.531	.515	3.600	.434
主管的領導風格	3.652	.636	3.515	.646	3.408	.733
護理工作的負荷	3.336	.614	3.182	.527	3.228	.458

(六) 不同「服務單位」之護理人員的工作滿意度差異

表 4-19 為不同服務單位之護理人員在工作滿意度各分量表上的平均數與標準差，整體言，加護病房的護理人員，在工作滿意度的五個分量表中支持性執業環境上分數較高，一般病房的護理人員，在專業自主與發展及護理工作的負荷上分數較高，開刀房的護理人員，在主管的領導風格上分數較高，門診的護理人員，在人際互動與合作上分數較高。

表 4-19

不同服務單位之護理人員在工作滿意度各分量表的平均數與標準差

工作滿意 度分量表	加護 病房	(n=28)	一般 病房	(n=56)	呼吸 病房	(n=113)	開刀房	(n=22)	門診	(n=79)
	平均數	標準差	平均數	標準差	平均數	標準差	平均數	標準差	平均數	標準差
支持性執業環境	3.357	.425	3.187	.646	3.096	.565	2.980	.590	3.346	.577
專業自主與發展	3.484	.376	3.532	.493	3.377	.449	3.394	.378	3.474	.490
人際互動與合作	3.595	.414	3.515	.539	3.516	.516	3.553	.425	3.722	.483
主管的領導風格	3.545	.462	3.393	.874	3.502	.602	3.614	.640	3.601	.707
護理工作的負荷	3.238	.496	3.387	.557	3.212	.544	3.106	.404	3.215	.606

單因子 MANOVA 考驗結果顯示不同服務單位的護理人員在工作滿意度上有顯著差異 (Wilk Λ =0.849, $F(20,959)=2.423$, $p=.0005$, 部分 Eta 平方為.040), 研究假設獲得支持, 表示護理人員的工作滿意度會因服務單位不同而有差異, 服務單位可以解釋護理人員在工作滿意度上 4% 的變異。為進一步了解不同服務單位的護理人員在工作滿意度各分量表上的差異。單變量 ANOVA 後續分析 (表 4-20) 結果顯示, 不同「服務單位」的護理人員在「支持性執業環境」分量表上達顯著差異, Scheffé 事後比較發現「加護病房」顯著高於其他四個單位。

表 4-20

不同服務單位之護理人員在工作滿意度上的單因子變異數分析摘要表

變異來源		平方和	自由度	平均平方和	F	顯著性	Eta 平方	事後比較
支持性執業環境	組間	4.66	4	1.165	3.53	.008	.046	1>5>2>3>4
	組內	96.76	293	.330				
專業自主與發展	組間	1.12	4	.279	1.33	.259	.018	
	組內	61.50	293	.210				
人際互動與合作	組間	2.30	4	.575	2.33	.056	.031	
	組內	72.43	293	.247				
主管的領導風格	組間	1.67	4	.418	.90	.463	.012	
	組內	135.83	293	.464				
護理工作的負荷	組間	1.74	4	.435	1.43	.223	.019	
	組內	88.92	293	.303				

註:1 = 加護病房, 2 = 一般病房, 3 = 呼吸病房, 4 = 開刀房, 5 = 門診

三、不同背景之護理人員在組織承諾上的差異性分析結果

(一) 不同「性別」之護理人員的組織承諾差異

表 4-21 為不同性別之護理人員在組織承諾各分量表上的平均數與標準差, 整體言, 男性護理人員在持續性和規範性承諾上分數較高, 女性護理人員則在情感性承諾上分數較高。

表 4-21

不同性別之護理人員在組織承諾各分量表的平均數與標準差

組織承諾分量表	女生	(n=313)	男生	(n=15)
	平均數	標準差	平均數	標準差
情感性	3.175	.454	3.092	.277
持續性	2.999	.561	3.033	.399
規範性	2.844	.520	2.858	.528

單因子 MANOVA 考驗結果顯示不同性別的護理人員在組織承諾上無顯著差異 (Wilk $\Lambda = 0.997$, $F(3,324) = .300$, $p = .825$, 部分 Eta 平方為 .003), 研究假設未獲得支持, 表示護理人員的組織承諾不會因性別不同而有差異。

(二) 不同「年齡」之護理人員的組織承諾差異

表 4-22 為不同年齡之護理人員在組織承諾各分量表上的平均數與標準差, 整體言, 年紀較大者在情感性、持續性和規範性承諾上分數較高。單因子 MANOVA 考驗結果顯示不同年齡的護理人員在組織承諾上有顯著差異 (Wilk $\Lambda = 0.956$, $F(6,646) = 2.463$, $p = .023$, 部分 Eta 平方為 .022), 研究假設獲得支持, 表示護理人員的組織承諾會因年齡不同而有差異, 年齡可以解釋護理人員在組織承諾上 2.2 % 的變異。單變量 ANOVA 後續分析 (表 4-23) 結果顯示, 不同「年齡」的護理人員在「情感性」和「規範性」承諾分量表上達顯著差異, Scheffé 事後比較發現「大於 40 歲」組顯著高於其他兩個年齡組。

表 4-22

不同年齡之護理人員在組織承諾各分量表的平均數與標準差

組織承諾 分量表	20-30 歲 平均數	(n=109) 標準差	31-40 歲 平均數	(n=119) 標準差	大於 40 歲 平均數	(n=100) 標準差
情感性	3.106	.407	3.139	.482	3.281	.430
持續性	2.985	.529	2.932	.609	3.100	.496
規範性	2.763	.533	2.813	.520	2.971	.483

表 4-23

不同年齡之護理人員在組織承諾上的單因子變異數分析摘要表

變異來源		平方和	自由度	平均平方和	F	顯著性	Eta 平方	事後比較
情感性	組間	1.808	2	.904	4.623	.010	.028	3 > 2 > 1
	組內	63.542	325	.196				
持續性	組間	1.579	2	.789	2.611	.075	.016	
	組內	98.265	325	.302				
規範性	組間	2.455	2	1.228	4.655	.010	.028	3 > 2 > 1
	組內	85.709	325	.264				

註: 1 = 20-30 歲, 2 = 31-40 歲, 3 = 大於 40 歲

(三) 不同「教育程度」之護理人員的組織承諾差異

表 4-24 為不同教育程度之護理人員在組織承諾各分量表上的平均數與標準差, 整體言, 高職+專科者在情感性、持續性及規範性承諾上分數較高。單因子 MANOVA 考驗結果顯示不同教育程度的護理人員在組織承諾上無顯著差異 (Wilk $\Lambda = 0.979$, F

(3,281) = 1.993, $p = .115$, 部分 Eta 平方為.021), 研究假設未獲得支持, 表示護理人員的組織承諾不會因教育程度不同而有差異。

表 4-24

不同教育程度之護理人員在組織承諾各分量表的平均數與標準差

組織承諾分量表	高職+專科 (n=137)		大學+碩士或以上 (n=148)	
	平均數	標準差	平均數	標準差
情感性	3.230	.456	3.102	.456
持續性	3.047	.541	2.976	.565
規範性	2.874	.503	2.778	.536

(四) 不同「婚姻狀況」之護理人員的組織承諾差異

表 4-25 為不同婚姻狀況之護理人員在組織承諾各分量表上的平均數與標準差, 整體言, 已婚者在情感性、持續性及規範性上分數較高。單因子 MANOVA 考驗結果顯示不同婚姻狀況的護理人員在組織承諾上有顯著差異 (Wilk $\Lambda = 0.969$, $F(3,281) = 2.971$, $p = .032$, 部分 Eta 平方為.031), 研究假設獲得支持, 表示護理人員的組織承諾會因婚姻狀況不同而有差異, 婚姻狀況可以解釋護理人員在組織承諾上 3.1%的變異。單變量 ANOVA 後續分析 (表 4-26) 結果顯示, 不同「婚姻狀況」的護理人員在「情感性」和「規範性」承諾分量表上達顯著差異, 事後比較發現「已婚」者顯著高於「未婚」者。

表 4-25

不同婚姻狀況之護理人員在組織承諾各分量表的平均數與標準差

組織承諾分量表	未婚 (n=142)		已婚 (n=143)	
	平均數	標準差	平均數	標準差
情感性	3.092	.459	3.235	.451
持續性	2.979	.569	3.040	.539
規範性	2.757	.564	2.891	.469

表 4-26

不同婚姻之護理人員在組織承諾上的單因子變異數分析摘要表

變異來源		平方和	自由度	平均平方和	F	顯著性	Eta 平方	事後比較
情感性	組間	1.469	1	1.469	7.094	.008	.024	已婚>未婚
	組內	58.606	283	.207				
持續性	組間	.268	1	.268	.873	.351	.003	
	組內	86.893	283	.307				
規範性	組間	1.273	1	1.273	4.739	.030	.016	已婚>未婚
	組內	76.051	283	.269				

(五) 目前任職醫院不同「護理年資」之護理人員的組織承諾差異

表 4-27 為目前任職醫院不同護理年資之護理人員在組織承諾各分量表上的平均數與標準差，整體言，大於 10 年者在情感性、持續性及規範性承諾上分數較高。單因子 MANOVA 考驗差異，結果顯示不同護理年資的護理人員在組織承諾上無顯著差異 ($Wilk \lambda = 0.999$, $F(6, 646) = .079$, $p = .998$ ，部分 Eta 平方為 .001)，研究假設未獲得支持，表示護理人員的組織承諾不會因護理年資不同而有差異。

表 4-27

目前任職醫院不同護理年資之護理人員在組織承諾各分量表的平均數與標準差

組織承諾	5 年以下	(n=117)	5-10 年	(n=119)	大於 10 年	(n=92)
分量表	平均數	標準差	平均數	標準差	平均數	標準差
情感性	3.162	.433	3.173	.483	3.179	.421
持續性	2.995	.540	2.988	.511	3.024	.622
規範性	2.826	.530	2.851	.487	2.860	.551

(六) 不同「服務單位」之護理人員的組織承諾差異

表 4-28 為不同服務單位之護理人員在組織承諾各分量表上的平均數與標準差，整體言，加護病房的護理人員在情感性、持續性及規範性上分數較高。單因子 MANOVA 考驗結果顯示不同服務單位的護理人員在組織承諾上無顯著差異 ($Wilk \lambda = 0.939$, $F(12, 770) = 1.534$, $p = .107$ ，部分 Eta 平方為 .021)，研究假設未獲得支持，表示護理人員的組織承諾不會因服務單位不同而有差異。

表 4-28

不同服務單位之護理人員在組織承諾各分量表的平均數與標準差

組織承諾 分量表	加護 病房 (n=28)	一般 病房 (n=56)	呼吸 病房 (n=113)	開刀房 (n=22)	門診 (n=79)	
	平均數	標準差	平均數	標準差	平均數	標準差
情感性	3.232	.355	3.219	.515	3.132	.393
持續性	3.147	.421	3.002	.606	2.980	.572
規範性	3.094	.392	2.772	.646	2.794	.477

四、不同背景護理人員在離職意圖上的差異性分析結果

(一) 不同「性別」之護理人員的離職意圖差異

表 4-29 為不同性別之護理人員在離職意圖量表上的平均數與標準差，整體言，男性護理人員分數較高。單變量 ANOVA 考驗結果顯示不同性別的護理人員在離職意

圖上無顯著差異 ($F(1,326) = .314, p = .576$, 部分 Eta 平方為 .001), 研究假設未獲得支持, 表示護理人員的離職意圖不會因性別不同而有差異。

表 4-29

不同性別之護理人員在離職意圖量表的平均數與標準差

	女生 (n=313)	男生 (n=15)
	平均數	標準差
離職意圖	2.853	.474

(二) 不同「年齡」之護理人員的離職意圖差異

表 4-30 為不同年齡之護理人員在離職意圖量表上的平均數與標準差, 整體言, 年紀較輕者分數較高。單變量 ANOVA 考驗 (表 4-31) 結果顯示不同「年齡」的護理人員在離職意圖上達顯著差異 ($F(2,325) = 17.931, p = .000$, 部分 Eta 平方為 .099), 研究假設獲得支持, 表示護理人員的離職意圖會因年齡不同而有差異, 年齡可以解釋護理人員在離職意圖量表上 9.9% 的變異, Scheffé 事後比較發現「20-30 歲」組顯著高於其他兩個年齡組。

表 4-30

不同年齡之護理人員在離職意圖量表的平均數與標準差

	20-30 歲 (n=109)	31-40 歲 (n=119)	大於 40 歲 (n=100)
	平均數	標準差	標準差
離職意圖	3.041	.594	.586

表 4-31

不同年齡之護理人員在離職意圖上的單因子變異數分析摘要表

變異來源	平方和	自由度	平均平方和	F	顯著性	Eta 平方	事後比較
離職意圖 組間	13.903	2	6.952	17.931	.000	.099	1 > 2 > 3
離職意圖 組內	125.996	325	.388				

註: 1 = 20-30 歲, 2 = 31-40 歲, 3 = 大於 40 歲

(三) 不同「教育程度」之護理人員的離職意圖差異

表 4-32 為不同教育程度之護理人員在離職意圖量表上的平均數與標準差, 整體言, 大學+碩士或以上者分數較高。單變量 ANOVA 考驗結果顯示不同教育程度的護理人員在離職意圖上無顯著差異 ($F(1,283) = 0.736, p = .392$, 部分 Eta 平方為 .003), 研究假設未獲得支持, 表示護理人員的離職意圖不會因教育程度不同而有差異。

表 4-32

不同教育程度之護理人員在離職意圖量表上的平均數與標準差

	高職+專科	(n=137)	大學+碩士或以上	(n=148)
	平均數	標準差	平均數	標準差
離職意圖	2.834	.666	2.902	.672

(四) 不同「婚姻狀況」之護理人員的離職意圖差異

表 4-33 為不同婚姻狀況之護理人員在離職意圖量表上的平均數與標準差，整體言，未婚者分數較高。單變量 ANOVA 考驗(表 4-34)結果顯示，研究假設獲得支持，不同婚姻狀況的護理人員在離職意圖上有顯著差異($F(1,283)=9.978, p=.002$ ，部分 Eta 平方為 .034)，婚姻狀況可以解釋護理人員在離職意圖上 3.4 %的變異。事後比較發現「未婚」者高於「已婚」者。

表 4-33

不同婚姻狀況之護理人員在離職意圖量表上的平均數與標準差

	未婚	(n=142)	已婚	(n=143)
	平均數	標準差	平均數	標準差
離職意圖	2.993	.642	2.747	.675

表 4-34

不同婚姻狀況之護理人員在離職意圖上的單因子變異數分析摘要表

變異來源		平方和	自由度	平均平方和	F	顯著性	Eta 平方	事後比較
離職意圖	組間	4.33	1	4.328	9.98	.002	.034	未婚>已婚
	組內	122.74	283	.434				

(五) 目前任職醫院不同「護理年資」之護理人員的離職意圖差異

表 4-35 為目前任職醫院不同護理年資之護理人員在離職意圖量表上的平均數與標準差，整體言，5-10 年分數較高。

表 4-35

目前任職醫院不同護理年資之護理人員在離職意圖量表上的平均數與標準差

	5 年以下	(n=117)	5-10 年	(n=119)	大於 10 年	(n=92)
	平均數	標準差	平均數	標準差	平均數	標準差
離職意圖	2.868	.628	2.977	.617	2.690	.704

單變量 ANOVA 考驗 (表 4-36) 結果顯示, 不同護理年資的護理人員在離職意圖上有顯著差異 ($F(2,325) = 5.131, p = .006$, 部分 Eta 平方為 .031), 護理年資可以解釋護理人員在離職意圖上 3.1 % 的變異。Scheffé 事後比較發現「5-10 年」組顯著高於其他兩個年資組。

表 4-36

目前任職醫院不同護理年資之護理人員在離職意圖上的單因子變異數分析摘要表

變異來源		平方和	自由度	平均平方和	F	顯著性	Eta 平方	事後比較
離職意圖	組間	4.282	2	2.141	5.131	.006	.031	2 > 1 > 3
	組內	135.617	325	.417				

註:1 = 5 年以下, 2 = 5-10 年, 3 = 大於 10 年

(六) 不同「服務單位」之護理人員的離職意圖差異

表 4-37 為不同服務單位之護理人員在離職意圖量表上的平均數與標準差, 整體言, 加護病房的護理人員分數較高。單因子 ANOVA 考驗結果顯示不同服務單位的護理人員在離職意圖上無顯著差異 ($F(4,293) = 1.384, p = .239$, 部分 Eta 平方為 .019), 研究假設未獲得支持, 表示護理人員的離職意圖不會因服務單位不同而有差異。

表 4-37

不同服務單位之護理人員在離職意圖各分量表的平均數與標準差

	加護 病房 (n=28)	一般 病房 (n=56)	呼吸 病房 (n=113)	開刀房 (n=22)	門診 (n=79)					
	平均數	標準差	平均數	標準差	平均數	標準差				
離職意圖	3.01	.595	2.77	.790	2.96	.591	2.89	.797	2.79	.641

伍、結語與討論

與護理人員工作壓力、工作滿意度、組織承諾、離職意圖有顯著差異的背景變項整理如表 4-38。根據研究結果發現：

1. **工作壓力** (工作負荷—控制—支持) 在背景變項中的性別變項上有顯著差異, 在「同事支持」方面男性高於女性, 與其他研究發現護理人員工作壓力不會因為性別而有所差異 (郭玉琦, 2019; 胡家綺, 2017) 結果不同, 但是在「工作負荷」方面則無差異, 與其他研究發現相同; 在年齡變項上有顯著差異, 在「主管支持」方面 20-30 歲高於其他年齡的護理人員, 與有的研究部分相似, 年齡愈輕者, 壓力感受越大 (王靜琳等人, 2007; 劉素蘭等人, 2010); 在護理年資變項上有顯著差異, 在「工作負荷」方面, 地區醫院的護理人員年資越長工作負荷越高, 與洪淑芬 (2014) 以醫學中

心護理人員為對象的研究結果，年資越長者其工作壓力越小略有不同，推論其原因可能為地區醫院護理人員年齡平均為 36 歲，護理年資平均為 8.5 年，較醫學中心的護理人員年齡平均為 28.18 歲，護理年資平均為 5.94 年（黃穗芬，2011）為多，年資越長者其體力和專注力隨著年齡的逐漸增加而逐漸減退，在執行步調快且忙碌的護理工作時，知覺到的工作負荷壓力也越高。

表 4-38

不同背景之護理人員在工作壓力、工作滿意度、組織承諾、離職意圖上的差異性分析表

變項	性別	年齡	教育程度	婚姻狀況	目前任職醫院的護理年資	服務單位
工作壓力						
工作控制						
工作負荷					3 > 2 > 1	
主管支持		1 > 3 > 2			1 > 2 > 3	
同事支持	男 > 女				1 > 3 > 2	
工作滿意度						
支持性執業環境						1>5>2>3>4
專業自主與發展						
人際互動與合作						
主管的領導風格						
護理工作的負荷						
組織承諾						
情感性		3 > 2 > 1		已婚>未婚		
持續性						
規範性		3 > 2 > 1		已婚>未婚		
離職意圖						
		1 > 2 > 3		未婚>已婚	2 > 1 > 3	

註：年齡 1 = 20-30 歲，2 = 31-40 歲，3 = 大於 40 歲，

護理年資 1 = 5 年以下，2 = 5-10 年，3 = 大於 10 年，

服務單位 1 = 加護病房，2 = 一般病房，3 = 呼吸病房，4 = 開刀房，5 = 門診

2. **工作滿意度**在背景變項中的**服務單位**變項上有顯著差異，在「支持性執業環境」方面加護病房滿意度最高，其次依序為門診、一般病房、呼吸病房、開刀房，與有的研究部分相似，在「工作環境總分」的護理人員工作滿意度感受中，門診（含社區）最高，加護病房（含呼吸照護病房）及開刀房其次，急診及內外科病房最低（吳玲珠等人，2014；林采怡和林弘昌，2019；胡家綺，2017）。

3. **組織承諾**在背景變項中的**年齡**變項上有顯著差異，在「情感性」和「規範性」承諾方面年齡越長者其組織承諾越高，與有的研究相似，隨著年齡層的增高，組織承諾也越高（莊蕙琿和楊順富，2011；解旻容等人，2013）；在**婚姻狀況**變項上有顯著差異，在「情感性」和「規範性」承諾方面已婚高過未婚，與有的研究相似，在組織承諾已婚者最高，單身之護理人員最低，且達顯著差異（莊蕙琿和楊順富，2011）。

4. **離職意圖**在背景變項中的**年齡**變項上有顯著差異，年齡越輕者其離職意圖越高，與有的研究相似，離職意圖隨著年齡提升而下降（王金蓮等人，2017），年齡為25歲以下，比25至34歲及35歲以上護理人員有較高離職傾向（陳國瑚等人，2006），年齡與離職意圖達顯著負相關（王雪鳳等人，2016）；在**婚姻狀況**變項上有顯著差異，未婚高過已婚，與有的研究相似，黃慧文（2017）研究發現，147位已婚者有97位（66%）有離職意圖，274位未婚者有211位（77%）有離職意圖，婚姻狀況在離職意圖上有顯著差異。相較於已婚，未婚護理人員有較高離職傾向（陳國瑚等人，2006）；在**護理年資**變項上有顯著差異，在目前任職醫院護理年資為5-10年的護理人員離職意圖顯著高於其他護理年資的護理人員，與有的研究，年資較長者，相較於新進護理人員之離職傾向來的低（陳國瑚等人，2006）有些微不同，推論其原因可能為護理年資為5-10年的護理人員，工作負荷壓力較護理年資為5年以下的護理人員高，得到的社會支持卻較護理年資為5年以下的護理人員少所影響。

第三節 護理人員工作壓力、工作滿意度、組織承諾與離職意圖之相關分析

本節運用 Pearson 積差相關來分析護理人員的工作壓力、工作滿意度、組織承諾與離職意圖的相關情形（見表 4-39 的相關矩陣），以下先說明各變項內不同層面的相關，再說明各變項間的相關。

一、各分量表內之相關分析

本研究中各式分量表分別為工作壓力（工作負荷—控制—支持）、工作滿意度、組織承諾與離職意圖，以下分別說明各分量表內之相關。

（一）工作壓力分量表內之相關分析

工作壓力（工作負荷—控制—支持）四個分量表分別為「工作控制」、「工作負荷」、「主管支持」及「同事支持」分量表。結果顯示（1）工作控制與主管支持較有相關（ $r = .313$ ， $p < .01$ ，解釋變異量 10%）；（2）主管支持與同事支持有相關（ $r = .380$ ， $p < .001$ ，解釋變異量 14%）；（3）工作負荷與其他分測驗相關低（ $r = -.113 \sim .141$ ，解釋變異量 1~2%）。

（二）工作滿意度分量表內之相關分析

工作滿意度量表共有五個分量表，分別為「支持性執業環境」、「專業自主與發展」、「人際互動與合作」、「主管的領導風格」及「護理工作的負荷」分量表。結果顯示所有分量表兩兩之間分別呈現顯著中度正相關（ $r = .377 \sim .624$ ， $p < .001$ ，解釋變異量 14%~39%），研究顯示護理人員各層面的工作滿意度彼此間相互有關聯。

表 4-39

工作壓力、工作滿意度、組織承諾與離職意圖分量表之相關摘要表

變項	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
工作壓力													
1.工作控制	1												
2.工作負荷	.141*	1											
3.主管支持	.313**	-.113	1										
4.同事支持	.184**	.083	.380***	1									
工作滿意度													
5.支持性執業環境	.276***	-.280***	.493***	.215***	1								
6.專業自主與發展	.436***	-.169**	.391***	.224***	.542***	1							
7.人際互動與合作	.261***	-.108	.339***	.388***	.436***	.624***	1						
8.主管的領導風格	.257**	-.221***	.621***	.315***	.531***	.567***	.577***	1					
9.護理工作的負荷	.240***	-.291***	.259***	.115	.443***	.562***	.377***	.455***	1				
組織承諾													
10.情感性	.256***	-.258***	.316***	.198**	.490***	.481***	.399***	.445***	.376***	1			
11.持續性	.136*	-.245***	.219***	.197**	.336***	.181**	.245***	.254***	.202**	.402***	1		
12.規範性	.276***	-.157**	.317***	.061	.441***	.316***	.175**	.323***	.270***	.411***	.475***	1	
13.離職意圖	-.118*	.298***	-.182**	-.114	-.356***	-.334***	-.253***	-.316***	-.271***	-.544***	-.537***	-.395***	1

* $P=0.05$, ** $P=0.01$, *** $P=0.001$ 。

(三) 組織承諾分量表內之相關分析

組織承諾量表共有三個分量表，分別為「情感性」、「持續性」及「規範性」分量表。結果顯示所有分量表兩兩之間分別呈現顯著中度略低正相關 ($r = .402 \sim .475$, $p < .001$ ，解釋變異量 16% ~ 23%)，研究顯示護理人員各層面的組織承諾彼此間相互有關聯。

二、工作壓力、工作滿意度、組織承諾及離職意圖之相關分析

以下檢視不同變項間的相關。

(一) 工作壓力與工作滿意度之相關分析

在工作壓力（工作負荷—控制—支持）與工作滿意度的相關分析中，(1) 工作壓力量表中之主管支持與滿意度各向度相關較高，尤其是與對主管的領導風格 ($r = .621$) 及支持性執業環境 ($r = .493$) 的滿意度；(2) 工作壓力量表中的工作控制與對專業自主與發展的工作滿意度呈中度正相關 ($r = .436$) (兩者皆屬內在因子)；(3) 工作負荷壓力如預期與滿意度各向度呈負相關，但卻僅呈低度相關 ($r = -.108 \sim -.291$)，其中來自工作負荷的壓力與對護理工作的負荷的滿意度相關 ($r = -.291$) 比預期低；(4) 工作壓力量表中的同事支持與滿意度各向度相關僅低度至中度偏低 ($r = .115 \sim .388$)，其中與對人際互動與合作的滿意度相關略高 ($r = .388$)。

(二) 工作壓力與組織承諾之相關分析

在工作壓力（工作負荷—控制—支持）與組織承諾的相關分析中，(1) 整體言，工作壓力與組織承諾間相關介於低度至中度偏低的相關 ($r = -.157 \sim .317$)；(2) 工作負荷壓力如預期與組織承諾各向度呈負相關，但僅呈現低度相關 ($r = -.157 \sim -.258$ ，解釋變異量皆不及 7%)；(3) 工作壓力量表中的主管支持與組織承諾的相關相對略高 ($r = .219 \sim .317$)，同事支持與組織承諾的相關則相對較低 ($r = .061 \sim .198$)。

(三) 工作壓力與離職意圖之相關分析

在工作壓力（工作負荷—控制—支持）與離職意圖的相關分析中，(1) 工作壓力量表各向度與離職意圖的相關僅呈低度相關 ($r = -.114 \sim .298$ ，解釋變異量 1.3% ~ 8%)；(2) 離職意圖與工作壓力各向度的相關方向如預期：與工作負荷呈現正相關，與工作控制、主管及同事支持呈負相關；其中，離職意圖與工作負荷壓力的相關相對較高 ($r = .298$)。

(四) 工作滿意度與組織承諾之相關分析

在工作滿意度與組織承諾的相關分析中，(1) 情感性承諾與滿意度量表各向

度相關較高，尤其是與對支持性執業環境($r=.490$)、專業自主與發展($r=.481$)及主管的領導風格($r=.445$)的滿意度；(2) 整體言，工作滿意度量表與持續性及規範性組織承諾間相關介於低度至中度的相關($r=.175 \sim .441$)；(3) 工作滿意度量表中的支持性執業環境與組織承諾量表的相關相對略高($r=.336 \sim .490$)。

(五) 工作滿意度與離職意圖之相關分析

在工作滿意度與離職意圖的相關分析中，(1) 工作滿意度量表各向度與離職意圖的相關呈低度至中度偏低相關($r=-.253 \sim -.356$ ，解釋變異量 6%~13%)；(2) 工作滿意度量表各向度與離職意圖的相關方向如預期均呈負相關；其中，對支持性執業環境的滿意度與離職意圖的相關相對較高($r=-.356$)。

(六) 組織承諾與離職意圖之相關分析

在組織承諾與離職意圖的相關分析中，(1) 組織承諾量表各向度與離職意圖的相關呈中度略偏低至中度相關($r=-.395 \sim -.544$ ，解釋變異量 6%~12%)；(2) 組織承諾量表各向度與離職意圖的相關方向如預期均呈負相關；其中，情感性承諾($r=-.544$)和持續性承諾($r=-.537$)相對於規範性承諾($r=-.395$)，與離職意圖的相關較高。

三、結語與討論

研究結果顯示：

1. 工作壓力(工作負荷—控制—支持)量表中，主管支持與同事支持有相關，顯示工作負荷—控制—支持模式中，主管支持與同事支持同屬於壓力調節的社會支持。

2. 工作壓力(工作負荷—控制—支持)量表中的**主管支持**相較於其他工作壓力向度，與工作滿意度量表(尤其是與主管的領導風格及支持性執業環境)和組織承諾量表相關性較高，但多也屬中度偏低至中度正相關，與離職意圖量表呈低度負相關。

3. 工作壓力(工作負荷—控制—支持)量表中的**工作負荷**與工作滿意度量表和組織承諾量表呈低度負相關，與其他研究結果相似，工作壓力及工作滿意度存在著密切關係，工作壓力與工作滿意度呈現顯著負向相關(林采怡和林弘昌，2019；張偉斌等人，2020；黃穗芬等人，2011)，工作壓力與組織承諾有顯著負相關，工作壓力越大，組織承諾越低(洪淑芬，2014；陳小芳，2012；彭士哲和曾淑萍，2021；黃穗芬等人，2011；Yaghoubi et al., 2009)。相較於工作壓力其他向度，工作負荷與離職意圖量表相關相對較高呈低度正相關，與其他研究結果相似，

工作壓力與離職傾向呈現正相關且具顯著意義(陳梅麗等人,2000;張翠芬等人,2016;陸雅美,2006;黃穗芬等人,2011)。

4.工作壓力(工作負荷—控制—支持)量表中的工作控制與工作滿意度量表中的專業自主與發展呈近中度正相關(兩者皆屬內在因子)。

5. 工作滿意度量表中,支持性執業環境與組織承諾量表的相關相對略高。

6. 組織承諾量表中,情感性承諾與滿意度量表各向度相關較高呈正相關,尤其是與支持性執業環境、專業自主與發展及主管的領導風格,與其他研究結果相似,組織承諾與工作滿意度有顯著的正相關(牛美雲,2005;洪淑芬,2014;陳怡伶,2016;黃珊和王秀紅,2008)。

7. 離職意圖量表中,與工作滿意度量表各向度的相關方向如預期均呈負相關;其中,離職意圖與支持性執業環境的相關相對較高,與其他研究結果相似,張翠芬等人(2016)以中部六家地區及四家區域醫院的193位護理人員為對象,研究結果顯示離職意圖與所有工作滿意度類別(工作酬勞、工作環境、自我肯定、醫院管理制度、本質學能)均呈顯著負相關。

8. 離職意圖量表中,與組織承諾量表各向度的相關方向如預期均呈負相關,與其他研究結果相似,Porter等人(1974)進行了縱向研究,與工作滿意度的各個組成部分相比,組織承諾更能區分留任者和離職者。情感性和規範性承諾以及對薪酬的滿意度、對晉升的滿意度和對工作性質的滿意度與離職意圖呈顯著負相關,影響離職意圖的變項是情感性承諾,薪水滿意度和規範性承諾(Luz et al., 2018)。

第四節 護理人員背景變項、工作壓力、工作滿意度和組織承諾對離職意圖之迴歸分析

本節以護理人員的一般背景變項、工作壓力、工作滿意度及組織承諾對護理人員的離職意圖進行階層迴歸分析。預測變項中,一般背景變項包括:性別(男/女)、年齡(20-30歲/31-40歲/大於40歲)、教育程度(大學+碩士/高職+專科)、婚姻狀況(未婚/已婚)、目前任職醫院的護理年資(5年以下/5-10年/10年以上)、服務單位(加護病房/一般病房/呼吸病房/開刀房/門診);工作壓力包含:工作控制、工作負荷、社會支持(合併主管支持和同事支持為社會支持變項);工作滿意度包含:專業自主與發展(激勵因子)、執業環境與護理負荷(合併支持性執業環境及護理工作的負荷兩個屬工作環境的外在保健因子)、

人際互動與主管領導(合併人際互動與合作及主管的領導風格兩個屬人際社會層面的保健因子)；組織承諾包含：情感性承諾、持續性承諾、規範性承諾。分析前，先將類別變項經過虛擬變項處理，並檢視迴歸基本假定是否符合。

採用階層迴歸的目的在探討一般背景變項、工作壓力(工作負荷—控制—支持)、工作滿意度及組織承諾四個區塊變項依序進入模式時，其增進的解釋力是否達到顯著。研究者進行了模型分析：背景變項先進入，再投入工作壓力(工作負荷—控制—支持)、再投入工作滿意度，最後投入組織承諾。其主要目的在了解控制背景變項下，工作壓力、工作滿意度及組織承諾依序進入模式，對離職意圖可增加的解釋力(表 4-40)。

表 4-40 呈現依序投入一般背景變項、工作壓力(工作負荷—控制—支持)、工作滿意度與組織承諾對離職意圖的解釋力(R 平方變更)，表 4-41 呈現不同模型迴歸預測之原始迴歸係數及 R 平方。

一、不同模式中各階層變項對離職意圖的增進解釋力

由表 4-40 分析結果顯示所有變項(含虛擬變項共計 20 個變項)能解釋護理人員離職意圖 51.2%變異量，且達到顯著($F(20,264) = 13.822, p = .000$)。在模型一中，結果顯示一般背景變項可以解釋護理人員離職意圖 12.2%變異量，達到顯著($F(11,273) = 3.435, p = .000$)；在模型二中，結果顯示在一般背景變項已進入模式後，三個工作壓力(工作負荷—控制—支持)分測驗(工作控制、工作負荷、社會支持)再進入模型，兩組合併可以解釋離職意圖 27.1%變異量，達到顯著($F(14,270) = 7.186, p = .000$)，工作壓力(工作負荷—控制—支持)對離職意圖可增加 15%的解釋力且達到顯著($F(3,270) = 18.513, p = .000$)；在模型三中，結果顯示在一般背景變項和工作壓力(工作負荷—控制—支持)已進入模式後，三個工作滿意度分測驗(專業自主與發展、執業環境與護理負荷、人際互動與主管領導)再進入模型，三組合併可以解釋離職意圖 30.7%變異量，達到顯著($F(17,267) = 6.973, p = .000$)，工作滿意度對離職意圖可增加 3.6%的解釋力且達到顯著($F(3,267) = 4.628, p = .004$)；在模型四中，結果顯示在一般背景變項和工作壓力(工作負荷—控制—支持)及工作滿意度已進入模式後，三個組織承諾分測驗(情感性承諾、持續性承諾、規範性承諾)再進入模型，四組合併可以解釋離職意圖 51.2%變異量，且達到顯著($F(20,264) = 13.822, p = .000$)，組織承諾對離職意圖可增加 20.4%的解釋力且達到顯著($F(3,264) = 36.757, p = .000$)。

表 4-40

一般背景變項、工作壓力、工作滿意度、組織承諾對離職意圖之迴歸預測

模型	R	R 平方	變更統計資料				
			R 平方 變更	F 值 變更	df1	df2	顯著性 F 值變更
1.一般背景	.349	.122	.122	3.435	11	273	.000
2. 一般背景+工作壓力	.521	.271	.150	18.513	3	270	.000
3. 一般背景+工作壓力+工作滿意度	.554	.307	.036	4.628	3	267	.004
4. 一般背景+工作壓力+工作滿意度+組織承諾	.715	.512	.204	36.757	3	264	.000
全部變項	.715	.512		13.822	20	264	.000

二、不同模式中個別變項對離職意圖的獨特解釋力

除了整體的檢核外，接著檢視各個模式中，各預測變項對離職意圖的獨特解釋力（表 4-41），意即檢視在排除模式中其他變項的影響力後，該變項的獨特解釋力是否達到顯著（迴歸係數為部分迴歸係數，故其解釋受模式中所納入變項之影響），結果顯示：

（一）一般背景變項（性別、年齡、教育程度、婚姻狀況、目前任職醫院的護理年資、服務單位）投入模式時（表 4-41 的模型 1），年齡大於 40 歲（ $p < .001$ ）和服務單位為一般病房（ $p < .05$ ）的迴歸係數達到顯著，顯示年齡大於 40 歲者之離職意圖顯著低於 20-30 歲者、服務於一般病房之護理人員之離職意圖顯著低於服務於呼吸病房之護理人員。

（二）在一般背景已投入模式後，再將工作壓力（工作負荷—控制—支持）投入模式中（表 4-41 的模型 2），年齡大於 40 歲（ $p < .001$ ）和服務單位為一般病房（ $p < .01$ ）的迴歸係數仍達到顯著，另外工作壓力中的工作負荷（ $p < .001$ ）、社會支持（ $p < .001$ ）對離職意圖的個別獨特解釋力亦達到顯著，工作負荷越重，離職意圖越高；社會支持（主管和同事）支持程度越高，離職意圖越低。

（三）在一般背景和工作壓力（工作負荷—控制—支持）已投入模式後，再將工作滿意度投入模式中（表 4-41 的模型 3），年齡大於 40 歲（ $p < .001$ ）和服務單位為一般病房（ $p < .05$ ）以及「工作壓力—工作負荷」（ $p < .001$ ）對離職意圖的個別獨特解釋力仍達到顯著，但「工作壓力—社會支持」及三個工作滿意度變項對離職意圖的個別獨特解釋力卻未達到顯著。

（四）在一般背景和工作壓力（工作負荷—控制—支持）及工作滿意度已投入模式後，再將組織承諾投入模式中（表 4-41 的模型 4），年齡大於 40 歲（ $p < .001$ ）和服務單位為一般病房（ $p < .05$ ）以及「工作壓力—工作負荷」（ $p < .05$ ）對離職意圖的個別獨特解釋力仍達到顯著，另外組織承諾中的情感性承諾（ p

<.001) 和持續性承諾 ($p < .001$) 對離職意圖的個別獨特解釋力亦達到顯著，對工作的情感性或持續性承諾越高，離職意圖越低。

表 4-41

一般背景、工作壓力、工作滿意度、組織承諾對離職意圖之迴歸係數考驗

變項	模型 1	模型 2	模型 3	模型 4
(常數)	3.081***	3.029***	3.759***	5.438***
性別(男性 vs. 女性)	-.087	-.118	-.138	-.139
年齡(31-40 歲 vs. 20-30 歲)	-.040	-.134	-.091	-.081
年齡(大於 40 歲 vs. 20-30 歲)	-.429***	-.515***	-.448***	-.344***
教育程度(大學+碩士 vs. 高職+專科)	.040	.089	.090	-.033
婚姻狀況(已婚 vs. 未婚)	-.118	-.042	-.032	.000
護理年資(5-10 年 vs. 5 年以下)	.120	.037	.008	.096
護理年資(10 年以上 vs. 5 年以下)	.021	-.124	-.155	-.087
1.服務單位(加護病房 vs. 呼吸病房)	-.079	-.121	-.075	.046
服務單位(一般病房 vs. 呼吸病房)	-.268*	-.312**	-.264*	-.191*
服務單位(開刀房 vs. 呼吸病房)	-.029	.022	-.046	-.109
服務單位(門診 vs. 呼吸病房)	-.097	-.046	-.033	-.068
工作壓力-工作控制		-.114	.045	.167
工作壓力-工作負荷		.525***	.395***	.176*
工作壓力-社會支持(主管和同事)		-.352***	-.169	-.012
工作滿意-專業自主與發展			-.115	-.129
工作滿意-執業環境與護理負荷			-.181	.013
工作滿意-人際互動與主管領導			-.112	.008
組織承諾-情感性				-.463***
組織承諾-持續性				-.406***
組織承諾-規範性				-.077
R2	.122***	.271***	.307***	.512***
△ R2	.122***	.150***	.036**	.204***

註：參照組：性別-女性、年齡-20-30 歲、教育程度-高職+專科、婚姻狀況-未婚、護理年資-5 年以下、服務單位-呼吸病房

整體而言，護理人員年齡大於 40 歲和服務單位為一般病房以及工作壓力—工作負荷，對離職意圖具顯著的個別獨特解釋力，另外組織承諾中的情感性承諾和持續性承諾亦對離職意圖具顯著的個別獨特解釋力，護理人員年齡越增加、服務單位為一般病房、對工作的情感性或持續性承諾越高，離職意圖越低；而工作負荷越重，離職意圖越高。

三、結語與討論

從研究結果分析得知：(一) 以護理人員之一般背景、工作壓力（工作負荷—控制—支持）、工作滿意度及組織承諾等四組變項依序進入迴歸模型，對護理人員的離職意圖進行解釋，依序可以增加 12.2%、15.0%、3.6%、20.4% 的變異量，共可解釋 51.2% 的變異，皆達統計上顯著。(二) 在一般背景變項、工作壓力（工

作負荷—控制—支持)、工作滿意度與組織承諾依序投入模型時，組織承諾所增進的解釋力較其他變項為高。(三)護理人員年齡大於 40 歲和服務單位為一般病房以及「工作壓力—工作負荷」，對離職意圖具顯著的個別獨特解釋力，另外組織承諾中的情感性承諾和持續性承諾亦對離職意圖具顯著的個別獨特解釋力，護理人員年齡越增加（大於 40 歲組離職意圖低於 20-30 歲組）、服務單位為一般病房（離職意圖低於呼吸病房）、對工作的情感性或持續性承諾越高，離職意圖越低；而工作負荷越重，離職意圖越高。此研究結果與黃穗芬（2011）針對護理人員的研究發現，護理人員工作壓力並不是影響離職傾向的唯一因素，還包括工作滿意度和組織承諾之研究結果相似。

第五節 工作壓力與離職意圖關係中工作滿意度及組織承諾之序列中介模型分析

本節探討護理人員工作壓力（工作負荷—控制—支持）是否先透過工作滿意度再透過組織承諾之序列性間接中介效果路徑影響離職意圖；也就是工作壓力是否透過先影響工作滿意度，再影響組織承諾，最後再影響離職意圖。

由於工作壓力（工作負荷—控制—支持）、工作滿意度及組織承諾各組變項均有 3~5 個向度，為避免使用向度分數進行中介模型考驗會過度繁瑣，而使用向度總分可能無法呈現變項間的真實關係，故研究者根據 Karasek 與 Theorell（1990）提出的工作負荷—控制—支持模式（JDCA model），將工作壓力（工作負荷—控制—支持）分為工作控制、工作負荷、社會支持（主管和同事）三個面向；根據雙因子激勵與保健滿意度理論，將滿意度分為專業自主與發展（屬內在激勵因子）、執業環境與護理負荷（屬外在保健因子中對工作環境的滿意度）、人際互動與主管領導（屬外在保健因子中對人際的滿意度）三個面向；由於組織承諾三分量表之相關皆接近（如表 4-39 所示），故將情感性、持續性和規範性承諾合併為一個全量表分數，並進行各分量表合併後的相關分析（表 4-42），結果顯示，「工作壓力—工作控制」與「工作滿意—專業自主與發展」的相關較高呈中度正相關（ $r=.436$ ），「工作壓力—工作負荷」與「工作滿意—執業環境與護理負荷」的相關較高呈中度略偏低負相關（ $r=-.336$ ），「工作壓力—社會支持（主管和同事）」與「工作滿意—人際互動與主管領導」的相關較高呈中度偏高正相關（ $r=.583$ ）。

表 4-42

工作壓力、工作滿意度、組織承諾與離職意圖分量表合併後之相關摘要表

	1	2	3	4	5	6	7	8
工作壓力								
1.工作控制	1							
2.工作負荷	.141*	1						
3.社會支持	.307***	-.032	1					
工作滿意度								
4.專業自主與發展	.436***	-.169**	.381***	1				
5.執業環境與護理負荷	.304***	-.336***	.404***	.649***	1			
6.人際互動與主管領導	.291***	-.195**	.583***	.664***	.605***	1		
7.組織承諾	.278***	-.277***	.341***	.402***	.522***	.435***	1	
8.離職意圖	-.118*	.298***	-.182**	-.334***	-.371***	-.325***	-.618***	1

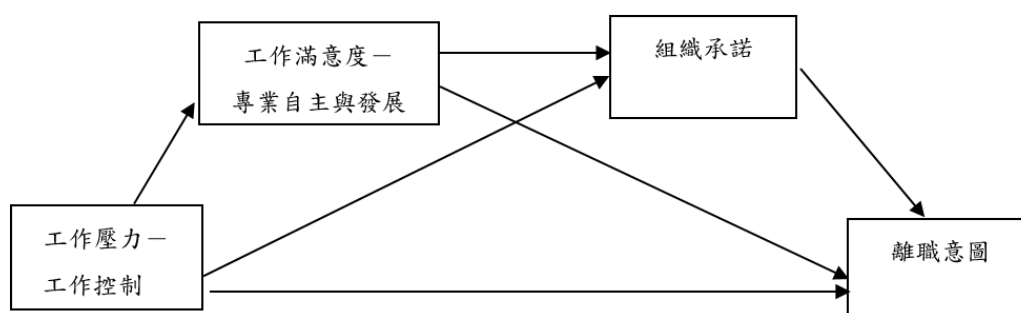
* $P = 0.05$, ** $P = 0.01$, *** $P = 0.001$ 。

接著根據各分量表合併後的相關分析結果進行分組，考驗三個序列的中介模型：(一) 工作壓力－工作控制→工作滿意－專業自主與發展→組織承諾→離職意圖（圖 4-1a）；(二) 工作壓力－工作負荷→工作滿意－執業環境與護理負荷→組織承諾→離職意圖（圖 4-1b）；(三) 工作壓力－社會支持（主管和同事）→ 工作滿意－人際互動與主管領導→組織承諾→離職意圖（圖 4-1c）。

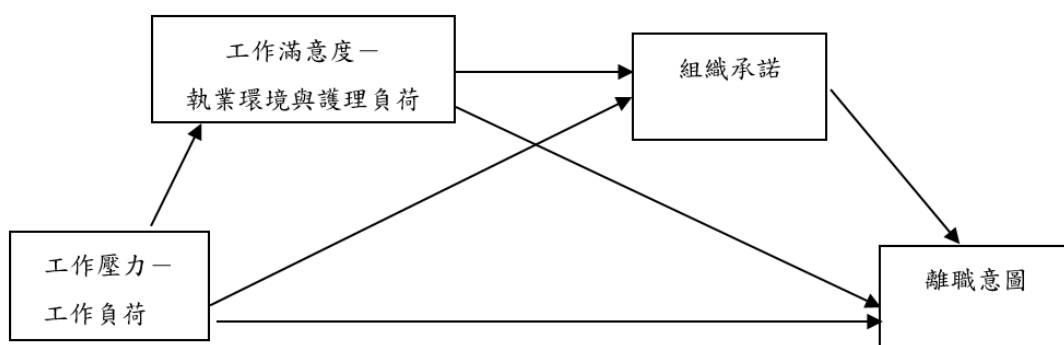
圖 4-1

工作壓力與離職意圖關係中工作滿意度及組織承諾之序列中介模型

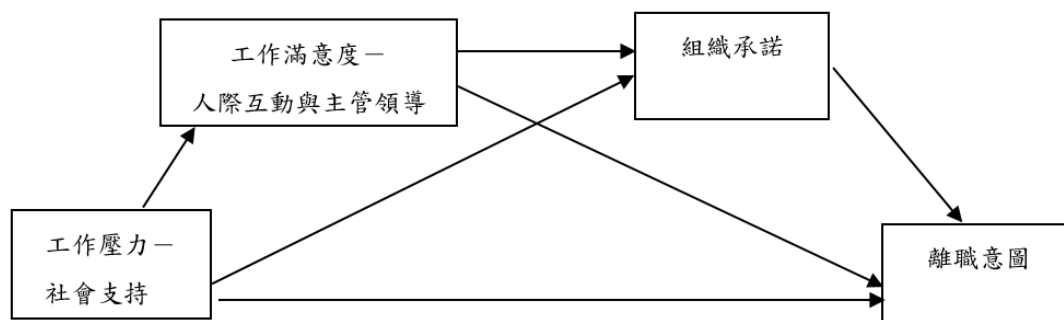
(4-1a)



(4-1b)



(4-1c)



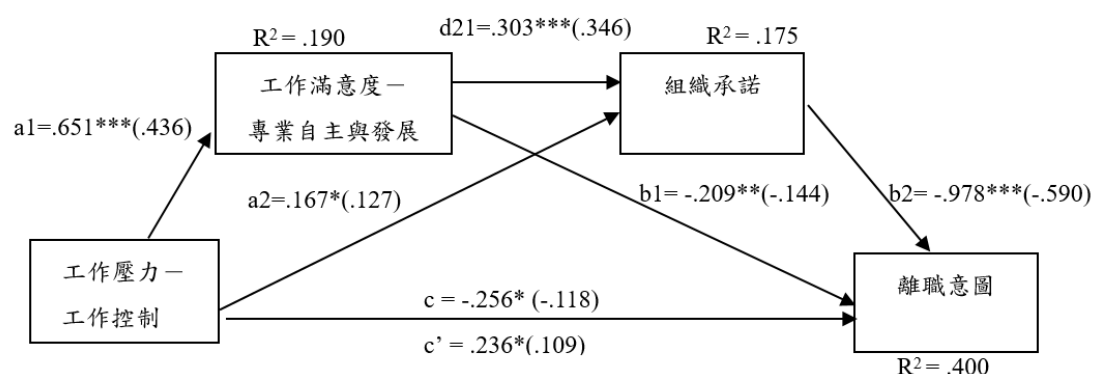
研究者以 PROCESS 軟體 (Hayes,2020) 分析工作壓力 (工作壓力—工作控制、工作壓力—工作負荷、工作壓力—社會支持 (主管和同事))、工作滿意度 (激勵因子：工作滿意—專業自主與發展，保健因子：工作滿意—執業環境與護理負荷、工作滿意—人際互動與主管領導) 及組織承諾 (情感性承諾、持續性承諾、規範性承諾) 對離職意圖的直接效果，以及工作壓力 (工作負荷—控制—支持) 透過工作滿意度和組織承諾對離職意圖產生的兩個間接效果：(一) 工作壓力→工作滿意度→離職意圖；(二) 工作壓力→組織承諾→離職意圖；及工作壓力 (工作負荷—控制—支持) 先透過工作滿意度再透過組織承諾對離職意圖產生的序列性間接中介效果：工作壓力→工作滿意度→組織承諾→離職意圖。

一、「工作滿意—專業自主與發展」與組織承諾為「工作壓力—工作控制」與離職意圖之中介模型考驗

本小節考驗護理人員的「工作壓力—工作控制」是否透過「工作滿意—專業自主與發展」影響組織承諾，再影響離職意圖。圖 4-2 為「工作滿意—專業自主與發展及與組織承諾為工作壓力—工作控制與離職意圖之序列中介假設模型」、表 4-43 為「工作滿意—專業自主與發展與組織承諾為工作壓力—工作控制與離職意圖之序列中介模型—直接及間接效果 (依變項為離職意圖)」。

圖 4-2

「工作滿意—專業自主與發展」與組織承諾為「工作壓力—工作控制」與離職意圖之序列中介假設模型



註：() 內為標準化係數

表 4-43

「工作滿意－專業自主與發展」與組織承諾為「工作壓力－工作控制」與離職意圖之序列中介模型－直接及間接效果（依變項為離職意圖）

	直接效果				間接效果					
	→工作滿意 -專業自主與發展		→組織承諾		→離職意圖		未標準化估計值		標準化估計值	
	b(SE)	β	b(SE)	β	b(SE)	β	b(SE)	Bootstrap 95% CI	β	Bootstrap 95% CI
工作壓力-工作控制	.651(.080)***	.436	.167(.079)*	.127	.236(.112)*	.109				
工作滿意-專業自主與發展			.303(.053)***	.346	-.209(.079)**	-.144				
組織承諾					-.978(.084)***	-.590				
全部效果(total TE)					-.256(.128)*	-.118				
全部間接效果(total IE)							-.492(.100)	[-.680,-.287]*	-.227	[-.323,-.127]*
IE1:工作壓力-工作控制→工作滿意-專業自主與發展→離職意圖							-.136(.057)	[-.255,-.027]*	-.063	[-.122,-.012]*
IE2:工作壓力-工作控制→組織承諾→離職意圖							-.163(.075)	[-.313,-.020]*	-.075	[-.144,-.009]*
IE3:工作壓力-工作控制→工作滿意-專業自主與發展→組織承諾→離職意圖							-.193(.044)	[-.288,-.113]*	-.089	[-.131,-.052]*
間接效果比較										
IE1 minus IE2							.027(.094)	[-.157,.218]n.s.	.012	[-.072,.097]n.s.
IE1 minus IE3							.057(.071)	[-.079,.206]n.s.	.026	[-.038,.093]n.s.
IE2 minus IE3							.030(.092)	[-.150,.216]n.s.	.014	[-.069,.097]n.s.
R2	.190***		.175***		.400***					
	F (1,283) = 66.34		F (2,282) = 29.81		F (3,281) = 62.45					

註：95% Bootstrap CI 是以重複抽樣 5000 次所建立的。CI 未包含 0 時，表示達到.05 的顯著水準。

從圖 4-2 和表 4-43 檢視中介模型中的直接效果路徑，直接效果的路徑係數皆達顯著。由考驗結果可得知：(一)「工作壓力－工作控制」為自變項對「工作滿意度－專業自主與發展」為依變項的直接效果達顯著 ($\beta=.436, p<.001$)，表示護理人員知覺到的工作控制程度越高，其專業自主與發展的工作滿意度就越高；(二)以組織承諾為依變項時，「工作壓力－工作控制」為自變項，在排除專業自主及發展的滿意度影響力後，對組織承諾的直接效果達顯著 ($\beta=.127, p<.05$)，表示護理人員對工作控制的程度越高，其承諾感就越高；「工作滿意度－專業自主與發展」為自變項，在排除工作控制影響力後，對組織承諾的直接效果達顯著 ($\beta=.346, p<.001$)，表示護理人員對專業自主及發展越感滿意，其承諾感就越高；(三)以離職意圖為依變項，以工作控制、專業自主與發展滿意度、組織承諾為自變項，在排除模式中其他自變項的影響後，工作控制 ($\beta=.109, p<.05$)、專業自主與發展滿意 ($\beta=-.144, p<.01$) 及組織承諾 ($\beta=-.590, p<.001$) 對離職意圖的直接效果仍達顯著，其中組織承諾對離職意圖的直接效果較其他變項為高，表示工作壓力－工作控制、工作滿意－專業自主與發展及組織承諾對離職意圖都具顯著的影響力，又以組織承諾的影響力較高。

接著再從表 4-43 檢視中介模型中的間接效果路徑，三個間接效果的總和達到統計上的顯著 (全部間接效果 $=-.492$)，三個間接效果皆達顯著。間接效果的考驗有幾點發現：(一)工作壓力－工作控制→工作滿意－專業自主與發展→離職意圖」達顯著 ($IE1 = -.136 [-.255, -.027]$)，表示知覺工作控制感的提高，會透過提高對專業自主與發展的滿意度，再間接降低離職意圖；(二)「工作壓力－工作控制 →組織承諾→離職意圖」達顯著 ($IE2 = -.163 [-.313, -.020]$)，表示知覺工作控制感的提高，也會透過提高對組織的承諾，再間接降低離職意圖；(三)「工作壓力－工作控制 →工作滿意－專業自主與發展→組織承諾→離職意圖」的序列性間接中介效果達顯著 ($IE3 = -.193 [-.288, -.113]$)，表示工作控制會先透過提高對專業自主與發展的滿意，再提高組織承諾，最後再降低離職意圖；(四)三條間接路徑的差異皆達到統計上的顯著。

總結，護理人員的知覺的工作控制感會透過三條間接路徑影響離職意圖，一條路徑是透過提高對專業自主與發展的滿意，來降低離職意圖，一條路徑是透過提高組織承諾，來降低離職意圖，另一條路徑是以序列性間接中介效果，先提高對專業自主與發展的工作滿意度，再繼之提高組織承諾感，最後再降低離職意圖；值得注意的是，護理人員工作控制對離職意圖具直接效果，由於直接效果係數為正，表示當排除專業自主與發展滿意、職業承諾的影響力後，工作控制感較高者，

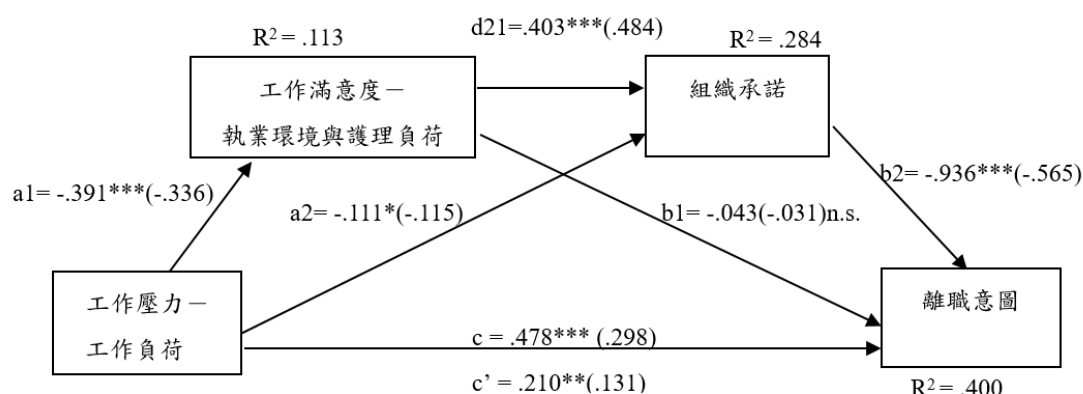
其離職意圖反而較高，此是否暗示當工作控制感未能帶來專業自主與發展的滿意及組織承諾時，護理人員反而傾向選擇離職。

二、「工作滿意－執業環境與護理負荷」與組織承諾為「工作壓力－工作負荷」與離職意圖之中介模型考驗

本小節考驗護理人員的「工作壓力－工作負荷」是否透過「工作滿意－執業環境與護理負荷」影響組織承諾，再影響離職意圖。圖 4-3 為「工作滿意－執業環境與護理負荷」與組織承諾為工作壓力－工作負荷與離職意圖之序列中介假設模型、表 4-44 為「工作滿意－執業環境與護理負荷」與組織承諾為工作壓力－工作負荷與離職意圖之序列中介模型－直接及間接效果（依變項為離職意圖）。

圖 4-3

「工作滿意－執業環境與護理負荷」與組織承諾為「工作壓力－工作負荷」與離職意圖之序列中介假設模型



註：() 內為標準化係數

接著從圖 4-3 和表 4-44 檢視中介模型中的直接效果路徑，除了「工作滿意－執業環境與護理負荷」至離職意圖的直接效果路徑係數未達顯著，其他直接效果的路徑係數皆達顯著。由考驗結果可得知：（一）以「工作滿意－執業環境與護理負荷」為依變項時，「工作壓力－工作負荷」對「工作滿意－執業環境與護理負荷」的直接效果達顯著（ $\beta = -.391, p < .001$ ），表示護理人員知覺到的工作負荷程度越高，其執業環境與護理負荷的工作滿意度就越低；（二）以組織承諾為依變項時，「工作壓力－工作負荷」為自變項，在排除執業環境與護理負荷的滿意度影響力後，對組織承諾的直接效果達顯著（ $\beta = -.111, p < .05$ ），表示護理人員感受到的工作負荷程度越高，其承諾感就越低；「工作滿意－執業環境與護理負荷」

為自變項，在排除工作負荷影響力後，對組織承諾的直接效果達顯著 ($\beta = .403$, $p < .001$)，表示護理人員對執業環境與護理負荷的滿意度越高，其承諾感就越高；

(三) 以離職意圖為依變項，以工作負荷、執業環境與護理負荷、組織承諾為自變項，在排除模式中其他自變項的影響後，工作負荷 ($\beta = .210$, $p < .01$) 及組織承諾 ($\beta = -.936$, $p < .001$) 對離職意圖的直接效果仍達顯著，其中組織承諾對離職意圖的直接效果較工作負荷為高，表示工作壓力—工作負荷、及組織承諾對離職意圖都具顯著的影響力，又以組織承諾的影響力較高。

接著再從表 4-44 檢視中介模型中的間接效果路徑，三個間接效果的總和達到統計上的顯著 (全部間接效果 = .269)，三個間接效果只有工作壓力—工作負荷→工作滿意—執業環境與護理負荷→組織承諾→離職意圖的序列性間接中介效果達顯著。間接效果的考驗有幾點發現：(一)「工作壓力—工作負荷→工作滿意—執業環境與護理負荷→組織承諾→離職意圖」的序列性間接中介效果達顯著 ($IE3 = .147[.076, .230]$)，表示工作負荷會透過降低對執業環境與護理負荷的滿意，再降低組織承諾，最後再提高離職意圖；(二)「工作壓力—工作負荷→工作滿意—執業環境與護理負荷→離職意圖」($IE1 = .017[-.048, .095]$) 和「工作壓力—工作負荷→組織承諾→離職意圖」($IE2 = .104[-.007, .227]$) 皆未達顯著，表示排除組織承諾的影響，「工作壓力—工作負荷」不會透過「工作滿意—執業環境與護理負荷」影響離職意圖，排除「工作滿意—執業環境與護理負荷」的影響，「工作壓力—工作負荷」不會透過組織承諾影響離職意圖。

總結，護理人員知覺到的工作負荷壓力，主要是以序列性中介的間接方式，先降低對執業環境與護理負荷的滿意度，再降低組織承諾，最後再提高其離職意圖；特別值得注意的是，工作負荷壓力除了透過上述路徑提高離職意圖外，仍然會以直接路徑的方式提高離職意圖。

表 4-44

「工作滿意－執業環境與護理負荷」與組織承諾為「工作壓力－工作負荷」與離職意圖之序列中介模型－直接及間接效果（依變項為離職意圖）

	直接效果				間接效果				
	→工作滿意 -執業環境與護理負荷		→組織承諾		→離職意圖		未標準化估計值		標準化估計值
	b(SE)	β	b(SE)	β	b(SE)	β	b(SE)	Bootstrap 95% CI	β Bootstrap 95% CI
工作壓力-工作負荷	-.391(.065)***	-.336	-.111(.052)*	-.115	.210(.079)**	.131			
工作滿意-執業環境與護理負荷			.403(.045)***	.484	-.043(.077)n.s.	-.031			
組織承諾					-.936(.091)***	-.565			
全部效果(total TE)					.478(.091)***	.298			
全部間接效果(total IE)							.269(.075)	[.129,.424]*	.167 [.081,.257]*
IE1: 工作壓力-工作負荷→工作滿意-執業環境與護理負荷→離職意圖							.017(.036)	[-.048,.095]n.s.	.011 [-.030,.060]n.s.
IE2: 工作壓力-工作負荷→組織承諾→離職意圖							.104(.059)	[-.007,.227]n.s.	.065 [-.004,.139]n.s.
IE3: 工作壓力-工作負荷→工作滿意-執業環境與護理負荷→組織承諾→離職意圖							.147(.040)	[.076,.230]*	.092 [.049,.141]*
間接效果比較									
IE1 minus IE2							-.087(.073)	[-.238,.054]n.s.	-.054 [-.144,.034]n.s.
IE1 minus IE3							-.131(.053)	[-.241,-.033]*	-.081 [-.147,-.021]*
IE2 minus IE3							-.043(.072)	[-.188,.097]n.s.	-.027 [-.114,.059]n.s.
R2	.113***		.284***		.400***				
	F (1,283) = 36.08		F (2,282) = 56.05		F (3,281) = 62.43				

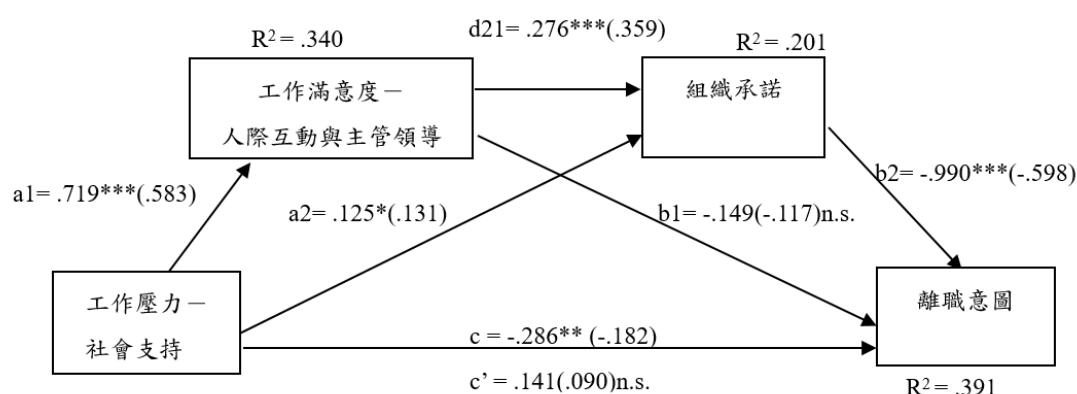
註：95% Bootstrap CI 是以重複抽樣 5000 次所建立的。CI 未包含 0 時，表示達到 .05 的顯著水準。

三、「工作滿意—人際互動與主管領導」與組織承諾為「工作壓力—社會支持（主管和同事）」與離職意圖之中介模型考驗

本小節考驗護理人員的「工作壓力—社會支持（主管和同事）」是否透過「工作滿意—人際互動與主管領導」影響組織承諾，再影響離職意圖。圖 4-4 為「工作滿意—人際互動與主管領導與組織承諾為工作壓力—社會支持（主管和同事）」與離職意圖之序列中介假設模型」、表 4-45 為「工作滿意—人際互動與主管領導與組織承諾為工作壓力—社會支持（主管和同事）」與離職意圖之序列中介模型—直接及間接效果（依變項為離職意圖）」。

圖 4-4

「工作滿意—人際互動與主管領導」與組織承諾為「工作壓力—社會支持（主管和同事）」與離職意圖之序列中介假設模型



接著從圖 4-4 和表 4-45 檢視中介模型中的直接效果路徑，直接效果的路徑係數除了工作壓力—社會支持（主管和同事）至離職意圖和工作滿意—人際互動與主管領導至離職意圖直接效果路徑未達顯著，其他直接效果路徑達顯著。由考驗結果可得知：（一）「工作壓力—社會支持（主管和同事）」為自變項對「工作滿意—人際互動與主管領導」依變項的直接效果達顯著（ $\beta = .719$ ， $p < .001$ ），表示護理人員知覺到的社會支持（主管和同事）程度越高，其人際互動與主管領導的工作滿意度就越高；（二）以組織承諾為依變項時，「工作壓力—社會支持（主管和同事）」為自變項，在排除人際互動與主管領導的滿意度影響力後，對組織

承諾的直接效果達顯著 ($\beta = .125, p < .05$)，表示護理人員感受到的社會支持（主管和同事）程度越高，其組織承諾越高；「工作滿意—人際互動與主管領導」為自變項，在排除社會支持（主管和同事）影響力後，對組織承諾的直接效果達顯著 ($\beta = .276, p < .001$)，表示護理人員對人際互動與主管領導越感滿意，其承諾感就越高；（三）以離職意圖為依變項時，在排除模式中其他自變項的影響後，只有組織承諾對離職意圖的直接效果達到顯著，表示組織承諾對離職意圖具顯著的影響力。

接著再從表 4-45 檢視中介模型中的間接效果路徑，三個間接效果的總和達到統計上的顯著（全部間接效果 = -.426），三個間接效果只有工作壓力—社會支持（主管和同事）→工作滿意—人際互動與主管領導→組織承諾→離職意圖的序列性間接中介效果達顯著。間接效果的考驗有幾點發現：（一）「工作壓力—社會支持（主管和同事）→工作滿意—人際互動與主管領導→組織承諾→離職意圖」的序列性間接中介效果達顯著（ $IE3 = -.196[-.297, -.115]$ ），表示社會支持（主管和同事）會先透過提高對人際互動與主管領導的滿意，再提高組織承諾，最後再降低離職意圖；2. 「工作壓力—社會支持（主管和同事）→工作滿意—人際互動與主管領導→離職意圖」（ $IE1 = -.107[-.234, .028]$ ）和「工作壓力—社會支持（主管和同事）→組織承諾→離職意圖」（ $IE2 = -.123[-.260, .004]$ ）皆未達顯著，表示排除組織承諾的影響，「工作壓力—社會支持（主管和同事）」不會透過「工作滿意—人際互動與主管領導」影響離職意圖，排除「工作滿意—人際互動與主管領導」的影響，「工作壓力—社會支持（主管和同事）」不會透過組織承諾影響離職意圖。

總結，護理人員知覺到的「工作壓力—社會支持（主管和同事）」主要是透過間接序列中介的路徑，先提高對人際互動及主管領導的滿意度，再提高對組織的承諾，最後降低離職意圖；值得注意的是，當人際互動及主管領導滿意及組織承諾納入模型後，工作壓力中的社會支持面向即不對，離職意圖有任何影響（即：直接效果未達顯著）。

表 4-45

「工作滿意－人際互動與主管領導」與組織承諾為「工作壓力－社會支持（主管和同事）」與離職意圖之序列中介模型－直接及間接效果
（依變項為離職意圖）

	直接效果				間接效果					
	→工作滿意 -人際互動與主管領導 b(SE)	β	→組織承諾 b(SE)	β	→離職意圖 b(SE)	β	未標準化估計值		標準化估計值	
							b(SE)	Bootstrap 95% CI	β	Bootstrap 95% CI
工作壓力-社會支持 (主管和同事)	.719(.060)***	.583	.125(.062)*	.131	.141(.091)n.s.	.090				
工作滿意-人際互動與主管領導 外在組織承諾(持續性)			.276(.050)***	.359	-.149(.077)n.s.	-.117				
					-.990(.086)***	-.598				
全部效果(total TE)					-.286(.092)**	-.182				
全部間接效果(total IE)							-.426(.088)	[-.602,-.255]*	-.272	[-.377,-.165]*
IE1: 工作壓力-社會支持(主管和同事)→工作滿意-人際互動與主管領導→離職意圖							-.107(.067)	[-.234,.028]n.s.	-.068	[-.152,.017]n.s.
IE2: 工作壓力-社會支持(主管和同事)→組織承諾→離職意圖							-.123(.067)	[-.260,.004]n.s.	-.079	[-.163,.003]n.s.
IE3: 工作壓力-社會支持(主管和同事)→工作滿意-人際互動與主管領導→組織承諾→離職意圖							-.196(.047)	[-.297,-.115]*	-.125	[-.186,-.075]*
間接效果比較										
IE1 minus IE2							.016(.102)	[-.174,.223]n.s.	.010	[-.110,.141]n.s.
IE1 minus IE3							.089(.083)	[-.064,.259]n.s.	.057	[-.042,.163]n.s.
IE2 minus IE3							.073(.093)	[-.102,.264]n.s.	.047	[-.066,.167]n.s.
R2	.340***		.201***		.391***					
	F (1,283) = 145.95		F (2,282) = 35.47		F (3,281) = 60.11					

註：95% Bootstrap CI 是以重複抽樣 5000 次所建立的。CI 未包含 0 時，表示達到.05 的顯著水準。

三、結語與討論

本節研究結果發現，(一) 護理人員的工作壓力—工作控制會透過直接效果路徑和三條間接路徑影響離職意圖，三條間接路中透過先影響專業自主與發展的工作滿意度，接著再影響組織承諾的序列性間接中介效果路徑，影響離職意圖較強；(二) 護理人員的工作壓力—工作負荷會透過直接效果路徑影響離職意圖，也會透過先影響工作滿意—執業環境與護理負荷，接著再影響組織承諾的序列性間接中介效果路徑影響離職意圖；(三) 護理人員的工作壓力—社會支持（主管和同事）不會透過直接路徑影響離職意圖，只會透過先影響工作滿意—人際互動與主管領導，接著再影響組織承諾的序列性間接中介效果路徑影響離職意圖。(四) 工作壓力（工作壓力—工作控制、工作壓力—工作負荷、工作壓力—社會支持（主管和同事））、工作滿意度（激勵因子：工作滿意—專業自主與發展，保健因子：工作滿意—執業環境與護理負荷、工作滿意—人際互動與主管領導）及組織承諾（情感性承諾、持續性承諾和規範性承諾）對離職意圖的直接效果中，組織承諾對離職意圖的直接影響效果高於其他變項。(五) 工作壓力（工作負荷—控制—支持）均會透過先影響工作滿意度，接著再影響組織承諾的序列性間接中介效果路徑影響離職意圖。

以往探討護理人員工作壓力、工作滿意度、組織承諾和離職意圖的相關研究，大多是探討兩兩變項間的相關，例如：工作壓力及工作滿意度存在著密切關係，工作壓力與工作滿意度呈現顯著負向相關（林采怡和林弘昌，2019；張偉斌等人，2020；黃穗芬等人，2011）；工作壓力與情感性承諾、規範性承諾均為負相關，而與持續性承諾呈正相關（洪淑芬，2014；陳小芳，2012；彭士哲和曾淑萍，2021；Yaghoubi et al., 2009）；工作滿意度愈高者，對於單位之組織承諾亦愈高（廖茂宏等人，2007）；工作壓力不但與離職有關也是預測離職一個非常重要的變項（陳梅麗等人，2000）；護理人員對機構中的學習成長機會越滿意，離職傾向的意願越低（陳自立，2005）；組織承諾顯著預測了護理人員的離職意向（De Gieter 等人，2011）。至於三者間的相關，工作壓力大、工作滿意度低時，離職意向則愈趨增高（張靖梅和林獻鋒，2021；張翠芬等人，2016；Sari et al., 2021）；當個人承受的工作壓力較低時，可以提升個人的組織承諾，進而降低離職傾向（沈昭吟和詹昆霖，2013；蔡李玉卿，2009 Husnah 和 Hasyim, 2020；Rindu et al., 2020）。

由於文獻中較少同時探討四個變項間的路徑關係，本研究整合以往的研究發現結果，並參考 Bluedorn (1982) 的綜合離職模式，提出工作壓力、工作滿意度、組織承諾和離職意圖四者的路徑關係，並根據 Karasek 與 Theorell (1990) 提出的工作負荷—控制—支持模式（JDCA model），將工作壓力（工作負荷—控制—

支持) 分為(工作壓力—工作控制、工作壓力—工作負荷、工作壓力—社會支持(主管和同事)) 三個向度, 工作滿意度依照題意向度分為(激勵因子: 工作滿意—專業自主與發展, 保健因子: 工作滿意—執業環境與護理負荷、工作滿意—人際互動與主管領導) 三個向度, 將情感性承諾、持續性承諾和規範性承諾合併為組織承諾一個向度, 進行工作壓力(工作負荷—控制—支持) 對離職意圖的直接效果, 以及工作壓力(工作負荷—控制—支持) 是否先透過工作滿意度再透過組織承諾對離職意圖產生序列性間接中介效果的考驗。

本研究發現工作壓力(工作負荷—控制—支持) 部分會透過直接效果影響離職意圖, 但是均會透過先影響工作滿意度, 接著再影響組織承諾的序列性間接中介效果路徑影響離職意圖, 與 Bluedorn (1982) 的綜合離職模式的提到的工作滿意和組織承諾是三大類前置變項和離職的過程中具有影響的中介變項(Bluedorn, 1982) 結果一致。

第五章 研究結論、討論與建議

本研究旨在探討某醫療體系所屬北、中、南各區地區醫院護理人員工作壓力（工作負荷—控制—支持）、工作滿意度、組織承諾和離職意圖的現況及不同背景的護理人員在工作壓力（工作負荷—控制—支持）、工作滿意度、組織承諾和離職意圖上的差異；四組變項的相關；護理人員背景變項、工作壓力（工作負荷—控制—支持）、工作滿意度、組織承諾對離職意圖的解釋力；以及工作滿意度及組織承諾是否為工作壓力（工作負荷—控制—支持）與離職意圖的序列中介變項。將上述施測結果進行分析及整理結論後進行討論，並對護理人力資源管理策略和研究上提出具體建議，提供醫院管理者及單位主管在研擬護理人力資源管理策略之參考。本章分為三節，第一節為研究結論；第二節為討論；第三節為建議。

第一節 研究結論

研究結論如下。

一、護理人員工作壓力、工作滿意度、組織承諾與離職意圖之現況

（一）地區型醫療機構中護理人員在「工作負荷—控制—支持」理論之工作壓力面向，知覺社會支持的程度高過知覺工作負荷及工作控制的程度。

（二）在「激勵—保健」理論之工作滿意面向，「人際互動與合作」和「主管的領導風格」保健因子的滿意度較高，其次為「專業自主與發展」激勵因子，最後為「護理工作的負荷」和「支持性執業環境」保健因子。

（三）組織承諾面向以「情感性」承諾較高，其次為「持續性」承諾和「規範性」承諾。

（四）離職意圖則屬中度偏低，離開目前任職醫院的意圖不強烈。

二、不同背景護理人員在工作壓力、工作滿意度、組織承諾與離職意圖上之差異

（一）在「工作負荷—控制—支持」理論之工作壓力面向，僅不同性別、年齡及目前任職醫院護理年資者有差異（男性在同事支持上高於女性、20-30 歲組知覺之主管支持度高過其他年齡層、年資大於 10 年組知覺之工作負荷度高過其他年資組，而年資 5 年以下組知覺之社會支持度高過其他年資組）。

（二）在「激勵—保健」理論之工作滿意面向，僅不同服務單位者有差異（加護病房在保健因子的支持性執業環境上滿意度高過其他單位）。

（三）在組織承諾面向，僅不同年齡、婚姻狀況者有差異（大於 40 歲、已婚者組在情感性和規範性承諾上高過其他組）。

(四) 在離職意圖方面，僅不同年齡、婚姻狀況及目前任職醫院護理年資者有差異(20-30 歲組、未婚者、年資 5-10 年組離職意圖高過其他組)。

三、護理人員工作壓力、工作滿意度、組織承諾與離職意圖之相關

(一) 工作壓力(工作負荷—控制—支持)量表中「工作控制、主管支持、同事支持」與工作滿意度量表及組織承諾量表呈低至中度正相關，與離職意圖呈低度負相關；而「工作負荷」與工作滿意度量表及組織承諾量表呈低度負相關，與離職意圖呈低度正相關。工作壓力量表「主管支持」與工作滿意度量表「主管的領導風格」、「支持性執業環境」及組織承諾量表的相關相對略高

(二) 工作滿意度量表與組織承諾量表呈低至中度正相關，與離職意圖呈低至中度偏低度負相關。工作滿意度量表「支持性執業環境」與組織承諾量表相關相對略高；組織承諾量表「情感性」承諾與工作滿意度量表各向度的相關相對略高，尤其是「支持性執業環境」、「專業自主與發展」及「主管的領導風格」。

(三) 離職意圖量表與組織承諾量表呈中度偏低至中度負相關。離職意圖與工作壓力(工作負荷—控制—支持)量表「主管支持」、工作滿意度量表「支持性執業環境」、「專業自主與發展」、「主管的領導風格」及組織承諾量表「情感性」和「持續性」的相關性相對較高。

四、護理人員背景變項、工作壓力、工作滿意度和組織承諾對離職意圖之階層迴歸解釋

以護理人員之一般背景、工作壓力(工作負荷—控制—支持)、工作滿意度及組織承諾等四組變項依序進入迴歸模型，對護理人員的離職意圖進行解釋，皆達統計上顯著。在不同階層模型中，年齡、服務單位、工作負荷壓力、情感性及持續性承諾對離職意圖的獨特解釋力都達顯著(40 歲以上低過 20-30 歲；一般病房低過呼吸病房；工作負荷壓力越高，離職意圖越高；情感性及持續性承諾越高，離職意圖越低)。

五、工作壓力與離職意圖關係中工作滿意度及組織承諾之序列中介效果

工作壓力(工作負荷—控制—支持)主要均是透過先影響工作滿意度，接著再影響組織承諾的序列性間接中介效果路徑影響離職意圖：

(一) 工作控制(工作壓力)→對專業自主與發展的滿意(滿意度激勵因子)→組織承諾→離職意圖的序列中介效果達顯著。在序列中介效果外，工作控制也會透過提高「專業自主與發展滿意」來降低離職意圖；提高組織承諾來降低離職意圖。亦會直接提高離職意圖。在排除專業自主與發展滿意、組織承諾的影響力後，工作控制對離職意圖的直接效果亦達顯著，但工作控制感較高者，其離職意圖反而較高。

(二) 工作負荷(工作壓力)→執業環境與護理負荷(滿意度保健因子)→組織承諾→離職意圖的序列中介效果達顯著。除序列中介效果外，工作負荷尚會直接提高離職意圖。

(三) 主管／同事社會支持(工作壓力)→人際互動與主管領導(滿意度保健因子)→組織承諾→離職意圖序列中介效果達顯著。

第二節 討論

本節根據「工作負荷—控制—支持」壓力、工作滿意度、組織承諾和離職意圖的現況；不同背景的護理人員在四組變項上的差異；四組變項的相關；護理人員背景變項、工作壓力、工作滿意度、組織承諾對離職意圖的解釋力；以及工作滿意度及組織承諾是否為工作壓力與離職意圖的序列中介變項的研究結果結論進行進一步的討論。

(一) 本研究發現在地區型醫療機構中的護理人員在護理人員工作壓力(工作負荷—控制—支持)的四個面向平均數上，感受到來自社會支持的程度高過感受到的工作負荷及工作控制，且護理人員工作滿意度的五個面向方面平均數，也是以和人際互動有關的保健因子「人際互動與合作」和「主管的領導風格」滿意度較高，其次依序為激勵因子「專業自主與發展」、保健因子「護理工作的負荷」和「支持性執業環境」，推論其原因可能為，地區醫院相較於醫學中心或區域醫院，雖然規模較小、人力配置較少、護病比例較高(最高可達 1:15)且護理工作分工較不清需身兼數職(張曉立，2021)，但是主管和護理人員及護理人員和同事間較為熟稔且彼此工作合作互動緊密，主管除了行政庶務的處理和單位管理，也須在臨床現場支援協助或一起擔任照護人力的角色，因此護理團隊之人際支持互動關係及工作氣氛較佳。在 JDCA 模式中，社會支持會減輕高壓力工作(高負荷，低控制)所產生的負面結果，高鳳霞和鄭伯璦(2014)提到在高工作要求情況下，社會支持有助於提升員工對於工作完成的信心與受到相互關懷的感受。然而，地區型醫療機構中的護理人員在「支持性執業環境」(各項作業的資訊化、退休制度及升遷機會)滿意度最低，此結果與林采怡和林弘昌(2019)以某區域教學醫院 207 位臨床護理人員為對象的研究結果，滿意度最低的為「護理工作的負荷」略有不同，推論其原因可能為，地區醫院和區域教學醫院在設置標準、福利制度、設備及工作複雜度上的不同所導致。

(二) 本研究發現在地區型醫療機構中的護理人員(年齡為 20-30 歲組、婚姻狀況為未婚者、目前任職醫院護理年資為 5-10 年組、工作負荷越重)，離職意圖較高；而護理人員(年齡越增加(大於 40 歲組離職意圖低於 20-30 歲組)、服務單位為一般病房(離職意圖低於呼吸病房)、對工作的情感性或持續性承諾越高)，離職意圖越低。本研究之發現與有的研究相似，在年齡越輕者其離職意圖越高部分，離職意圖隨著年齡提升而下降(王金蓮等人，2017)，年齡為 25 歲以下，比 25 至 34 歲及 35 歲以上護理人員有較高離職傾向(陳國珣等人，2006)。在未婚者離職意圖高過已婚者部分，黃慧文(2017)研究發現，147 位已婚者有 97 位(66%)有離職意圖，274 位未婚者有 211 位(77%)有離職意圖，婚姻狀

況在離職意圖上有顯著差異，相較於已婚者，未婚護理人員有較高離職傾向（陳國珣等人，2006）。而在目前任職醫院的護理年資為 5-10 年的護理人員離職意圖顯著高於其他護理年資的護理人員的部分，與有的研究，年資較長者，相較於新進護理人員之離職傾向來的低（陳國珣等人，2006）略有些許不同，推論其原因可能為，護理年資為 5 年以下資淺者，職業生涯尚在成長學習和期望累積經驗及年資階段，護理年資大於 10 年資深者，職業生涯已形塑，較期望工作穩定，而護理年資為 5-10 年的護理人員，其職業生涯尚處於探索階段，工作負荷壓力較護理年資為 5 年以下的護理人員高，得到的社會支持卻較護理年資為 5 年以下的護理人員少，因而離職意圖較高，Karasek（1979）指出，成員若能感受到社會支持，將降低壓力的發生。在工作負荷越重，離職意圖較高的部分，護理人員離職時最不滿意的是工作負荷（施采吟和翁偉楷，2020；張靖梅和林獻鋒，2021）。在工作的情感性或持續性承諾越高，離職意圖越低的部分，黃穗芬等人（2011）研究發現，護理人員的情感性組織承諾不是影響離職傾向最主要的因素，持續性組織承諾才是重要因素；由於該研究收集資料階段正逢大環境不景氣，因此護理人員基於考量離開組織的成本損失，越認為離開機構會有損自身利益或就業機會者，則越沒有離職傾向。

（三）本研究發現在地區型醫療機構中的護理人員感受到主管支持的程度越高，在支持性執業環境、專業自主與發展、主管的領導風格方面的工作滿意度越高，產生的情感性和持續性承諾越高，離職意圖越低，此結果與其他研究結果相似，組織承諾與工作滿意度有顯著的正相關（牛美雲，2005；洪淑芬，2014；陳怡伶，2016；黃珊和王秀紅，2008），陳怡光等人（2013）研究發現，主管的支持能提升員工的工作滿意度，主管支持會透過工作滿意的中介效果影響組織承諾，工作滿意度正向影響組織承諾，影響程度多寡依序為情感性承諾、持續性承諾和規範性承諾，蔡月英等人（2020）的研究指出，員工知覺到從組織中獲得高度支持時，會提高工作滿意度，增加對醫院的依附關係和義務感，並對組織回應予組織承諾的行為展現，張翠芬等人（2016）以中部六家地區及四家區域醫院的 193 位護理人員為對象，研究結果顯示離職意圖與所有工作滿意度類別（工作酬勞、工作環境、自我肯定、醫院管理制度、本質學能）均呈顯著負相關，黃穗芬（2011）針對護理人員的研究發現，護理人員工作壓力並不是影響離職傾向的主要因素，工作滿意度和組織承諾才是重要因素。

（四）本研究發現在地區型醫療機構中的護理人員組織承諾對離職意圖的直接影響效果高於其他變項（組織承諾越高，離職意圖越低）。工作壓力（工作負荷—控制—支持）主要均是透過先影響工作滿意度，接著再影響組織承諾的序列性間接中介效果路徑影響離職意圖，與 Bluedorn（1982）的綜合離職模式的提到的工作滿意和組織承諾是三大類前置變項和離職的過程中具有影響的中介變項結果一致。另外，值得注意的是，護理人員工作控制對離職意圖具直接效果，由於直接效果係數為正，表示當排除專業自主與發展滿意、組織承諾的影響力後，

工作控制感較高者，其離職意圖反而較高，推論其原因可能為，工作控制感較高的護理人員，對工作的專業自主性、成就感、主管和同事的認同與肯定感的需求及薪資福利、升遷的期待也較高，地區醫院因為規模較小，薪資福利和升遷機會較醫學中心和區域醫院為少，當護理人員工作控制感的提升未能帶來專業自主、人際支持與職涯發展上的滿意進而產生組織承諾時，護理人員反而傾向選擇離職，陳怡光等人（2013）研究指出，醫院員工在工作期間，對於工作相關決定的自主權和專業技能及直屬主管的支持與協助，均會對工作滿意度造成影響。

第三節 建議

根據前面兩節的研究結果與討論提出以下建議

一、護理人力資源管理策略之建議

地區醫院雖然因為規模較小而有其劣勢，在軟、硬體措施和設備（薪資福利、升遷機會、資訊化程度）上較醫學中心及區域醫院為不足及侷限，基於設置標準和經營維持不易的成本考量下，護理人力配置較少、護病比例較高、護理人員分工較不清楚需身兼數職等，形成護理人員的工作負荷壓力，然而本研究結果顯示，地區醫院護理人員在知覺社會支持的程度高過知覺工作負荷及工作控制的程度，且人際互動與主管領導的滿意度及情感性組織承諾較高，離職意圖屬中度偏低，由此可見，地區醫院優勢在於組織管理上層級劃分較少，但管理制度較有彈性，組織氛圍富人情味和溫度，主管與組織成員較熟識且親近，主管和護理人員及護理人員和同事間的緊密互動合作過程，所產生的深厚社會支持情誼（尤其是主管支持部分），反而是地區醫院可以善加運用的寶貴資源，建議地區醫院的管理者可以強化主管在人際溝通協調與人員激勵方面的管理能力，另外，除了新進或資淺人員需要主管提供支持和關懷，對於年資為 5-10 年或 10 年以上者，雖然其工作控制能力和獨立性較高，但是面對的工作負荷壓力也隨之較多，需適時主動給予關心和支持。

本研究顯示護理人員工作壓力（工作負荷－控制－支持）主要均是透過先影響工作滿意度，接著再影響組織承諾的序列性間接中介效果路徑影響離職意圖，其中組織承諾對離職意圖的直接影響效果高於其他變項，且情感性及持續性承諾對離職意圖具獨特解釋力，因此，建議地區醫院的管理者重視護理人員組織承諾的強化，可藉由提供具公平性及符合現況所需的薪資福利制度、工作相關獎勵措施和內部晉升的機會，以及讓護理人員能從工作中獲得成就感、擁有工作執行的自主性、參與決策和自我表達的機會，例如：（一）辦理全院或是單位內的在職教育訓練課程，除了邀請院外講師授課，也可以培養院內各單位資深護理人員擔任講師授課，使其發揮個人專長得到主管、同事甚至自我的認同及肯定，並鼓勵

護理人員參與各種專業研討會，支持護理人員在職進修或取得工作所需相關專業證照，以提升個人專業成長，獲得成就感。(二)主管能夠真心關懷和傾聽、採取開放性的溝通管道，鼓勵護理人員主動表達意見和感受，並將資訊透明化，讓資訊藉由會議或書面的方式公開且正確的傳達，透過團體討論讓護理人員有參與決策、表達想法和選擇的機會。(三)主管須能夠肯定及尊重每位護理人員不同的特質、個性及學習能力，適性適任的安排和討論個別化的學習進度、工作複雜度及訂定工作目標(太難的目標容易產生挫折感，太簡單的目标則缺乏挑戰性)，藉此強化護理人員對工作的控制感和自主性，並能適度賦權，信任及鼓勵護理人員擔任某項業務或計劃主責人員，學習規劃流程和相關事宜的彙整處理、與他人的溝通協調，經由和單位主管討論後施行，主管從旁給予建議、支持和協助但不過度主導和干涉，人員在這個過程中的學習和成長可以增加對工作的責任感，感受到主管或同事的認同與肯定，而工作上的自主性可提升成就感和自我認可、自我實現，催化護理人員產生自我內在激勵效果，同時主管若能適時輔以外在實質的獎勵做為激勵措施，將更能達到強化內在激勵的效果，藉由提升工作滿意度進而產生情感性組織承諾，以增加組織認同感、情感的依附及向心力而減少離職意圖。

二、 未來研究之建議

(一) 因為本研究以某醫療體系所屬之地區醫院護理人員為主要研究對象，故研究結果的推論運用至其他層級之醫療院，將有所限制。

(二) 本研究主要是探討護理人員工作壓力與離職意圖關係中之工作滿意度及組織承諾之序列中介效果，故未進一步將組織承諾分成情感性、持續性、和規範性作個別性探討，後續研究可針對組織承諾這部分做進一步的探討。

(三) 在滿意度的主管的領導風格和專業自主與發展這部份，後續研究可以進一步探討是否跟主管運用的領導方式或是個人本身的內在特質有相關。

參考文獻

- 牛美雲 (2005)。護理人員工作滿意度，組織承諾及留任意願之調查研究---以宜蘭縣護理人員為例。〔未出版碩士論文〕臺灣大學。
<https://doi.org/10.6342/NTU.2005.01634>
- 中華民國護理師護士公會全國聯合會 (2021)。109 年護理人力監測指標資料。<https://www.nurse.org.tw/filecenter/B/8D8B93C0BFD7056077/109%e5%b9%b4%e8%ad%b7%e7%90%86%e4%ba%ba%e5%8a%9b%e7%9b%a3%e6%b8%ac%e6%8c%87%e6%a8%99-0404%e6%9b%b4%e6%96%b0%e7%89%88.pdf>
- 王金蓮、邱淑媿、簡莉盈、黃心苑 (2018)。探討台灣臨床護理人員工作待遇滿意度與離職及轉業意念之相關因素。**澄清醫護管理雜誌**，14 (2)，27-39。
<https://www.airitilibrary.com/Publication/alDetailedMesh?DocID=18136702-201804-201804030010-201804030010-27-39>
- 王郁智、章淑娟、朱正一 (2006)。升遷機會、社會支持、工作滿意度與留任意願之相關性研究。**志為護理-慈濟護理雜誌**，5 (4)，90-101。
<https://doi.org/10.6974/tcnj.200608.0090>
- 王雪鳳、楊豐華、羅月英、楊慧滿 (2016)。護理人員酬勞公平，工作滿足及離職意圖相關因素之探討。**弘光學報**，(78)，203-221。
<https://doi.org/10.6615/HAR.201609.78.14>
- 王靜琳、呂桂雲、黃瓊玉、何美瑤 (2008)。護理人員專業承諾及其相關因素之探討。**長庚護理**，19，P334-345。[https://doi.org/10.6386/CGN.200809_19\(3\).0004](https://doi.org/10.6386/CGN.200809_19(3).0004)
- 王靜琳、蔡來蔭、呂桂雲 (2005)。專業承諾之概念分析。**護理雜誌**，52 (5)，71-77。<https://doi.org/10.6224/JN.52.5.71>
- 成亮、杜佩蘭、張肇松、黃英忠 (2008)。照顧 SARS 病患之護理人員其組織承諾和工作投入對離職傾向的影響。**醫務管理期刊**，9 (4)，271-285。
[https://doi.org/10.6174/jhm2008.9\(4\).271](https://doi.org/10.6174/jhm2008.9(4).271)
- 何慧菁、張淑惠、曹瑞雲、張梅芳、陳永煌、楊燦 (2010)。醫院員工工作壓力與身心健康之相關研究。**中華職業醫學雜誌**，17 (4)，239-252。
<https://doi.org/10.30027/CJOM.201010.0002>
- 吳玲珠、馬素華、鍾蝶起、黃桂香、謝明珠、陳瓊華 (2014)。某區域醫院護理人員專業自主性與工作滿意度及其相關影響因素之初探。**護理雜誌**，61 (5)，54-65。<https://doi.org/10.6224/JN.61.5.54>
- 吳美珠、陳亞玲、莊玉仙、邱玉萍、吳靜華、蔡麗君、李慧咪、林淑婷、黃淑儀 (2018)。專科護理師工作壓力，職場疲勞與工作滿意度之相關性探討。**安泰醫護雜誌**，24 (1)，1-13。
<https://www.airitilibrary.com/Publication/alDetailedMesh?DocID=18111955-201806-201807120011-201807120011-1-13>

- 沈昭吟、詹昆霖 (2013)。傳統產業員工之逆境商數對工作壓力、組織承諾與離職意圖之相關研究。**朝陽商管評論**，**12** (1)，33-63。
<http://nhuir.nhu.edu.tw/handle/987654321/25358>
- 林谷峻、高靖秋、鄭文凱 (2009)。護理人力資本與離職率之關聯性。**會計學報**，**1** (2)，93-127。<http://www.acc.scu.edu.tw/sjoa/file/V001N2-4.pdf>
- 林采怡、林弘昌 (2019)。探討臨床護理人員的工作壓力，自我效能對工作滿意度之影響。**科技與人力教育季刊**，**5** (4)，92-116。
https://www.tahrd.ntnu.edu.tw/wp-content/uploads/2020/10/%E7%AC%AC5%E5%8D%B7%E7%AC%AC4%E6%9C%9F_%EF%BC%88%E5%85%A8%EF%BC%89.pdf#page=93
- 林俊傑 (2007)。組織承諾的理論與相關研究之探討。**學校行政** (51)，35-53。
<https://doi.org/10.6423/hhhc.200709.0035>
- 林素鈺、侯東旭、趙正敏 (2020)。那些因素決定了護理人員留任意願？醫院社會責任與心理契約觀點。**醫務管理期刊**，**21** (3)，161-180。
[https://doi.org/10.6174/JHM.202009_21\(3\).161](https://doi.org/10.6174/JHM.202009_21(3).161)
- 林瑜雯、莊子萱、劉曦宸、陳韻柔、陳富莉 (2011)。從醫療職場工作特質探討醫院護理長與臨床護理人員之工作壓力源。**台灣公共衛生雜誌**，**30** (3)，245-256。
https://www.researchgate.net/profile/Fu-Li-Chen/publication/290169783_Exploring_job_stressors_for_head_nurses_and_clinical_nurses_from_the_perspective_of_their_job_characteristics/links/574d1c0908aacc988526a2a4e/Exploring-job-stressors-for-head-nurses-and-clinical-nurses-from-the-perspective-of-their-job-characteristics.pdf
- 林靖瑛 (2016)。部門別五大人格特質，組織承諾對減少護理人員離職意圖之研究。[未出版博士論文]。臺北大學。
<https://www.airitilibrary.com/Publication/alDetailedMesh1?DocID=U0023-1303201714243377>
- 林碧莉、何美瑤、曾麗琦、呂桂雲 (2005)。衛生所護理人員工作壓力與專業承諾之研究。**實證護理**，**1**，132-139。<https://doi.org/10.6225/JEBN.1.2.132>
- 侯望倫 (1984)。工作壓力的實證研究：組織氣候，角色特性，人格特質與壓力症狀的關係。**管理評論**，**3** (3)，38-46。
<https://doi.org/10.6656/MR.1984.3.3.CHI.38>
- 施采吟、翁偉楷 (2020)。降低三個月內新進護理人員離職率。**源遠護理**，**14** (3)，57-64。[https://doi.org/10.6530/YYN.202011_14\(3\).0007](https://doi.org/10.6530/YYN.202011_14(3).0007)
- 洪秀玟、丘文斌 (2013)。工作壓力，社會支持與自覺健康狀況：南部地區醫療機構基層人力之實證研究。**實建醫護與管理雜誌**，**11** (2)，20-29。
<https://www.airitilibrary.com/Publication/alDetailedMesh?DocID=16830806-201312-201405220026-201405220026-20-29>

- 洪淑芬 (2014)。**護理人員工作壓力、工作滿意度、組織承諾與離職傾向之相關性研究**。〔未出版碩士論文〕。國立成功大學。<https://hdl.handle.net/11296/hnfv22>
- 胡玉英、李碧霞、張媚、孫吉珍 (2007)。**護理人員的激勵與工作滿意度相關性研究**。**長庚護理**, 18(3), 341-351。[https://doi.org/10.6386/cgn.20070918\(3\).0004](https://doi.org/10.6386/cgn.20070918(3).0004)
- 胡怡君、林碧珠、張育愷、侯文萱、郭淑瑜、林妍妙、董道興、陳淑如 (2019)。**臨床護理主管工作倦怠與工作壓力，工作-家庭衝突之相關性探討**。**新臺護理期刊**, 21(2), 27-38。[https://doi.org/10.6540/NTJN.201909_21\(2\).0003](https://doi.org/10.6540/NTJN.201909_21(2).0003)
- 胡家綺 (2017)。**護理人員工作壓力與工作滿意度之研究-衛生福利部臺東醫院為例**。〔未出版碩士論文〕。國立臺東大學 <https://hdl.handle.net/11296/bffu9w>
- 孫佩娟 (2019)。**台北市護理人員工作壓力，休閒阻礙與離職傾向之關聯性研究**。〔未出版碩士論文〕。中國文化大學。
<http://ir.lib.pccu.edu.tw/handle/987654321/44862>
- 高旭繁、陸洛 (2011)。**工作壓力及其後果的組群差異：以 OSI 模式為理論基礎之大樣本分析**。**臺大管理論叢**, 22(1), 239-272。
http://ntur.lib.ntu.edu.tw/bitstream/246246/284299/1/2201_201112_8.pdf
- 高鳳霞、鄭伯璫 (2014)。**職場工作壓力：回顧與展望**。**人力資源管理學報**, 14(1), 77-101。<https://doi.org/10.6147/JHRM.2014.1401.04>
- 張火燦、紀乃文 (2006)。**護理人員組織承諾與專業承諾多元構面交互作用對離職傾向與離業傾向的影響：離職傾向與離業傾向的中介效果**。**人力資源管理學報**, 6(2), 111-133。<https://doi.org/10.6147/JHRM.2006.0602.06>
- 張松齡、羅淑芬、王文秀、賴美滿、張秀香、賴彩霞 (2003)。**東部地區精神科護理人員工作壓力，因應行為及其相關因素之探討**。**志為護理-慈濟護理雜誌**, 2(3), 59-69。<https://doi.org/10.6974/TCNJ.200309.0059>
- 張春興 (1991)。**現代心理學**。東華書局。
- 張春興 (2006)。**張氏心理學辭典**。東華書局。
- 張偉斌、何政勳、溫信財、林玉珊 (2020)。**公共衛生護理人員工作壓力，主管支持與工作滿意之相關性**。**北市醫學雜誌**, 17(4), 412-424。
[https://doi.org/10.6200/TCMJ.202012_17\(4\).0006](https://doi.org/10.6200/TCMJ.202012_17(4).0006)
- 張景星 (2021)。**日間型社區精神復健機構專任管理員工作壓力，工作滿意度與離職傾向關係之研究**。〔未出版碩士論文〕。屏東大學。
<https://search.ebscohost.com.ezproxy.nptu.edu.tw/login.aspx?direct=true&db=catt08282a&AN=npul.1030488&lang=zh-tw&site=eds-live>
- 張瑋佳、劉美雯 (2013)。**護理職場壓力源與因應量表編製與效度檢驗**。2013 健康與管理學術研討會，新竹：台灣。
<http://ir.lib.ypu.edu.tw/ir/bitstream/310904600Q/8804/2/OD-003.pdf>
- 張靖梅、林獻鋒 (2021)。**護理人員離職行為影響因素及工作負荷之探究**。**長庚護理**, 32(1), 18-31。[https://doi.org/10.6386/cgn.202103_32\(1\).0002](https://doi.org/10.6386/cgn.202103_32(1).0002)

- 張翠芬、陳重光、陳敏加 (2016)。不同類型醫院護理人員特質，工作壓力，工作滿意度與離職傾向之相關性研究—以六家地區醫院及四家區域醫院為例。**澄清醫護管理雜誌**，**12** (2)，28-38。
<https://www.airitilibrary.com/Publication/alDetailedMesh?DocID=18136702-201604-201604110032-201604110032-28-38>
- 張翠芬、趙正敏、詹麗珠 (2020)。護理人員主管領導行為，人格特質對離職意圖之影響：以工作壓力為中介變項。**醫務管理期刊**，**21** (3)，238-257。
[https://doi.org/10.6174/JHM.202009_21\(3\).238](https://doi.org/10.6174/JHM.202009_21(3).238)
- 張曉立 (2021)。地區醫院護理人員工作壓力、工作倦怠相關因素探討。〔未出版碩士論文〕。美和科技大學。<https://hdl.handle.net/11296/ta242h>
- 張薰榕、史麗珠、邱孟君、沈昱名、林雪蓉 (2012)。台灣健保總額預算期間臨床護理人員的工作感受及工作壓力。**中華職業醫學雜誌**，**19** (1)，15-27。
<https://doi.org/10.30027/CJOM.201201.0003>
- 莊于瑄 (2020)。護理人員工作壓力與工作倦怠對離職傾向影響之研究—以人格特質為調節變項。〔未出版碩士論文〕。銘傳大學。
<https://hdl.handle.net/11296/k3b746>
- 莊蕙琿、楊順富 (2011)。護理人員職業倦怠與組織承諾相關之研究：以中部區域教學醫院為例。**澄清醫護管理雜誌**，**7** (2)，51-60。
<https://doi.org/10.30156/CCMJ.201104.0006>
- 郭玉琦 (2019)。某區域教學醫院護理人員工作壓力與職場疲潰相關因素探討。〔未出版碩士論文〕。美和科技大學。<https://hdl.handle.net/11296/6h22wq>
- 陳小芳 (2012)。護理人員工作輪調、工作壓力與組織承諾相關性探討—以南部某區域教學醫院為例。〔未出版碩士論文〕。長榮大學。
<https://doi.org/10.6833/CJCU.2012.00064>
- 陳仙媚 (2013)。心理契約、組織承諾對護理人員離職意圖之影響—以雲林某區域教學醫院為例。〔未出版碩士論文〕。國立雲林科技大學。
<https://hdl.handle.net/11296/j425b4>
- 陳自立 (2005)。地區醫院護理人員工作滿意及離職傾向之關聯分析。〔未出版碩士論文〕。義守大學。<http://ir.lib.isu.edu.tw/handle/987654321/3807>
- 陳宣傳 (2015)。臺灣不同科別之臨床護理人員其工作壓力源與心理健康探討。〔未出版碩士論文〕。台灣大學。<https://doi.org/10.6342/NTU.2015.00935>
- 陳怡光、張端訓、邱瓊萱、魏中仁 (2013)。工作控制、工作壓力及社會支持對員工的工作滿意度及組織承諾的影響。**輔仁醫學期刊**，**11** (3)，187-196。
<https://www.airitilibrary.com/Publication/alDetailedMesh?DocID=18102093-201309-201310220003-201310220003-187-196>
- 陳怡伶 (2016)。內外控人格特質、情緒勞動與工作滿意度對組織承諾：以網路世代護理人員為例。〔未出版碩士論文〕。南臺科技大學。
<https://hdl.handle.net/11296/ys7nnq>

- 陳欣妤 (2021)。國小專任輔導教師工作壓力、工作滿意度、職業承諾及離職意圖關係之研究。〔未出版碩士論文〕。國立屏東大學。
<https://hdl.handle.net/11296/kqyjss>
- 陳國珣、陳麗如、蘇喜 (2006)。護理人員對護理工作認知與離職傾向之探討。**台灣公共衛生雜誌**，**25** (3)，177-188。
<http://ntur.lib.ntu.edu.tw/bitstream/246246/161266/1/30.pdf>
- 陳梅麗、林小玲、連金延、余先敏、蔡欣玲 (2000)。醫學中心護理人員工作壓力，離職意願與離職行為之相關性研究。**榮總護理**，**17** (3)，260-269。
<https://doi.org/10.6142/VGHN.17.3.260>
- 陳銘薰、黃新龍 (2019)。工作壓力、幸福感、組織承諾與離職傾向關聯之研究——以國軍軍士官為例。**商管科技季刊**，**20** (2)，157-179。
<http://www.cabmt.org.tw/uploads/upload/f47eb7463ee80db48f8f9c4950b126da.pdf>
- 陸柏憲 (2019)。工作壓力與工作滿意度對離職傾向關係之驗證性研究——以日月光半導體高雄廠產線人員為例。〔未出版碩士論文〕。樹德科技大學。
<https://hdl.handle.net/11296/t84jr5>
- 陸雅美 (2006)。內外科病房新進護理人員工作壓力與離職傾向之相關性研究。〔未出版碩士論文〕。長榮大學。<https://doi.org/10.6833/CJCU.2006.00084>
- 彭士哲、曾淑萍 (2021)。矯正人員組織承諾之初探。**矯政期刊**，**10** (1)，36-63。
[https://doi.org/10.6905/jc.202101_10\(1\).0002](https://doi.org/10.6905/jc.202101_10(1).0002)
- 曾雯琦、林秋芬、林麗英、盧美秀、蔣立琦 (2017)。發展臺灣醫院護理師工作滿意度量表與信效度檢測。**護理雜誌**，**64** (2)，44-54。
https://www.researchgate.net/profile/Wen-Chii-Tzeng/publication/316250537_Development_and_Testing_of_the_Taiwanese_Hospital_Nurses'_Job_Satisfaction_Scale/links/5f533c07a6fdcc9879cdd488/Development-and-Testing-of-the-Taiwanese-Hospital-Nurses-Job-Satisfaction-Scale.pdf
- 曾慧萍、鄭雅文 (2002)。〔負荷-控制-支持〕與〔付出-回饋失衡〕工作壓力模型中文版量表之信效度檢驗：以電子產業員工為研究對象。**台灣公共衛生雜誌**，**21** (6)，420-432。<https://doi.org/10.6288/TJPH2002-21-06-05>
- 湯心怡 (2019)。護理人員共享決策態度、工作滿意度及教育訓練需求之探討。〔未出版碩士論文〕。國立臺北護理健康大學。<https://hdl.handle.net/11296/jt65qz>
- 馮明珠、武香君、林慧姿、雷蕾、趙嘉玲、陸椿梅、楊婉萍 (2020)。面對全球新冠肺炎爆發台灣護理人員之壓力，心理困擾與緩解方式探討。**護理雜誌**，**67** (3)，64-74。[https://doi.org/10.6224/JN.202006_67\(3\).09](https://doi.org/10.6224/JN.202006_67(3).09)

- 黃玉琳 (2019)。護理人員工作壓力、工作倦怠對離職傾向影響效果之探討。〔未出版碩士論文〕。龍華科技大學。<https://hdl.handle.net/11296/b8an2y>
- 黃昆輝(2000)。工作滿意。教育大辭書。[Online]. Available:<http://terms.naer.edu.tw/detail/1302183/> (2021-05-28)
- 黃珊、王秀紅 (2008)。臨床護理人員組織承諾與工作滿足感之相關性探討。長庚護理，19 (4)，472-481。[https://doi.org/10.6386/CGN.200812_19\(4\).0005](https://doi.org/10.6386/CGN.200812_19(4).0005)
- 黃若飴、王俊明、楊智玲 (2017)。不同醫院層級的護理人員在工作壓力及身心健康之研究。南開學報，14 (2)，1-10。
<http://libap.nhu.edu.tw:8081/Ejournal/AO01140201.pdf>
- 黃毓華，黃英忠，陳錦輝，杜佩蘭 (2015)。護理人員之社會心理工作特性、工作倦怠與身心健康相互影響—固定樣本追蹤研究。台灣公共衛生雜誌，34 (2)，204-217。<https://doi.org/10.6288/tjph201534103090>
- 黃瑞珍、黃珊、林麗滿、孫愛德 (2001)。手術室護理人員工作壓力情形及其相關因素之探討。長庚護理，12 (1)，1-11。
<https://www.airitilibrary.com/Publication/alDetailedMesh?DocID=10267301-200103-12-1-1-11-a>
- 黃慧文 (2017)。某區域教學醫院護理人員離職意向之相關因素。台灣醫學，21 (4)，335-342。[https://doi.org/10.6320/fjm.2017.21\(4\).1](https://doi.org/10.6320/fjm.2017.21(4).1)
- 黃穗芬、林靜娟、宋琇鈺、陳鳳櫻 (2011)。護理人員工作壓力，工作滿意度，組織承諾和離職傾向關係的探討。弘光學報 (63)，25-34。
<https://doi.org/10.6615/har.201106.63.03>
- 黃鴻茗、宋鎮照 (2013)。台灣地區醫院的消逝對社區醫療安全網絡的影響。台灣社區工作與社區研究學刊，3 (1)，1-22。<http://www.tacws.org/zh-TW/practices/download/journals31/030101.pdf>
- 楊育淇、戴明蓉、曾惠欣、林姵婷、黃毓萱、劉畊伶、彭雅雯、陳耀豐、孫嘉玲、陳佩英 (2018)。內科病房護理人員之工作壓力程度探討。2018 生命教育暨健康管理國際學術研討會，新竹市：台灣。
<http://120.106.195.12/handle/310904600Q/16892>
- 楊麗清 (2016)。臺灣不同層級醫院之臨床護理人員其工作壓力源及心理健康之探討。〔未出版碩士論文〕。國立臺灣大學。
<https://doi.org/10.6342/NTU201601341>
- 葉婉榆、鄭雅文、陳美如、邱文祥 (2008)。職場疲勞量表的編製與信效度分析。台灣衛誌，27，349-364。
https://www.researchgate.net/profile/Yawen-Cheng-4/publication/289703254_Development_and_validation_of_an_occupational_burnout_inventory/links/5ccd2f5c458515712e903c34/Development-and-validation-of-an-occupational-burnout-inventory.pdf

解旻容、郭玉珍、鄭青展、胡秀媛 (2013)。護理人員工作滿足感，專業承諾及組織承諾之相關性探討。**領導護理**，14 (2)，22-32。

[https://doi.org/10.29494/LN.201306_14\(2\).0003](https://doi.org/10.29494/LN.201306_14(2).0003)

蕭淑銖、胡佩怡 (2015)。我國護理人員心理健康調查與預防策略。勞動部勞動及職業安全衛生研究所。

https://laborelearning.mol.gov.tw/base/10001/door/%E5%A0%B1%E5%91%8A%E5%8D%80/842_ILOSH103R328%E6%88%91%E5%9C%8B%E8%AD%B7%E7%90%86%E4%BA%BA%E5%93%A1%E5%BF%83%E7%90%86%E5%81%A5%E5%BA%B7%E8%AA%BF%E6%9F%A5%E8%88%87%E9%A0%90%E9%98%B2%E7%AD%96%E7%95%A5.pdf

廖茂宏、魏慶國、許玉君、陳嘉珮 (2007)。實施“激勵性薪資”制度後，護理人員對制度的認知程度與工作滿意度，組織承諾的影響—以北部某區域級醫院為例。**健康管理學刊**，5 (2)，117-127。

<https://doi.org/10.29805/JHM.200712.0002>

衛生福利部 (2021)。全國醫療資訊網台閩地區護理人員統計:台閩地區護理人員統計表-110 年 6 月。

<https://www.nurse.org.tw/publicUI/H/H10201.aspx?arg=8D924EFF0ACC862076>

劉素蘭、王曼溪、劉秀華 (2010)。新進護理人員工作壓力源之研究。**榮總護理**，27 (3)，276-284。<https://doi.org/10.6142/vghn.27.3.276>

劉淑如、鄭靜瑜 (2002)。高屏地區護理人員組織承諾之探討。**志為護理—慈濟護理雜誌**，1 (1)，56-65。<https://doi.org/10.6974/TCNJ.200201.0056>

蔡月英、張翠芬、趙正敏 (2020)。知覺組織支持和社會網絡對離職意圖之影響：護理人員心理契約，組織承諾的中介效應。**醫院雜誌**，53 (3)，1-15。

<https://www.airitilibrary.com/Publication/alDetailedMesh?DocID=P20190424001-202009-202010060022-202010060022-1-15>

蔡李玉卿 (2009)。護理人員工作壓力工作滿足組織承諾與離職傾向之相關性研究。〔未出版碩士論文〕。長榮大學。<https://doi.org/10.6833/CJCU.2009.00022>

蔡坤宏 (2000)。組織承諾，工作滿足與離職意圖的關係：Meta 分析。**中華管理評論**，3 (4)，33-49。<http://cmr.ba.ouhk.edu.hk/cmr/oldweb/n13/201023.htm>

蔡政廷、林弘昌 (2018)。影響醫療機構護理人員離職傾向因素之初探—以台灣北區某區域醫院為例。**科技與人力教育季刊**，5 (1)，49-66。

[https://doi.org/10.6587/JTHRE.201809_5\(1\).0003](https://doi.org/10.6587/JTHRE.201809_5(1).0003)

盧玉羸、陳瑞貞、梁淑媛、吳淑芳 (2014)。護理人員之工作壓力與職場疲勞之相關性探討。**護理暨健康照護研究**，10 (4)，276-285。

<https://doi.org/10.6225/JNHR.10.4.276>

- 盧怡孜 (2017)。中部國民中學專任輔導教師工作滿意度與轉任傾向之研究。〔未出版碩士論文〕。國立台中教育大學。 <https://hdl.handle.net/11296/3fdy8n>
- 賴育民、黃雪莉、蔡宗益 (2012)。台灣醫療從業人員憂鬱情緒之相關因素探討。
中華職業醫學雜誌，19 (4)，207-216。
<https://doi.org/10.30027/cjom.201210.0002>
- 錢才瑋、王文中、周銘霆、張志誠 (2012)。以中文版工作內容問卷 (C-JCQ) 評估醫院基層員工之工作壓力。**醫務管理期刊**，13 (2)，79-94。
[https://doi.org/10.6174/jhm2012.13\(2\).79](https://doi.org/10.6174/jhm2012.13(2).79)
- 謝良博、邱華慧、王素美、陳妮婉 (2011)。護理人員工作壓力、慢性頭痛狀況及憂鬱狀態之研究。**澄清醫護管理雜誌**，7 (2)，20-26。
<https://doi.org/10.30156/ccmj.201104.0003>
- 鍾宜芬、陳俞成 (2020)。護理人員人格特質，工作滿意度，留任意願之探討。
醫院雜誌，53 (2)，1-11。
<https://www.airitilibrary.com/Publication/alDetailedMesh?DocID=P20190424001-202006-202007150009-202007150009-1-11>
- 羅文惠、游麗瑾、李金雲、游淑敏 (2021)。護理人員照護嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19) 病人之心理壓力。**北市醫學雜誌**，18 (4)，432-444。
[https://doi.org/10.6200/TCMJ.202112_18\(4\).0007](https://doi.org/10.6200/TCMJ.202112_18(4).0007)
- Al-Aameri, A. S. (2000). Job satisfaction and organizational commitment for nurses. *Saudi Medical journal*, 21(6), 531-535.
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11500699/>
- Allen, N. J., & Meyer, J. P. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization. *Journal of Occupational Psychology*, 63(1), 1-18.
<https://doi.org/10.1111/j.2044-8325.1990.tb00506.x>
- Allen, N. J., & Meyer, J. P. (1996). Affective, continuance, and normative commitment to the organization: An examination of construct validity. *Journal of Vocational Behavior*, 49(3), 252-276. <https://doi.org/10.1006/jvbe.1996.0043>
- Alshmemri, M., Shahwan-Akl, L., & Maude, P. (2017). Herzberg's two-factor theory. *Life Science Journal*, 14(5), 12-16.
https://www.lifesciencesite.com/ljsj/life140517/03_32120lsj140517_12_16.pdf
- Beehr, T. A., & Newman, J. E. (1978). Job stress, employee health, and organizational effectiveness: A facet analysis, model, and literature review 1. *Personnel Psychology*, 31(4), 665-699. <https://psycnet.apa.org/record/1980-26633-001>
- Berberoglu, A. (2018). Impact of organizational climate on organizational commitment and perceived organizational performance: Empirical evidence from public hospitals. *BMC Health Services Research*, 18(1), 1-9.
<https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-018-3149-z>

- Bluedorn, A. C. (1982). A unified model of turnover from organizations. *Human Relations*, 35(2), 135-153.
<https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/001872678203500204>
- Cavanaugh, M. A., Boswell, W. R., Roehling, M. V., & Boudreau, J. W. (2000). An empirical examination of self-reported work stress among US managers. *Journal of Applied Psychology*, 85(1), 65. <https://psycnet.apa.org/record/2000-03754-007>
- Cheng, Y., Luh, W.-M., & Guo, Y.-L. (2003). Reliability and validity of the Chinese version of the job content questionnaire in Taiwanese workers. *International Journal of Behavioral Medicine*, 10(1), 15-30.
<https://researchoutput.ncku.edu.tw/en/publications/reliability-and-validity-of-the-chinese-version-of-the-job-content>
- Clugston, M. (2000). The mediating effects of multidimensional commitment on job satisfaction and intent to leave. *Journal of Organizational Behavior*, 21(4), 477-486.
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/%28SICI%291099-1379%28200006%2921%3A4%3C477%3A%3AAID-JOB25%3E3.0.CO%3B2-7>
- Cooper, C. L., Sloan, S. J., & Williams, S. (1988). *Occupational stress indicator: Management set*. Nfer-Nelson Windsor.
<https://www.scirp.org/%28S%28vtj3fa45qm1ean45vvffcz55%29%29/reference/referencespapers.aspx?referenceid=1288599>
- De Gieter, S., Hofmans, J., & Pepermans, R. (2011). Revisiting the impact of job satisfaction and organizational commitment on nurse turnover intention: An individual differences analysis. *International Journal of Nursing Studies*, 48(12), 1562-1569. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21821254/>
- Dewi, M. K., & Piartrini, P. S. (2021). The role of organizational commitment in mediating the influence of communication and work stress on the turnover intention in private hospitals in West Denpasar. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, 5(1), 68-79.
<https://www.ajhssr.com/wp-content/uploads/2021/01/K215016879.pdf>
- Dilig-Ruiz, A., MacDonald, I., Varin, M. D., Vandyk, A., Graham, I. D., & Squires, J. E. (2018). Job satisfaction among critical care nurses: A systematic review. *International Journal of Nursing Studies*, 88, 123-134.
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30292878/>
- Ferdian, A., Luturlean, B. S., Zhafira, K. D., & Izumi, N. K. (2020). The impact of work stress on turnover intention in Indonesia: Is there a mediation from employee' job satisfaction? *J. Mgt. Mkt. Review* 5(1) 31 – 40.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3551042

- French, J. R. P., & Caplan, R. D. (1972). *Organization stress and strain*. In A. J. Marrow (Ed.), *The failure of success* (pp. 30-66). Amacom.
[https://www.scirp.org/\(S\(351jmbntvnsjt1aadkposzje\)\)/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=683200](https://www.scirp.org/(S(351jmbntvnsjt1aadkposzje))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=683200)
- Hayes, A.F.(2020).The PROCESS macro for SPSS. Retrieved from <http://www.processmacro.org/download.html>
- Herzberg, F. (1968). *One more time: How do you motivate employees* (Vol. 65). Harvard Business Review Press.
https://www.insidemarketing.it/wp-content/uploads/2020/08/one_more_time_-_how_do_you_motivate_employees.pdf
- Husnah, I., & Hasyim, S. (2020). The role of organizational commitment in mediating those influence of work stress and work environment towards turnover intention. *International Journal of Innovative Science And Research Technology*, 5(8), 1295-1304. <https://ijisrt.com/assets/upload/files/IJISRT20AUG725.pdf>
- Johnson, J. V., & Hall, E. M. (1988). Job strain, work place social support, and cardiovascular disease: A cross-sectional study of a random sample of the Swedish working population. *American Journal of Public Health*, 78(10), 1336-1342.
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1349434/>
- Jou, R.-C., Kuo, C.-W., & Tang, M.-L. (2013). A study of job stress and turnover tendency among air traffic controllers: The mediating effects of job satisfaction. *Transportation research part E: logistics and transportation review*, 57, 95-104.
<https://ideas.repec.org/a/eee/transe/v57y2013icp95-104.html>
- Kaplan, M., & Kaplan, A. (2018). The relationship between organizational commitment and work performance: A case of industrial enterprises. *Journal of Economic and Social Development (JESD)*, 5(1), 46-50.
https://www.jesd-online.com/dokumenti/upload/separated/Vol_5_No_1_Paper5.pdf
- Karasek Jr, R. A. (1979). Job demands, job decision latitude, and mental strain: Implications for job redesign. *Administrative Science Quarterly*, 285-308.
<https://www.jstor.org/stable/2392498>
- Karasek, R., Baker, D., Marxer, F., Ahlbom, A., & Theorell, T. (1981). Job decision latitude, job demands, and cardiovascular disease: A prospective study of Swedish men. *American Journal of Public Health*, 71(7), 694-705.
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1619770/>
- Karasek, R. A., & Theorell, T. 1990. *Healthy work, stress, productivity and the reconstruction of working life*. Basic Books.
[https://www.scirp.org/\(S\(351jmbntvnsjt1aadkposzje\)\)/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=1955102](https://www.scirp.org/(S(351jmbntvnsjt1aadkposzje))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=1955102)

- Labrague, L. J., & de Los Santos, J. A. A. (2021). Fear of Covid-19, psychological distress, work satisfaction and turnover intention among frontline nurses. *Journal of Nursing Management*, 29(3), 395-403.
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32985046/>
- Lazarus, R. S. (1993). From psychological stress to the emotions: A history of changing outlooks. *Annual Review of Psychology*, 44(1), 1-22.
<https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.ps.44.020193.000245>
- Lin, Y.-W., Chuang, T.-H., Liu, H.-C., Chen, Y.-J., & Chen, F.-L. (2011). Exploring job stressors for head nurses and clinical nurses from the perspective of their job characteristics. *Taiwan Gong Gong Wei Sheng Za Zhi*, 30(3), 245.
https://www.researchgate.net/publication/290169783_Exploring_job_stressors_for_head_nurses_and_clinical_nurses_from_the_perspective_of_their_job_characteristics
- Lu, L., Tseng, H. J., & Cooper, C. L. (1999). Managerial stress, job satisfaction and health in Taiwan. *Stress Medicine*, 15(1), 53-64.
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/%28SICI%291099-1700%28199901%2915%3A1%3C53%3A%3AAID-SMI790%3E3.0.CO%3B2-7>
- Luz, C. M. D. R., de Paula, S. L., & de Oliveira, L. M. B. (2018). Organizational commitment, job satisfaction and their possible influences on intent to turnover. *Revista de Gestão*, 25(1), 84-101
<https://www.revistas.usp.br/rege/article/view/144416>
- Lyne, K. D., Barrett, P. T., Williams, C., & Coaley, K. (2000). A psychometric evaluation of the occupational stress indicator. *Journal of Occupational and Organizational Psychology*, 73(2), 195-220.
<https://psycnet.apa.org/record/2000-02038-005>
- Meyer, J. P., & Allen, N. J. (1991). A three-component conceptualization of organizational commitment. *Human Resource Management Review*, 1(1), 61-89.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/105348229190011Z>
- Meyer, J. P., Allen, N. J., & Smith, C. A. (1993). Commitment to organizations and occupations: Extension and test of a three-component conceptualization. *Journal of Applied Psychology*, 78(4), 538.
<https://psycnet.apa.org/record/1993-47410-001>
- Mobley, W. H. (1977). Intermediate linkages in the relationship between job satisfaction and employee turnover. *Journal of Applied Psychology*, 62(2), 237-240.
<https://doi.org/10.1037/0021-9010.62.2.237>

- Mobley, W. H., Griffeth, R. W., Hand, H. H., & Meglino, B. M. (1979). Review and conceptual analysis of the employee turnover process. *Psychological Bulletin*, 86(3), 493. <https://psycnet.apa.org/record/1979-29973-001>
- Mobley, W. H., Horner, S. O., & Hollingsworth, A. T. (1978). An evaluation of precursors of hospital employee turnover. *Journal of Applied Psychology*, 63(4), 408. <https://psycnet.apa.org/record/1979-09964-001>
- Mowday, R. T., Steers, R. M., & Porter, L. W. (1979). The measurement of organizational commitment. *Journal of Vocational Behavior*, 14(2), 224-247. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0001879179900721>
- Murphy, L. R. (1995). Managing job stress. *Personnel Review*, 24(1), 41-50. <https://doi.org/10.1108/00483489510079075>
- National Institute for Occupational Safety and Health (1999). Stress at work. www.cdc.gov/niosh/docs/99-101/pdfs/99-101.pdf
- Pearlin, L. I., Menaghan, E. G., Lieberman, M. A., & Mullan, J. T. (1981). The stress process. *Journal of Health And Social Behavior*, 22(4), 337-356. <https://psycnet.apa.org/record/1982-21186-001>
- Penconek, T., Tate, K., Bernardes, A., Lee, S., Micaroni, S. P., Balsanelli, A. P., de Moura, A. A., & Cummings, G. G. (2021). Determinants of nurse manager job satisfaction: A systematic review. *International Journal of Nursing Studies*, 118, 103906. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33765624/>
- Porter, L. W., Steers, R. M., Mowday, R. T., & Boulian, P. V. (1974). Organizational commitment, job satisfaction, and turnover among psychiatric technicians. *Journal of Applied Psychology*, 59(5), 603-609. <https://doi.org/10.1037/h0037335>
- Randall, D. M. (1990). The consequences of organizational commitment: Methodological investigation. *Journal of Organizational Behavior*, 11(5), 361-378. <https://psycnet.apa.org/record/1991-06099-001>
- Rindu, R., Lukman, S., Hardisman, H., Hafizurrachman, M., & Bachtiar, A. (2020). The relationship between transformational leadership, organizational commitment, work stress, and turnover intentions of nurse at Private Hospital in Indonesia. *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*, 8(E), 551-557. <https://oamjms.eu/index.php/mjms/article/view/4425>
- Sari, Y., Yustina, I., & Wahyuni, S. E. (2021). The influence of nurse satisfaction and work stress on turnover intension at Mitra Medika Hospital Medan. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 8(3), 490-494. https://ejmcm.com/article_9406.html
- Seaward, B. L. (2017). *Managing stress*. Jones & Bartlett Learning. https://www.amberton.edu/media/Syllabi/Summer%202022/Graduate/HBD5759_E1.pdf

- Selye, H. (1955). Stress and disease. *Science*, 122(3171), 625-631.
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/13255902/>
- Siegrist, J. (1996). Adverse health effects of high-effort/low-reward conditions. *Journal of Occupational Health Psychology*, 1(1), 27.
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9547031/>
- Steers, R. M. (1977). Antecedents and outcomes of organizational commitment. *Administrative Science Quarterly*, 46-56. <https://psycnet.apa.org/record/1977-28522-001>
- Takase, M. (2010). A concept analysis of turnover intention: Implications for nursing management. *Collegian*, 17(1), 3-12. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20394269/>
- Theorell, T., Karasek, R., & Eneroth, P. (1990). Job strain variations in relation to plasma testosterone fluctuations in working men-a longitudinal study. *Journal of Internal Medicine*, 227(1), 31-36. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2299296/>
- Theorell, T., & Karasek, R. A. (1996). Current issues relating to psychosocial job strain and cardiovascular disease research. *Journal of occupational health psychology*, 1(1), 9–26. <https://doi.org/10.1037//1076-8998.1.1.9>
- Williams, S., & Cooper, C. L. (1998). Measuring occupational stress: Development of the pressure management indicator. *Journal of Occupational Health Psychology*, 3(4), 306. <https://psycnet.apa.org/record/1998-12418-003>
- Yaghoubi, M., Karimi, S., Javadi, M., & Hassanzadeh, A. (2010). A survey on relationship between job stress and three dimensions of organization commitment among nursing managers. *Avicenna Journal of Nursing And Midwifery Care*, 18(1), 5-15. https://nmj.umsha.ac.ir/browse.php?a_id=1069&sid=1&slc_lang=en

附錄

(附錄一)

護理人員工作壓力問卷

辛勞的護理同仁，您好：

首先感謝您百忙中撥冗填答這份學術性研究問卷，由衷的向您致謝。

「護理人力短缺」影響層面甚廣，包括了整體醫療照護品質與病人安全以及醫院的人事成本；因此，了解造成護理人力短缺的原因和研擬解決措施，是各國所重視和探討的議題。本問卷乃在探討護理人員在臨床工作上面臨的工作壓力及其與工作滿意度、組織承諾和離職意圖的關係，期待研究結果提供醫院管理者及單位主管在研擬護理人力資源管理策略之參考，以減少同仁的離職意圖，藉以留住優秀護理人員。

誠摯地邀請您依照實際狀況作答，本問卷取得之資料僅提供本研究分析用，對您所填答的資料不做個別的探討，並對所取得的資料絕對保密，請您放心填答。您的意見將對本研究有莫大的助益，再次感謝您對本研究的協助與幫忙。

敬祝 平安順心

國立屏東大學教育心理與輔導學系

社區諮商與教育碩士在職專班

指導教授：張麗麗博士

研 究 生：梁明慧敬上

Email：karenlmh525@gmail.com

中華民國 年 月

貼心提醒：

本研究以自填問卷為資料蒐集之工具，問卷包括五大部分：

第一部分：個人基本資料

第二部分：工作壓力量表

第三部分：工作滿意度量表

第四部份：組織承諾量表

第五部分：離職意圖量表

請您依序按照題號及實際工作狀況填答。

第一部分 個人基本資料

1. 性別：(1) ☐女 (2) ☐男
2. 年齡：_____歲
3. 教育程度：(1) ☐高職 (2) ☐專科 (3) ☐大學 (4) ☐碩士或以上
4. 婚姻狀況：(1) ☐未婚 (2) ☐已婚 (3) ☐同居 (4) ☐離異或鰥寡
5. 目前任職醫院的護理年資：_____年
6. 目前服務單位類別：
(1) ☐加護病房 (2) ☐急診 (3) ☐一般病房 (4) ☐呼吸照護病房
(5) ☐開刀房 (6) ☐洗腎室 (7) ☐門診 (8) ☐健檢
(9) 其他 (請說明) _____

第二部分 工作壓力量表

請您閱讀完題目後，根據您對每個敘述的同意程度，圈選一個較符合您真實感受的選項。

題 號	題目內容	很			
		不 同 意	不 同 意	同 意	同 意
1	在工作中，我需要學習新的事物。.....	1	2	3	4
2	我的工作內容，很多是重複性的工作。.....	1	2	3	4
3	在工作中，我必須具有創新的想法。.....	1	2	3	4
4	在工作中，很多事我可以自己作主。.....	1	2	3	4
5	我的工作需要高度的技術。.....	1	2	3	4
6	對於如何執行我的工作，我沒有什麼決定權。.....	1	2	3	4
7	我的工作內容是很多元多樣的。.....	1	2	3	4
8	對於工作上發生的事，我的意見具有影響力。.....	1	2	3	4
9	在工作中，我有機會發展自己特殊的才能。.....	1	2	3	4
10	我的工作步調很快。.....	1	2	3	4
11	我的工作很辛苦。.....	1	2	3	4
12	我的工作不會過量。.....	1	2	3	4
13	我有足夠的時間來完成工作。.....	1	2	3	4
14	我的工作需要長時間集中注意力。.....	1	2	3	4
15	我的工作非常忙碌。.....	1	2	3	4

題 號	題目內容	很			
		不 同 意	不 同 意	同 意	同 意
16	我的工作場所有人力不足的現象。.....	1	2	3	4
17	我的工作很耗體力。.....	1	2	3	4
18	我的主管關心部屬的福利。.....	1	2	3	4
19	我的主管會聽取我的意見。.....	1	2	3	4
20	我的主管能協助部屬做事。.....	1	2	3	4
21	主管會組織部屬工作。.....	1	2	3	4
22	我的同事很稱職。.....	1	2	3	4
23	我的同事關心我。.....	1	2	3	4
24	我的同事很友善。.....	1	2	3	4
25	我的同事會幫忙我的工作。.....	1	2	3	4

第三部分 工作滿意度量表

請您閱讀完題目後，根據您對每個敘述的滿意程度，圈選一個較符合您真實感受的選項。

題 號	題目內容	非				
		常 不 滿 意	不 滿 意	普 通	滿 意	非 常 滿 意
1	我對於機構提供的個人防護設施及配備感到.....	1	2	3	4	5
2	我對於各項作業的資訊化感到.....	1	2	3	4	5
3	我對於工作環境的安全性感到.....	1	2	3	4	5
4	我對於機構提供醫療設備的品項及數量感到.....	1	2	3	4	5
5	我對於機構提供病人的照護模式感到.....	1	2	3	4	5
6	我對於機構支持護理人員進修感到.....	1	2	3	4	5

請翻次頁繼續填寫，謝謝！

題 號	題目內容	非 常 不 滿 意					非 常 滿 意				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
7	我對於機構提供的專業訓練感到.....	1	2	3	4	5					
8	我對於服務機構的退休制度感到.....	1	2	3	4	5					
9	我對於職位的升遷機會感到.....	1	2	3	4	5					
10	我對於現有的薪資報酬感到.....	1	2	3	4	5					
11	我對於能自我掌握工作的狀況感到.....	1	2	3	4	5					
12	我對於自己處理危機的能力感到.....	1	2	3	4	5					
13	我對於工作的專業自主感到.....	1	2	3	4	5					
14	我對於自己有參與各項重要決策的機會感到.....	1	2	3	4	5					
15	我對於自己的工作能力能獲得同儕的認同與肯定感到.....	1	2	3	4	5					
16	我對於自己的工作能力能獲得主管的認同與肯定感到.....	1	2	3	4	5					
17	我對於能從工作上獲得成就感感到.....	1	2	3	4	5					
18	我對於在工作上能得到學習的機會感到.....	1	2	3	4	5					
19	我對於與其他醫事人員的互動情形感到.....	1	2	3	4	5					
20	我對於與醫師共同合作情形感到.....	1	2	3	4	5					
21	我對於與護理人員共同合作情形感到.....	1	2	3	4	5					
22	我對於與行政人員的互動情形感到.....	1	2	3	4	5					
23	我對於我的工作受到跨團隊成員的相互尊重感到.....	1	2	3	4	5					
24	我對於與護理同儕的互動情形感到.....	1	2	3	4	5					
25	我對於直屬護理主管的支持與關懷感到.....	1	2	3	4	5					
26	我對於直屬護理主管的領導能力感到.....	1	2	3	4	5					
27	我對於直屬護理主管有能力凝聚團隊向心力感到.....	1	2	3	4	5					
28	我對於直屬護理主管能公平與合理的對待感到..... (如：升遷、考核、獎勵及福利等)	1	2	3	4	5					
29	我對於目前非護理專業的工作量感到.....	1	2	3	4	5					
30	我對於目前護理專業的工作量感到.....	1	2	3	4	5					
31	我對於自己承擔目前護理工作的困難度感到.....	1	2	3	4	5					

請翻次頁繼續填寫，謝謝！

第四部份 組織承諾量表

請您閱讀完題目後，根據您對每個敘述的同意程度，圈選一個較符合您真實感受的選項。

題 號	題目內容	非				
		常	不	沒	同	非
		同	同	意	同	同
		意	意	見	意	意
1	我會很高興能在這間醫院渡過日後的職業生涯。.....	1	2	3	4	5
2	我很樂於跟外人談論我工作的醫院。.....	1	2	3	4	5
3	我真的覺得這間醫院的問題就是我自己的問題。.....	1	2	3	4	5
4	我覺得我可以輕易地對其他醫院產生像對目前醫院..... 一般的歸屬感。	1	2	3	4	5
5	我覺得我並非這間醫院大家庭中的一份子。.....	1	2	3	4	5
6	我對這間醫院並沒有情感上的依附。.....	1	2	3	4	5
7	這間醫院對我個人有極大的意義。.....	1	2	3	4	5
8	我對於我們的醫院並沒有強烈的歸屬感。.....	1	2	3	4	5
9	我不害怕如果我辭掉工作會無人遞補。.....	1	2	3	4	5
10	即使我想離開這間醫院，我也很難馬上做到。.....	1	2	3	4	5
11	如果我決定現在就離開醫院，我生活中太多的事情會..... 被打亂。	1	2	3	4	5
12	如果我現在離開醫院，也不會有太多的損失。.....	1	2	3	4	5
13	目前留在這間醫院上班，對我而言是一種必要也是需要。...	1	2	3	4	5
14	我覺得我沒有太多的選擇可以考慮離開這間醫院。.....	1	2	3	4	5
15	離開這間醫院的嚴重後果之一是其它工作的選擇太少。..	1	2	3	4	5
16	我繼續留在這間醫院的一個主要原因是，離開需要付出.. 相當大的個人犧牲，另一間醫院可能無法提供我相同的 福利。	1	2	3	4	5
17	我覺得現在的人太常更換工作的醫院。.....	1	2	3	4	5
18	我不認為人們必須對於自己工作的醫院一直保持忠誠。..	1	2	3	4	5
19	我不覺得轉換醫院是件不道德的事。.....	1	2	3	4	5
20	繼續留在這間醫院的一個主要原因是，我相信忠誠..... 很重要，所以覺得有道德上的義務待下來。	1	2	3	4	5

請翻次頁繼續填寫，謝謝！

題 號	題目內容	非 常 不 同 意					非 常 沒 同 意				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
21	就算我得到另一份更好的工作，我也不覺得離開現在..... 的醫院是正確的。	1	2	3	4	5					
22	我曾被教導要對一間醫院維持忠誠度。.....	1	2	3	4	5					
23	如果人們職業生涯都只待在同一家醫院，那麼一切將..... 會變得更美好。	1	2	3	4	5					
24	我認為對雇主忠誠不再是一項明智的抉擇。.....	1	2	3	4	5					

第五部分 離職意圖量表

您閱讀完題目後，根據您對每個敘述的同意程度，圈選一個較符合您真實感受的選項。

題 號	題目內容	非 常 不 同 意					非 常 沒 同 意				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	如果我現在離職，以我目前的年齡和專業技能..... ，我在其他醫院很容易找到合適的工作。	1	2	3	4	5					
2	我時常考慮要離開這家醫院。.....	1	2	3	4	5					
3	過去一年我有去尋找其它工作。.....	1	2	3	4	5					
4	在未來的一年內我不會辭去目前的工作。.....	1	2	3	4	5					

～問卷到此結束，再次由衷的感謝您的撥冗與耐心填答～

（附錄二）

問卷授權同意書（John Meyer）

Request for permission to use “The Organizational Commitment Scales” 論文 x



梁karen

1月5日 週三 下午3:15



Dear Dr. Meyer, My name is Ming Hui Liang. I am a graduate student in the Department of Educational Psychology and Counseling, National Pingtung University, Tai

John Peter Meyer <meyer@uwo.ca>

1月5日 週三 晚上7:28



寄给我

英文 中文（繁體） 翻譯郵件

關閉下列語言的翻譯功能：英文 x

Hello,

Thank you for your interest in using the Three-Component Model (TCM) Employee Commitment Survey in your research. You can get information about the measure, a Users' Guide, and the measure itself at:

<http://employeecommitment.com/>

For academic / research purposes, please choose the Academic Package. (There is no charge for this package.)

I wish you well with your research!

Best regards,
John Meyer

問卷授權同意書（曾雯琦）

申請使用「醫院護理師工作滿意度量表」使用 109研究所 x 論文 x



梁karen

1月11日 週二 上午10:01

蔣立琦 教授 您好：我叫梁明慧。我是國立屏東大學教育心理與輔導學系的研究生。我正在寫我的碩士論文，題目是「護理人員工作壓力、工作滿意度、組織承諾與離職意向關係之研究」，..

曾雯琦 <wctzeng@mail.ndmctsg.edu.tw>

1月11日 週二 上午11:31



寄给我

明慧, 平安

歡迎使用本份量表

本量表是一個公開量表, 請上護理師全聯會下載, 並於日後適切引用,

網址: <https://www.nurse.org.tw/public/UI/H/H10301.aspx?arg=8D5367B8D244251053>

曾雯琦

Wen-Chii Tzeng, RN, PhD
Professor
School of Nursing
National Defense Medical Center
Taiwan